

Bunga Rampai

ASUHAN KEBIDANAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI

Pada Calon Pengantin

Marchatus Soleha • Hasriani • Wita Solama • Zuliyana
Henri Angraini • Yollanda Dwi Santi Violentina
Rikhly Faradisy Mursyida

Editor: Idawati



BUNGA RAMPAI

ASUHAN KEBIDANAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN

Penulis:

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.

Bd. St. Hasriani, S.Tr.Keb., M.Keb.

Wita Solama, SST., M.Kes.

Bdn. Zuliyana, SST., M.Keb.

Heni Angraini, S.Tr.Keb., M.Keb.

Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb.

Rikhly Faradisy Mursyida, S.ST., M.Kes.

Editor:

Dr. Idawati, S.ST., M.K.M., C.Ed.



Bunga Rampai Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi pada Calon Pengantin

Penulis:

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.
Bd. St. Hasriani, S.Tr.Keb., M.Keb.
Wita Solama, SST., M.Kes.
Bdn. Zuliyana, SST., M.Keb.
Heni Angraini, S.Tr.Keb., M.Keb.
Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb.
Rikhly Faradisy Mursyida, S.ST., M.Kes.

Editor: Dr. Idawati, S.ST., M.K.M., C.Ed.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-16-9

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul "Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi pada Calon Pengantin." Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam mendukung peningkatan kesehatan reproduksi dan kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan dan kehamilan. Masa pranikah dan prakonsepsi merupakan periode penting dalam mempersiapkan kondisi fisik, mental, sosial, dan reproduksi calon pengantin agar mampu mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi proses kehamilan serta pengasuhan anak secara optimal.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penilaian risiko, intervensi, hak reproduksi dan seksual, serta pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Pembahasan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan, status gizi, anemia, kesiapan sebelum kehamilan, imunisasi, skrining penyakit, serta faktor risiko reproduksi yang perlu diperhatikan sebelum memasuki masa kehamilan. Berbagai materi tersebut memberikan pemahaman penting mengenai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan ibu dan calon generasi mendatang.

Selain aspek fisik dan reproduksi, buku ini juga menguraikan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan sehat, kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki pernikahan, serta evaluasi kesiapan perempuan pada masa prakonsepsi. Pembahasan mengenai konseling pranikah, peran keluarga, kesehatan mental, dan strategi pencegahan dalam asuhan kebidanan prakonsepsi menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan pasangan secara menyeluruh. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pranikah dan prakonsepsi di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 ASUHAN KEBIDANAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN 1

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi.....	2
C. KIE Persiapan Kehamilan	3
D. Penilaian Resiko	3
E. Intervensi.....	5
F. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan (KIE) Pranikah.....	7
G. Pre-marital Screening	7
H. Hak Reproduksi dan Seksual.....	11
I. KIE Persiapan Kehamilan Pada Masa Pra Nikah.....	11
J. Materi KIE Kesehatan Reproduksi & Seksual Bagi Catin.....	11
K. Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah	11
L. Simpulan.....	12
Referensi.....	13

CHAPTER 2 PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN 15

Bd. St. Hasriani, S.Tr.Keb., M.Keb.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Dasar Pemeriksaan Pranikah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan.....	18
D. Komponen Pemeriksaan Kesehatan.....	20
E. Skrining Risiko Kesehatan	25
F. Simpulan.....	27
Referensi.....	28
Glosarium.....	31

CHAPTER 3 STATUS GIZI, ANEMIA, DAN KESIAPAN SEBELUM KEHAMILAN

.....	33
Wita Solama, SST., M.Kes.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Konsep Dasar Pra-Konsepsi	33
C. Status Gizi Pra-Kehamilan.....	34
D. Anemia Pada Wanita Usia Subur.....	36
E. Kesiapan Fisik Sebelum Kehamilan.....	37
F. Asuhan Kebidanan Pra-Konsepsi.....	39
G. Studi Kasus Klinis.....	40
H. Program Kesehatan & Peran Bidan	42
I. Simpulan.....	43
Referensi.....	44
Glosarium.....	45

CHAPTER 4 IMUNISASI, SKRINING PENYAKIT, DAN FAKTOR RISIKO

REPRODUKSI.....	47
Bdn. Zuliyana, SST., M.Keb.	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep Imunisasi pada Masa Pranikah dan Prakonsepsi.....	48
C. Skrining Penyakit pada Calon Pengantin	54
D. Faktor Risiko Reproduksi pada Calon Pengantin	57
E. Simpulan.....	60
F. Referensi.....	60
G. Glosarium.....	62

CHAPTER 5 EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN PERENCANAAN

KEHAMILAN.....	63
Heni Angraini, S.Tr.Keb., M.Keb.	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi	65
C. Tujuan Kesehatan Reproduksi	70
D. Sasaran Kesehatan Reproduksi	70
E. Perencanaan Kehamilan sehat	71
F. Kesehatan Ibu Hamil dan Komplikasi	72
G. Simpulan.....	75
H. Referensi.....	77
I. Glosarium.....	78

**CHAPTER 6 KESIAPAN PSIKOLOGIS DAN SOSIAL DALAM MEMASUKI
PERNIKAHAN79**

Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb.....	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Konsep Kesiapan Pernikahan.....	80
C. Perspektif Teori tentang Kesiapan Pernikahan.....	80
D. Kesiapan Pernikahan pada Remaja dan Dewasa Awal	81
E. Kesiapan Psikologis dalam Memasuki Pernikahan	82
F. Kesiapan Sosial dalam Memasuki Pernikahan.....	84
G. Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Psikologis dan Sosial.....	86
H. Dampak Ketidaksiapan dalam Pernikahan.....	87
I. Upaya Meningkatkan Kesiapan Psikologis dan Sosial.....	87
J. Hubungan Kesiapan Pernikahan dengan Kesehatan Mental	88
K. Peran Keluarga dalam Mempersiapkan Pernikahan.....	89
L. Kesiapan Pernikahan dalam Perspektif Sosial Budaya Indonesia.....	89
M. Konseling Pranikah sebagai Upaya Persiapan Pernikahan	90
N. Implikasi Kesiapan Pernikahan terhadap Kehidupan Keluarga	90
O. Kesimpulan	91
P. Referensi.....	91

**CHAPTER 7 EVALUASI KESIAPAN PEREMPUAN DALAM MASA
PRAKONSEPSI.....93**

Rikhly Faradisy Mursyida, S.ST., M.Kes.....	93
A. Pendahuluan.....	93
B. Konsep evaluasi kesiapan prakonsepsi	94
C. Calon Pengantin Wanita dengan Kesiapan Prakonsepsi Rendah.....	95
D. Komponen evaluasi kesiapan perempuan prakonsepsi.....	97
E. Strategi Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier dalam Asuhan Kebidanan Pranikah-Prakonsepsi.....	98
F. Hambatan dalam Evaluasi Kesiapan Prakonsepsi	103
G. Implikasi bagi praktik kebidanan.....	104
H. Simpulan.....	104
Referensi.....	105
Glosarium.....	106

PROFIL PENULIS107

CHAPTER 1

ASUHAN KEBIDANAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI PADA CALON PENGANTIN

Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kementerian Kesehatan RI melaporkan AKI di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab tingginya AKI di Indonesia berkaitan dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Komplikasi atau penyulit yang terjadi pada masa kehamilan dapat berlanjut ke masa persalinan, nifas bahkan dapat berdampak pada bayi baru lahir.

Kehamilan dapat dikatakan sebagai ujung tombak keberhasilan anak bangsa di kemudian hari. Pada masa kehamilan diupayakan persiapan yang matang agar janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik selama di dalam rahim. Persiapan kehamilan tidak hanya tentang kesiapan fisik, melainkan juga kemandirian mental untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan janin di dalam kandungan. Janin membutuhkan kasih sayang, nutrisi yang cukup dan lingkungan yang sehat agar dapat berkembang secara optimal. Beberapa hal penting harus dipersiapkan sedini mungkin sebelum kehamilan itu terjadi. Salah satunya adalah informasi mengenai persiapan kehamilan yang dapat diperoleh melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) persiapan kehamilan.

Konseling pra kehamilan adalah pendampingan yang berbasis pengetahuan serta keterampilan yang menyediakan informasi mengenai persiapan kehamilan yang dapat bermanfaat meningkatkan kesehatan saat kehamilan nanti. Salah satu proses reproduksi adalah kehamilan. Kehamilan merupakan anugerah Tuhan yang harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Intervensi prakonsepsi lebih penting dari intervensi prenatal untuk pencegahan anomali kongenital karena sebanyak 30 persen ibu hamil baru memeriksakan kehamilannya pada trimester

kedua (> 13 minggu kehamilan, yaitu setelah periode organogenesis utama (antara 3 dan 10 minggu kehamilan).

Idealnya tes kesehatan pranikah dilakukan enam bulan sebelum pernikahan tetapi tes kesehatan pranikah dapat dilakukan kapanpun selama pernikahan belum berlangsung (Permatasari, 2022).

B. Konsep Dasar Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi

Skrining pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum menikah menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Skrining pranikah ini penting untuk menghindari terjadi masalah kesakitan, kecatatan rohani dan jasmani, kematian, serta menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir (Well born baby and well health mother)

Pre marital screening check up atau tes pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Di negara-negara lain, pre marital screening sudah menjadi persyaratan wajib bagi pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang mempunyai riwayat kesehatan yang baik. Seseorang yang tampak sehat dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa (carrier) penyakit. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan genetik, penyakit menular dan infeksi melalui darah.

Pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan calon mempelai (fisik, mental, sosial) dan pasangan sebelum kehamilan, bertujuan mewujudkan kesehatan reproduksi optimal, mencegah penyakit menular/genetik, dan menjamin kesehatan ibu serta bayi (3-12 bulan sebelum konsepsi), fokus utamanya adalah skrining kesehatan, edukasi gizi, dan konseling kesehatan reproduksi. Pelayanan kesehatan/konseling untuk calon mempelai, mencakup pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis sebelum menikah.

Konseling pranikah adalah pendampingan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Pendampingan pranikah mempersiapkan pasangan agar sungguh-sungguh siap secara mental, psikis maupun secara biologis sebelum memasuki dunia perkawinan dan hidup berkeluarga. Dalam konseling pranikah, hal-hal mendasar yang ditekankan bagi calon pasangan, misalnya terkait persiapan kesehatan mental dan kesehatan biologis, seperti kesehatan reproduksi pria dan wanita.

Pemeriksaan bertujuan untuk mencegah agar penyakit tersebut tidak menurun pada keturunannya di kemudian hari sehingga hidup sehat bersama

keluarga bisa tercapai. Waktu pelaksanaan pre marital screening yang disarankan adalah 6 bulan sebelum calon mempelai menikah.

C. KIE Persiapan Kehamilan

Persiapan prakehamilan (prakonsepsi) adalah istilah luas yang mengacu pada proses identifikasi berbagai risiko, seperti risiko sosial, perilaku, lingkungan, dan biomedis terhadap kesuburan dan hasil kehamilan seorang wanita, yang bertujuan untuk mengurangi risiko ini (bila mungkin) melalui pendidikan, konseling, dan intervensi yang tepat, sebelum kehamilan.

Perawatan prakonsepsi harus menjadi bagian penting dari perawatan primer dan kedokteran pencegahan pada semua wanita usia subur yang memeriksa kesehatan dirinya :

1. Masalah ini penting, karena meskipun ibu hamil menginginkan hal terbaik untuk keturunannya di masa yang akan datang, kenyataannya lebih dari 50% kehamilan tidak direncanakan dengan baik.
2. Idealnya, pasien, suami dan dokter atau petugas kesehatan lainnya, merencanakan program kesehatan reproduksi dan mempersiapkannya dengan baik sesuai kebutuhan dan keadaan masing-masing individu. Ibu yang ingin hamil dievaluasi kesehatan alat reproduksi dan pendukungnya, sementara ibu yang belum ingin hamil tetap harus dijaga kesehatan reproduksinya dan ditawarkan metode keluarga berencana yang sesuai (Emilia, 2019).

Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik.

Selain evaluasi kesehatan reproduksi berkala, perawatan prakonsepsi juga dapat berkisar pada kegiatan antara lain:

1. Pemeriksaan pranikah dan berbagai pemeriksaan penunjangnya
2. Konseling Kontrasepsi pra-kehamilan
3. Evaluasi penyakit menular seksual atau infeksi vagina
4. Petugas kesehatan diharapkan mampu melakukan penilaian prakonsepsi dasar, memberikan pendidikan dasar kesehatan reproduksi, dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk intervensi. Apabila terdapat situasi di luar kemampuan maka petugas kesehatan, harus dilakukan rujukan kepada seorang konselor genetik dan / atau petugas dengan keahlian khusus (Marniati, 2022).

D. Penilaian Resiko

Tujuan utama penilaian risiko adalah untuk mendapatkan riwayat kesehatan reproduksi secara menyeluruh . pertanyaan meliputi pertanyaan meliputi (Parmawati, I., Nisman, W. A., Lismidiati, W., & Mulyani, 2020) :

1. Usia

Seiring dengan peningkatan usia ibu , risiko infertilitas , aneuploidi janin , keguguran , diabetes gestasional , preeklamsia , dan lahir mati juga meningkat⁵ . Wanita harus menyadari risiko ini dan sebaiknya jangan menunda kehamilan sampai usia 30-an atau 40-an, atau sebaliknya tidak harus hamil lagi pada usia tersebut bila tidak betul-betul diperlukan. Usia ayah yang lanjut juga memiliki beberapa risiko bagi anak.

2. Riwayat Pekerjaan

3. Riwayat umum

Keinginan dan rencana untuk hamil, lama menikah, rencana menikah Siklus menstruasi, Kontrasepsi yang sedang atau pernah dipakai, Obat-obatan yang pernah/sedang dipakai Alergi obat-obatan atau lainnya.

4. Riwayat ginekologis

Hasil papsmear abnormal, Gangguan siklus menstruasi, Mioma uteri, Kista ovarium Operasi ginekologis Penyakit menular seksual seperti gonore, klamidia, kondiloma, sifilis atau herpes.

5. Riwayat Obstetri buruk

Pernah abortus, hamil kosong/blighted ova, kematian janin, bayi cacat Pernah mengalami KPD/Ketuban Pecah Dini, kelahiran preterm, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah Pernah hamil di luar kandungan, Pernah hamil mola, atau penyakit trofoblas gestasional ganas Perdarahan dalam kehamilan/pascasalin.

6. Imunisasi yang pernah didapat Hepatitis B

7. Penyakit Keturunan

8. Penyakit Kronis yang pernah/sedang diderita

9. Obat-obatan yang pernah/sedang dikonsumsi

10. Alkohol, merokok, kafein

11. Pernah mendapat produk darah, pernah mengalami komplikasi transfuse

12. Diet yang sedang dilakukan, suplemen atau herbal yang dikonsumsi

13. Pemakaian herbal rutin

14. Olah raga yang rutin dilakukan

15. Binatang peliharaan

16. Pekerjaan, jenisnya, lama bekerja, risiko untuk penularan penyakit atau cedera

17. Keadaan kesehatan mental/psikis

E. Intervensi

Berbagai intervensi terbukti dapat menurunkan kejadian kelainan kongenital, gangguan pertumbuhan janin dan beberapa komplikasi kehamilan seperti persalinan preterm, solusio plasenta, atau pencegahan eklamsi. Intervensi yang telah dilakukan antara lain :

1. Berhenti merokok Wanita yang sedang merencanakan kehamilan akan lebih termotivasi untuk berhenti merokok dan petugas kesehatan dapat memanfaatkan konseling prakonsepsi untuk memotivasi ibu menghentikan merokok agar tidak mengganggu tumbuh kembang janin.
2. Beberapa vaksinasi melindungi infeksi kongenital yang dapat menyebabkan cacat janin. Vaksin hidup (varisela; campak, gondongan dan rubela) harus diberikan minimal satu bulan sebelum kehamilan untuk menghindari sindroma rubela.
3. Menurunkan berat badan untuk mencapai indeks massa tubuh (IMT) normal sangat penting dilakukan sebelum hamil, karena terbukti obesitas berhubungan dengan infertilitas dan sebaliknya ibu yang terlalu kurus (terutama dengan gangguan asupan makanan) berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah.
4. Perubahan perilaku kesehatan (misalnya mencuci tangan dan tindakan higienis lainnya, menghindari konsumsi daging setengah matang, makanan yang tidak dipasteurisasi dan sayuran mentah) dapat mengurangi risiko tertular infeksi, seperti toksoplasmosis, sitomegalovirus, dan listeriosis.
5. Hipertensi harus terkontrol sebelum konsepsi obat antihipertensi seperti ACE inhibitor dan ARB, harus dihindari pada kehamilan, karena pada setiap tahap kehamilan terkait dengan efek buruk pada janin. Pasien yang ingin hamil harus mengganti obatnya dengan yang aman untuk janin. Wanita dengan hipertensi yang tidak terkontrol harus dievaluasi kesehatan umumnya lebih dahulu agar kehamilan tidak merugikan ibu dan janinnya.
6. Ibu yang mengidap Asma harus di bawah kontrol yang baik sebelum hamil dan dalam pengawasan dokter. Bila diperlukan, penggunaan steroid (dihirup dan sistemik) pada kehamilan umumnya aman, terutama bila dibandingkan dengan risiko tidak dipakai.
7. Penyakit tiroid memerlukan pemantauan ketat fungsi tiroid, karena hipertiroid dan hipotiroid dapat mempengaruhi kesuburan dan luaran kehamilan nantinya.
8. Wanita dengan riwayat kejang dan wanita yang menggunakan obat anti epilepsi harus menerima informasi menyeluruh tentang risiko kehamilan bagi ibu dan janin, penyesuaian dalam resimen obat mereka, dan suplemen asam

folat untuk mengurangi risiko NTD. Pemakaian valproate untuk kejang harus dihentikan, dan harus diganti dengan obat alternatif yang memadai, karena valproate merupakan teratogen paling kuat dibanding obat anti epilepsi lainnya.

9. Untuk wanita dengan lupus eritematosus sistemik, prognosis kehamilan yang terbaik adalah bila remisi penyakit telah tercapai setidaknya enam bulan sebelum kehamilan dan fungsi ginjal pasien stabil, normal atau mendekati normal. Obat yang dikonsumsi ibu mungkin perlu diubah karena potensi risiko janin.
10. Karies gigi dan penyakit mulut lainnya (misalnya periodontitis) dapat berhubungan dengan komplikasi kehamilan, seperti kelahiran preterm dan ketuban pecah dini, sehingga perlu dirujuk ke dokter gigi yang tepat sebelum ibu hamil.
11. Penyakit keturunan Untuk wanita dengan riwayat penyakit keturunan, diperlukan rujukan untuk konseling genetik. Pemeriksaan kromosom ibu sebagai pembawa, potensi risiko penyakit genetik pada janin, pilihan tentang diagnosis prenatal dan intervensi yang mungkin akan dilakukan, harus dijelaskan sebelum ibu menentukan untuk hamil.
12. Masalah psikososial - stres psikososial, kesehatan mental, dan masalah keuangan atau lainnya. harus diidentifikasi dan intervensi dengan tepat untuk menghindari kurangnya dukungan sosial, hambatan untuk perawatan prenatal, dan kekerasan dalam rumah tangga.
13. Penyakit jiwa ibu harus diidentifikasi dan diobati dengan adekuat dan ibu harus menunggu untuk hamil agar dapat menghindari efek obat, efek kejiwaan, dan gangguan hubungan ibu dengan bayinya. Support suami dan keluarga harus baik, karena penyakit yang tidak diobati atau diobati tidak adekuat akan mengakibatkan berbagai konsekuensi. Idealnya, pasien harus menunggu sampai ia telah menjadi euthymic, yang mungkin memakan waktu 6 sampai 12 bulan, sebelum ia mencoba untuk hamil.
14. Mega vitamin, suplemen makanan yang tidak penting, dan obat-obat herbal harus dihentikan, mengingat bahwa risiko terhadap janin dari zat-zat tersebut umumnya belum dievaluasi. Dosis vitamin A yang terlalu tinggi selama awal kehamilan telah dikaitkan dengan cacat lahir. Persiapan multivitamin yang mengandung lebih dari 5000 unit internasional vitamin A harus dihindari (peningkatan risiko teratogenesis pada dosis pemberian > 10.000 internasional unit / hari).

Dengan memperhatikan faktor risiko ibu, penapisan faktor risiko seperti tertulis di atas serta upaya intervensinya, kita dapat berharap agar kehamilan yang direncanakan akan menghasilkan generasi berikut yang lebih baik (Wahyuni, 2019).

F. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan (KIE) Pranikah

UU No. 36 tahun 2009, penyuluhan kesehatan diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan. penyuluhan kesehatan diselenggarakan untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok masyarakat agar hidup sehat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Konseling pranikah (premarital counseling) adalah upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Tujuan KIE Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kespro dan seksual bagi catin
2. Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan KIE kespro kepada catin
3. Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dapat berkoordinasi dengan lembaga keagamaan dalam pemberian KIE kespro catin
4. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi catin termasuk imunisasi TT (Zaqiah, 2020)

G. Pre-marital Screening

1. Definisi

Disebut juga dengan pre-marital check up yang terdiri dari berbagai kelompok tes yang dibuat untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan yang ada saat ini atau kemungkinan masalah yang muncul dikemudian hari saat pasangan hamil dan memiliki anak.

Idealnya tes kesehatan pra nikah dilakukan enam bulan sebelum dilakukan pernikahan tetapi tes kesehatan pra nikah dapat dilakukan kapan pun selama pernikahan belum berlangsung. Upaya kesehatan terhadap pasangan pranikah yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pemeriksaan kesehatan bagi pasangan pranikah sangat penting untuk mengetahui tingkat kesehatan dari pasangan, jika ditemukan masalah kesehatan maka dapat langsung dilakukan intervensi untuk pengobatan.

2. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Prosedur yang harus dilakukan tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan kesehatan lain biasanya. Anda dan pasangan membuat janji terlebih dahulu dengan dokter spesialis atau dokter umum kemudian setelah melakukan wawancara singkat tentang sejarah kesehatan, PUS (pasangan usia subur) wajib melakukan pemeriksaan fisik dan rangkaian tes radiologi dan laboratorium untuk mendeteksi kelainan-kelainan apa saja yang mungkin diderita. Idealnya, pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan enam menjelang pernikahan. Namun ukuran itu sebenarnya bersifat fleksibel dalam arti kapanpun dapat dilakukan, agar penyakit- penyakit yang mungkin terdeteksi dapat ditanggulangi terlebih dahulu (Usman, 2023).

3. Konseling Pranikah

Konseling pranikah adalah pendampingan berbasis pengetahuan serta keterampilan yang ada untuk menyediakan berbagai informasi tentang pernikahan yang bermanfaat untuk dapat memperkuat serta mempertahankan hubungan pasangan yang akan menikah.

Menikah merupakan tahapan yang penting bagi setiap pasangan yang sudah menemukan belahan jiwa, setelah cukup lama saling mengenal satu sama lain, berbagi cerita dan berusaha menyatukan ide-ide. Pendampingan pranikah mempersiapkan pasangan agar sungguh-sungguh siap secara mental, psikis maupun secara biologis sebelum memasuki dunia perkawinan dan hidup berkeluarga. Dalam Konseling pranikah, hal-hal mendasar sangat ditekankan bagi calon pasangan, misalnya terkait kesiapan kesehatan mental dan kesehatan biologis, seperti kesehatan reproduksi pria dan wanita.

4. Kriteria Konseling Pranikah

Bimbingan dan konseling pranikah dapat disusun dengan memenuhi beberapa kriteria yaitu:

a. Dimensi Konten

Relational Skills (Keterampilan Hubungan). Yaitu Keterampilan yang perlu ada pada pasangan sebagai keterampilan dalam mencapai visi perkawinan.

Awareness, Knowledge, and Attitudes (Kesadaran, Pengetahuan, dan Sikap). Yaitu Keterampilan hubungan yang baik membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap dari setiap pasangan, seperti elemen kesiapan mental dan etika, harapan yang realistis, kemauan untuk membuat pengorbanan pribadi yang signifikan.

Motivation/Virtues (Motivasi dan Kebajikan). Yaitu Karakter dan motivasi yang diberikan individu terhadap hubungan sangat penting untuk memahami pernikahan yang sehat, begitupun dengan kebajikan, seperti kemurahan hati, keadilan, dan kesetiaan.

b. Dimensi II Identitas

Low Level (Tingkat Rendah). Yaitu Intensitas tingkat rendah yang merupakan upaya kampanye melalui pamflet kepada pasangan pranikah, dapat melalui pesan media yang kreatif untuk mengajarkan prinsip dasar perkawinan sehat.

Moderate Level (Tingkat Sedang). Intensitas tingkat sedang memberi kerangka ruang lingkup kurikulum dalam pendidikan pernikahan. Menghadirkan peserta, adanya waktu yang ditentukan bersama untuk membahas konten dalam pendidikan pernikahan.

High Level (Tingkat Tinggi). Intensitas tingkat tinggi sangat penting untuk strategi pendidikan pernikahan yang komprehensif, eksplorasi mendalam terhadap topik yang lebih lengkap, dan memungkinkan individu dan pasangan untuk mengeksplorasi masalah pribadi pada tingkat yang lebih dalam dengan fasilitator terlatih.

Di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan intensitas moderate level dengan asumsi bahwa sebagai bentuk persiapan maka kerangka konten yang dibahas tidak begitu mendalam, namun cukup mengakomodir konten dalam pembahasan perkawinan.

c. Dimensi III Dimensi

Instruction. Learning style (Gaya Belajar). Metode insruksi atau pengajaran perlu menyesuaikan dan menyajikan konten kurikuler agar sesuai dengan pengalaman hidup peserta dengan sangat efektif, disini lain instruktur atau pelatih yang memberikan program pendidikan pernikahan harus terbiasa dengan isu-isu tertentu yang dihadapi peserta.

Learning style (Gaya Belajar). Metode yang dapat disesuaikan dengan beragam gaya belajar, seperti presentasi informasi didaktik, menunjukkan contoh (misalnya, dalam video), diskusi interaktif, dan permainan peran. Individu dan pasangan terdidik terbiasa dengan pendekatan kognitif dan didaktik yang khas dari pendidikan tinggi mungkin lebih menyukai metode pembelajaran eksperimental yang lebih aktif. Program BK pranikah di perguruan tinggi dapat dirancang dengan serangkaian kurikuler/konten yang disesuaikan dengan gaya belajar di perguruan tinggi.

d. Dimensi IV Target

Target untuk poin pada pendidikan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok ras, etnis, dan sosial ekonomi. Target ini perlu dipenuhi untuk menjaga kecemburuan sosial diantara setiap individu yang memiliki keinginan mendapat pendidikan perkawinan. 5) Dimensi V Delivery (Penyampaian).

Penyampaian pendidikan pernikahan dapat disampaikan oleh specialist marriage education (spesialis pendidikan pernikahan) yaitu konselor atau psikolog di perguruan tinggi yang dapat diakses melalui pusat layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang tersedia di masing-masing lembaga universitas negeri maupun swasta. Secara keseluruhan program yang dirancang disesuaikan dengan individu yang berada pada masa dewasa awal khususnya mahasiswa yang berada pada perguruan tinggi, minimal meliputi.

Individu memperhatikan latarbelakang keluarga masing-masing pasangan. Pasangan pranikah perlu memperhatikan keadaan latarbelakang keluarga pasangan (Gardner, Busby, & Brimhall, 2009). • Mengeksplorasi suatu hubungan melibatkan dua individu, dan karakteristik keduanya mempengaruhi sifat hubungan komitmen terhadap pernikahan untuk mengikuti program pendidikan pernikahan (Blair & Cordova, 2009). Selain itu faktor keadaan individu yang mengalami gangguan stress, kecemasan, emosional dan semacamnya mempengaruhi perkawinan pada masa dewasa. Sehingga peningkatan kecemasan setiap hari dan ketidaksejahteraan fisik secara tidak langsung menurunkan kepuasan hubungan perkawinan (Falconier, Nussbeck, Bodenmann, Schneider, & Bradbury, 2015) perlu dibekali bagi mahasiswa sebagai individu pada dewasa awal.

Interaksi positif pasangan memungkinkan untuk mengeksplorasi ekspektasi individu terhadap pernikahan meningkatkan seluruh dimensi mental, emosional, fisik, dan spiritual dan memberi rasa aman dan kepuasan individu terhadap hubungan (Salvatore, Kuo, Steele, Simpson, & Collins, 2011).

Persiapan pernikahan akan memberi dampak terhadap individu yang menjalani hubungan dengan pasangan yang berfokus pada komitmen dan harapan hubungan yang realistis. Bimbingan dan konseling pranikah merupakan upaya membantu individu maupun pasangan dalam merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap penting dalam hal pernikahan/perkawinan berbasis sumber daya pasangan untuk memiliki berbagai keterampilan dan mengembangkan visi kehidupan pernikahan.

H. Hak Reproduksi dan Seksual

Memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan jarak kelahiran. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat Memperoleh informasi dan pelayanan KB Pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan. Hak reproduksi juga mencakup informasi yang mudah, lengkap, dan akurat.

I. KIE Persiapan Kehamilan Pada Masa Pra Nikah

1. Persiapan fisik
Pemeriksaan status kesehatan: tanda-tanda vital (suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah)
2. Pemeriksaan Darah Rutin: Hb, Trombosit, Lekosit, Pemeriksaan Darah Yang Dianjurkan: Golongan Darah Dan Rhesus, Gula Darah Sewaktu (GDS), Asuhan Kebidanan Pranikah Dan Prakonsepsi, Thalasemia, Hepatitis B Dan C, Torch (Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus Dan Herpes Simpleks), Pemeriksaan Urin
3. Persiapan Gizi
4. Status Imunisasi
5. Kebersihan Organ Reproduksi (Situmorang, 2023)

J. Materi KIE Kesehatan Reproduksi & Seksual Bagi Catin

1. Persiapan pranikah (Persiapan fisik, gizi, status imunisasi)
2. Menjaga Kebersihan organ reproduksi.
3. Kesetaraan gender dalam pernikahan.
4. Kehamilan dan persalinan, komplikasi, pasca salin dan inisiasi menyusui Dini dan ASI eksklusif
5. Metode komplikasi untuk menunda kehamilan
6. Infeksi menular seksual & infeksi saluran reproduksi dan HIV AIDS, termasuk pencegahan penularan dari Ibu ke anak.
7. Gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki serta Pencegahannya
8. Mitos pada perkawinan.

K. Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pasangan Yang Akan Menikah

Rangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan Kesehatan Umum

1. Pemeriksaan fisik/klinis lengkap Di antara manfaat pemeriksaan fisik lengkap adalah untuk mengetahui status tekanan darah seseorang. Tekanan darah yang normal adalah salah satu kunci kesehatan. Tekanan darah tinggi atau hipertensi berbahaya saat perempuan hamil, karena dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Pemeriksaan fisik juga bisa mendeteksi gejala obesitas, karena obesitas dapat memengaruhi tingkat kesuburan.
2. Pemeriksaan darah rutin Pemeriksaan darah rutin ini meliputi kadar hemoglobin (hb), hematokrit, sel darah putih (leukosit) dan faktor pembekuan darah (trombosit). Para calon ibu perlu mengetahui kadar hb-nya untuk mendeteksi gejala anemia, juga perlu mengetahui adanya gangguan faktor pembekuan darah. Dari hasil pemeriksaan darah dapat diketahui kondisi kadar kolesterol tinggi yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke.
3. Golongan darah dan rhesus Rhesus adalah sebuah penggolongan atas ada atau tiadanya substansi antigen-D pada darah. Rhesus positif berarti ditemukan antigen-D dalam darah dan rhesus negatif berarti tidak ada antigen-D. Kebanyakan warga bangsa Asia memiliki rhesus positif (+), sedangkan kebanyakan warga bangsa Eropa memiliki negatif (-).
4. Urinalisis lengkap Pemeriksaan urine penting dilakukan agar bisa diketahui adanya infeksi saluran kemih (ISK) dan adanya kondisi darah, protein, dan lain-lain yang menunjukkan adanya penyakit tertentu. Penyakit ISK saat kehamilan berisiko baik bagi ibu maupun bayi, seperti kelahiran prematur, berat janin yang rendah, bahkan risiko kematian saat persalinan.

L. Simpulan

Asuhan pranikah dan prakonsepsi adalah pelayanan kesehatan promotif dan preventif untuk memastikan pasangan sehat secara fisik, mental, dan sosial sebelum menikah dan hamil. Fokus utamanya adalah skrining kesehatan, konseling kesehatan reproduksi, serta persiapan gizi untuk mencegah komplikasi kehamilan, penyakit keturunan, dan meningkatkan kesehatan ibu-anak.

Konseling merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan. Konseling dilakukan tidak hanya untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan kesehatan dan keluhan yang disampaikan oleh klien, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana mencari dan menggali lebih dalam mengenai riwayat penyakit genetik. Konseling juga dapat berisi informasi mengenai penyakit maternal yang dilakukan sebagai upaya mencegah dan mendeteksi dini kemungkinan permasalahan maternal yang akan terjadi.

Kehamilan merupakan proses menghasilkan keturunan yang memerlukan persiapan secara matang, baik secara fisik maupun mental. Pemeriksaan kesehatan

yang berkaitan dengan kesiapan fisik meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, persiapan gizi, status imunisasi dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Sementara kesiapan mental dapat diperoleh dari KIE yang berisi edukasi persiapan kehamilan yang berhubungan dengan psikologis.

Referensi

- Ayu, N. et al. (2021) 'Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Yang Berniat Menikah Usia Dini Di Kabupaten Semarang Tahun 2020', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(3), pp. 360–367
- Dewi, dkk (2011) 'Asuhan kehamilan untuk kebidanan', (Jakarta: Salemba medika).
- Emilia, O., & Prabandari, Y. S. (2019). *Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi*. Ugm Press.
- Permatasari, Dian. dkk (2022). Asuhan kebidanan pranikah dan pra konsepsi. Sumenep: Yayasan Kita Menulis
- Marniati, A. D. (2022). *Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Situmorang, R., & Simamora, R. M. (2023). MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN PADA REMAJA DAN PRAKONSEPSI. *Journal of Andalas Medica*, 1(2), 112-125.
- Susilowati H, Endang. (2006). Lebih jauh tentang kehamilan. Jakarta : Edsa Mahkota.
- Tyastuti, S., & Wahyuningsih, H. P. (2016). Asuhan Kebidanan Kehamilan. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Zaqiah, F., & Nursal, D. G. A. Konseling Pranikah Tentang Kesehatan Reproduksi untuk Calon Pengantin. Penerbit Adab.
- Wardani, R. A., Farani, S., Susanti, L., Fadhilah, S., Sari, K. I. P., Rusmayani, N. G. A. L., & Sari, I. P. (2022). *Pengantar Asuhan Kebidanan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

CHAPTER 2

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN

Bd. St. Hasriani, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan merupakan bagian penting. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *preconception care* semakin ditekankan sebagai strategi preventif untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. *Preconception care* mencakup intervensi biomedis, perilaku, dan sosial yang dilakukan sebelum terjadinya kehamilan untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan mengurangi faktor risiko yang dapat memengaruhi hasil kehamilan (Dean et al., 2021). Pendekatan ini menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak tidak hanya ditentukan selama kehamilan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sebelum konsepsi.

Pemeriksaan pranikah memiliki peran strategis dalam mendeteksi secara dini berbagai kondisi kesehatan yang berpotensi menimbulkan risiko pada kehamilan, seperti anemia, penyakit menular seksual, serta penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Studi terbaru menunjukkan bahwa skrining kesehatan sebelum kehamilan secara signifikan berkontribusi dalam menurunkan komplikasi obstetri serta meningkatkan luaran neonatal (Lassi et al., 2020; ACOG, 2022). Di Indonesia, upaya ini telah diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan primer melalui program skrining calon pengantin sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Deteksi dini dan intervensi yang tepat sebelum kehamilan terbukti mampu meningkatkan kesiapan fisik dan mental perempuan dalam menghadapi kehamilan.

Selain aspek medis, pemeriksaan kesehatan pranikah juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin perempuan mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta gaya hidup sehat. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang nutrisi seimbang, suplementasi zat besi dan asam folat, pentingnya

imunisasi, serta pencegahan faktor risiko seperti merokok dan konsumsi alkohol (Stephenson et al., 2020). Pendekatan promotif dan preventif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatannya sebelum memasuki masa kehamilan.

Lebih lanjut, pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan juga berperan dalam mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesiapan psikososial dalam memasuki kehidupan pernikahan dan kehamilan. Kesehatan mental yang optimal sebelum kehamilan berkontribusi terhadap kemampuan perempuan dalam beradaptasi terhadap perubahan fisik dan emosional selama masa kehamilan serta peran sebagai ibu. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi yang tidak terdeteksi sejak masa prakonsepsi dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan perkembangan janin (Dunkel Schetter & Tanner, 2020). Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan kesehatan pranikah perlu mencakup aspek psikologis sebagai bagian dari pelayanan yang holistik dan berpusat pada perempuan.

Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemeriksaan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya derajat kesehatan ibu dan anak yang optimal serta berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan kesehatan nasional dan global.

B. Konsep Dasar Pemeriksaan Pranikah

1. Pengertian pemeriksaan kesehatan pranikah

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian upaya skrining kesehatan yang dilakukan pada individu atau pasangan sebelum menikah untuk menilai kondisi kesehatan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi, kehamilan, serta kualitas keturunan di masa depan.

Dalam praktiknya, pemeriksaan pranikah merupakan bagian dari pelayanan *preconception care* yang menekankan pentingnya kesiapan kesehatan sebelum terjadinya konsepsi guna mencegah komplikasi kehamilan dan meningkatkan luaran maternal dan neonatal (Temmerman et al., 2021; Dorney et al., 2022). Dengan demikian, pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada deteksi penyakit, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif yang komprehensif.

2. Sasaran pemeriksaan (calon pengantin perempuan)

Sasaran utama pemeriksaan kesehatan pranikah adalah perempuan usia subur yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Kelompok ini memiliki peran penting dalam proses reproduksi sehingga kondisi kesehatannya perlu dipersiapkan secara optimal. Pemeriksaan difokuskan pada identifikasi status kesehatan umum, status gizi, kesehatan reproduksi, serta faktor risiko yang dapat memengaruhi kehamilan seperti anemia, infeksi, penyakit kronis, dan gangguan hormonal. Selain itu, perhatian juga diberikan pada aspek perilaku kesehatan seperti pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan berisiko (misalnya merokok atau konsumsi zat berbahaya) yang dapat berdampak pada kesuburan dan kesehatan janin (Hanson et al., 2020; Stephenson & Barker, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon ibu berada dalam kondisi optimal sebelum memasuki masa kehamilan.

3. Prinsip pelayanan (komprehensif, promotif, preventif)

Pelayanan pemeriksaan kesehatan pranikah dilaksanakan berdasarkan prinsip komprehensif, promotif, dan preventif. Prinsip komprehensif menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial. Prinsip promotif berfokus pada upaya peningkatan kesehatan melalui edukasi, konseling, dan pemberdayaan individu agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri. Sementara itu, prinsip preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau komplikasi melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan faktor risiko kehamilan serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak (Bhutta et al., 2021). Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut, pelayanan pranikah menjadi bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pencegahan.

4. Etika dan kerahasiaan dalam pemeriksaan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah, aspek etika dan kerahasiaan memiliki peranan yang sangat penting. Tenaga kesehatan wajib menjunjung tinggi prinsip etik seperti *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* dalam memberikan pelayanan. Calon pengantin berhak mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, dan akurat terkait kondisi kesehatannya serta berhak menentukan keputusan secara mandiri setelah mendapatkan konseling yang adekuat. Selain itu, seluruh informasi medis yang diperoleh selama pemeriksaan harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat dibuka dengan persetujuan individu yang bersangkutan (International

Confederation of Midwives, 2021; Beauchamp & Childress, 2020). Penerapan prinsip etika dan kerahasiaan ini penting untuk membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dan klien serta memastikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.

C. Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan

1. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Pemeriksaan kesehatan pranikah bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kondisi kesehatan dan faktor risiko yang dapat memengaruhi kesiapan reproduksi serta keberhasilan kehamilan di masa depan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendekatan preconception care yang berfokus pada peningkatan status kesehatan sebelum terjadinya konsepsi melalui skrining, intervensi dini, serta perubahan perilaku kesehatan. Pendekatan ini memberikan peluang untuk mencegah berbagai penyakit kronis dan gangguan kesehatan yang dapat berdampak pada ibu maupun janin (Steel et al., 2025; Dorney & Black, 2024)

Selain itu, tujuan penting lainnya adalah meningkatkan kesiapan pasangan, khususnya perempuan, dalam menghadapi kehamilan secara fisik, mental, dan sosial. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku hidup sehat seperti perbaikan pola makan, aktivitas fisik, serta pengendalian faktor risiko seperti merokok dan konsumsi alkohol. Dengan adanya intervensi sejak periode prakonsepsi, peluang terjadinya kehamilan sehat dan kelahiran bayi yang optimal menjadi lebih besar (Citra et al., 2026; Steel et al., 2025)

2. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

a. Deteksi dini penyakit menular dan tidak menular

Pemeriksaan kesehatan pranikah memberikan manfaat penting dalam mendeteksi secara dini berbagai penyakit menular maupun tidak menular yang dapat memengaruhi kesehatan pasangan dan keturunan. Skrining ini mencakup penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis, dan sifilis, serta penyakit kronis seperti anemia, diabetes, dan hipertensi. Deteksi dini memungkinkan penanganan segera sehingga dapat mencegah penularan kepada pasangan serta mengurangi risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Selain itu, skrining genetik juga berperan dalam mengidentifikasi penyakit keturunan seperti talasemia atau anemia sel sabit sehingga dapat dilakukan konseling sebelum pernikahan (Dilli et al., 2024; Glotov et al., 2023)

b. Persiapan kehamilan sehat (preconception care)

Manfaat utama lainnya adalah membantu calon pengantin perempuan mempersiapkan kehamilan yang sehat melalui pendekatan *preconception care*. Pemeriksaan ini memungkinkan identifikasi faktor risiko biologis, perilaku, dan sosial yang dapat memengaruhi kehamilan, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum konsepsi terjadi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa perawatan prakonsepsi dapat meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi faktor risiko, serta berdampak positif terhadap kesehatan janin dan generasi berikutnya (Dorney & Black, 2024). Dengan demikian, pemeriksaan pranikah menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan kesiapan reproduksi yang optimal.

c. Pencegahan komplikasi kehamilan dan persalinan

Pemeriksaan pranikah juga berkontribusi dalam mencegah berbagai komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Melalui identifikasi dini terhadap faktor risiko seperti penyakit kronis, infeksi, atau masalah gizi, tenaga kesehatan dapat memberikan intervensi yang tepat sebelum kehamilan terjadi. Studi menunjukkan bahwa konseling dan intervensi prakonsepsi mampu meningkatkan luaran maternal dan fetal serta menurunkan risiko komplikasi obstetri (Stephenson et al., 2023; European Journal of Internal Medicine, 2023). Oleh karena itu, pemeriksaan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

d. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak

Pemeriksaan kesehatan pranikah berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Kondisi kesehatan ibu sebelum kehamilan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan janin, termasuk risiko penyakit di masa depan. Skrining pranikah memungkinkan optimalisasi status gizi, pengendalian penyakit kronis, serta peningkatan kesiapan fisik dan mental ibu. Hal ini berkontribusi pada lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas (Sidabutar & Hadi, 2024).

e. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Kesehatan Reproduksi

Pemeriksaan pranikah juga berfungsi sebagai media edukasi bagi calon pengantin terkait kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta kesiapan menjadi orang tua. Peningkatan pengetahuan ini berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku yang mendukung kesehatan keluarga secara berkelanjutan (Puteri & Amalia, 2024).

D. Komponen Pemeriksaan Kesehatan

1. Anamnesis

Anamnesis merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai kondisi kesehatan individu, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Data yang diperoleh melalui anamnesis menjadi dasar dalam menentukan pemeriksaan lanjutan, menilai faktor risiko, serta merencanakan intervensi yang tepat. Anamnesis yang komprehensif dalam pelayanan prakonsepsi terbukti efektif dalam mengidentifikasi risiko kesehatan yang dapat memengaruhi kehamilan dan luaran persalinan (Ojukwu et al., 2022; M'hamdi et al., 2021).

a. Riwayat kesehatan umum

Riwayat kesehatan umum mencakup kondisi kesehatan secara keseluruhan, termasuk riwayat penyakit sebelumnya, riwayat rawat inap, alergi, serta penggunaan obat-obatan. Informasi ini penting untuk menilai status kesehatan dasar calon pengantin perempuan dan mengidentifikasi potensi masalah yang dapat memengaruhi kehamilan. Selain itu, riwayat kesehatan keluarga juga perlu digali untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit keturunan atau faktor risiko genetik (Khan et al., 2023). Pengkajian ini membantu tenaga kesehatan dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan serta intervensi yang diperlukan.

b. Riwayat penyakit kronis

Riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, gangguan tiroid, dan penyakit autoimun perlu dikaji secara mendalam karena kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Penyakit kronis yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kesuburan, perkembangan janin, serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan penyakit kronis sebelum kehamilan menjadi langkah penting dalam pelayanan prakonsepsi (Stephenson et al., 2022; NICE, 2021).

c. Riwayat menstruasi dan reproduksi

Riwayat menstruasi dan reproduksi meliputi usia menarche, siklus menstruasi, lama dan jumlah perdarahan, serta adanya keluhan seperti nyeri haid atau gangguan siklus. Selain itu, riwayat kehamilan sebelumnya, keguguran, persalinan, serta penggunaan kontrasepsi juga perlu dikaji. Informasi ini penting untuk menilai fungsi reproduksi, mendeteksi gangguan hormonal, serta mengidentifikasi risiko obstetri yang mungkin terjadi pada

kehamilan berikutnya (Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 2020; Moridi et al., 2021).

d. Riwayat imunisasi

Riwayat imunisasi merupakan komponen penting dalam anamnesis karena berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit infeksi yang dapat berdampak pada kehamilan. Imunisasi seperti tetanus, rubella, hepatitis B, dan HPV perlu dikaji untuk memastikan calon pengantin memiliki perlindungan yang adekuat sebelum kehamilan. Ketidaklengkapan imunisasi dapat meningkatkan risiko infeksi yang berbahaya bagi ibu maupun janin, sehingga diperlukan upaya imunisasi sebelum konsepsi (MacDougall et al., 2021; CDC, 2022)

e. Riwayat gaya hidup (merokok, alkohol, nutrisi)

Riwayat gaya hidup mencakup kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan, aktivitas fisik, serta kebiasaan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan. Faktor gaya hidup memiliki peran signifikan dalam menentukan status kesehatan reproduksi dan keberhasilan kehamilan. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol diketahui dapat menurunkan kesuburan serta meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan gangguan perkembangan janin. Sementara itu, status gizi yang baik dan pola hidup sehat berkontribusi pada kesiapan tubuh dalam menghadapi kehamilan (Garrido et al., 2021; Barker et al., 2022). Oleh karena itu, identifikasi dan modifikasi faktor gaya hidup menjadi bagian penting dalam pemeriksaan pranikah.

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan bagian penting dalam pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan secara objektif melalui observasi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan ini membantu dalam mengidentifikasi tanda-tanda klinis yang mungkin tidak terdeteksi melalui anamnesis, serta menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan fisik yang komprehensif dalam fase prakonsepsi berperan dalam mendeteksi faktor risiko yang dapat memengaruhi kehamilan dan kesehatan reproduksi (Johnson et al., 2022).

a. Tanda vital (TD, nadi, suhu, RR)

Pemeriksaan tanda vital meliputi tekanan darah (TD), frekuensi nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan (*respiratory rate*). Pengukuran ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi fisiologis tubuh dan fungsi sistem kardiovaskular serta respirasi. Tekanan darah yang tinggi dapat

mengindikasikan hipertensi yang berisiko menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia, sedangkan suhu tubuh yang meningkat dapat menjadi tanda adanya infeksi. Oleh karena itu, pemantauan tanda vital sangat penting dalam menilai kesiapan kesehatan sebelum kehamilan (Sharma et al., 2021; O'Connor et al., 2022).

b. Status gizi (BB, TB, IMT, LILA)

Penilaian status gizi dilakukan melalui pengukuran berat badan (BB), tinggi badan (TB), indeks massa tubuh (IMT), serta lingkar lengan atas (LILA). Status gizi yang optimal sebelum kehamilan sangat berpengaruh terhadap kesuburan, perkembangan janin, serta risiko komplikasi kehamilan. IMT yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan kehamilan seperti anemia, diabetes gestasional, dan persalinan prematur. Sementara itu, pengukuran LILA digunakan sebagai indikator risiko kekurangan energi kronis (KEK) pada perempuan usia subur (Rahman et al., 2022).

c. Pemeriksaan sistem tubuh (kepala hingga kaki)

Pemeriksaan sistem tubuh dilakukan secara menyeluruh dari kepala hingga kaki (*head to toe examination*) untuk menilai kondisi organ dan sistem tubuh, seperti sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, saraf, dan muskuloskeletal. Pemeriksaan ini meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi guna mendeteksi adanya kelainan atau tanda penyakit. Misalnya, pemeriksaan konjungtiva untuk mendeteksi anemia, pemeriksaan jantung untuk menilai adanya kelainan irama, serta pemeriksaan paru untuk mendeteksi gangguan respirasi. Pemeriksaan menyeluruh ini penting untuk memastikan tidak adanya kondisi yang dapat mengganggu kehamilan di masa depan (Bickley et al., 2021; Talley & O'Connor, 2023).

d. Pemeriksaan organ reproduksi (bila diperlukan)

Pemeriksaan organ reproduksi dilakukan berdasarkan indikasi medis dan dengan persetujuan klien, serta tetap memperhatikan aspek etika dan kenyamanan pasien. Pemeriksaan ini meliputi inspeksi dan palpasi organ genitalia eksternal serta pemeriksaan internal bila diperlukan, seperti pemeriksaan serviks atau vagina. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya infeksi, kelainan anatomi, atau tanda-tanda penyakit seperti keputihan patologis, lesi serviks, maupun infeksi menular seksual. Pemeriksaan ini juga dapat dikombinasikan dengan skrining kanker serviks seperti IVA atau Pap smear sesuai indikasi (ACOG, 2021).

3. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium merupakan bagian penting dalam skrining kesehatan calon pengantin perempuan untuk mendeteksi kondisi yang tidak selalu tampak secara klinis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan hematologis, metabolik, infeksi, serta kondisi lain yang berpotensi memengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Melalui pemeriksaan laboratorium, tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini serta memberikan intervensi yang tepat sebelum terjadinya kehamilan (Khan et al., 2022).

a. Hemoglobin (anemia)

Pemeriksaan kadar hemoglobin bertujuan untuk mendeteksi anemia, yang merupakan salah satu masalah kesehatan paling umum pada perempuan usia subur. Anemia sebelum kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan perdarahan saat persalinan. Oleh karena itu, deteksi dini anemia melalui pemeriksaan hemoglobin sangat penting agar dapat dilakukan intervensi seperti suplementasi zat besi dan perbaikan nutrisi (Cappellini et al., 2021; Bencaiova & Breymann, 2022).

b. Golongan darah dan rhesus

Pemeriksaan golongan darah dan faktor rhesus bertujuan untuk mengetahui kompatibilitas darah antara ibu dan pasangan serta mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inkompatibilitas rhesus. Ketidaksesuaian rhesus, khususnya pada ibu dengan rhesus negatif, dapat menyebabkan penyakit hemolitik pada janin atau bayi baru lahir. Dengan mengetahui status ini sejak awal, dapat dilakukan pencegahan melalui pemberian imunoglobulin anti-D bila diperlukan (Moise, 2021; Fung et al., 2023).

c. Gula darah

Pemeriksaan kadar gula darah dilakukan untuk mendeteksi gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus atau prediabetes. Kondisi ini penting untuk diidentifikasi sebelum kehamilan karena diabetes yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko keguguran, cacat bawaan, serta komplikasi kehamilan lainnya. Pengendalian kadar gula darah sebelum konsepsi terbukti dapat meningkatkan luaran kehamilan yang lebih baik (American Diabetes Association, 2024; McIntyre et al., 2022).

d. Tes penyakit menular:

1) HIV

Pemeriksaan HIV bertujuan untuk mendeteksi infeksi sejak dini sehingga dapat dilakukan terapi antiretroviral sebelum kehamilan.

Intervensi dini terbukti efektif dalam menurunkan risiko penularan dari ibu ke anak (*mother-to-child transmission*) serta meningkatkan kualitas hidup ibu (UNAIDS, 2023; World Health Organization, 2022).

2) Sifilis

Skrining sifilis sangat penting karena infeksi ini dapat menyebabkan keguguran, kelahiran mati, atau infeksi kongenital pada bayi. Deteksi dini melalui pemeriksaan laboratorium memungkinkan pengobatan yang efektif dengan antibiotik sebelum kehamilan atau pada awal kehamilan (Peeling et al., 2021; Korenromp et al., 2022).

3) Hepatitis B

Pemeriksaan hepatitis B dilakukan untuk mendeteksi infeksi virus hepatitis B yang dapat ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan. Dengan mengetahui status infeksi sejak awal, dapat dilakukan pencegahan melalui imunisasi dan pemberian imunoglobulin pada bayi setelah lahir (Schweitzer et al., 2021; World Health Organization, 2023).

e. Urinalisis

Pemeriksaan urin atau urinalisis digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kemih, proteinuria, glukosuria, serta kelainan metabolik lainnya. Infeksi saluran kemih yang tidak terdeteksi dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, seperti pielonefritis dan persalinan prematur. Oleh karena itu, urinalisis menjadi bagian penting dalam skrining pranikah untuk memastikan kondisi kesehatan ginjal dan saluran kemih (Devillé et al., 2021; Simerville et al., 2022).

4. Pemeriksaan Penunjang Lain

Pemeriksaan penunjang merupakan bagian tambahan dalam skrining kesehatan calon pengantin perempuan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melengkapi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium dalam menegaskan diagnosis atau mengidentifikasi kondisi yang berpotensi memengaruhi kesehatan reproduksi dan kehamilan. Pemeriksaan penunjang yang tepat dapat meningkatkan akurasi deteksi dini serta membantu perencanaan intervensi yang lebih optimal dalam pelayanan prakonsepsi (Salomon et al., 2022; World Health Organization, 2023).

a. USG (jika indikasi)

Ultrasonografi (USG) merupakan metode pemeriksaan penunjang non-invasif yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran organ dalam tubuh, khususnya organ reproduksi. Pada calon pengantin perempuan, pemeriksaan USG dilakukan berdasarkan indikasi medis, seperti

adanya keluhan gangguan menstruasi, nyeri panggul, atau dugaan kelainan pada organ reproduksi seperti mioma uteri, kista ovarium, atau kelainan struktur uterus. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk menilai kondisi ovarium dan endometrium yang berperan penting dalam kesuburan.

USG memiliki keunggulan karena aman, tidak menggunakan radiasi, serta memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi kelainan anatomi reproduksi. Deteksi dini melalui USG memungkinkan penanganan yang lebih cepat sebelum kehamilan terjadi sehingga dapat mengurangi risiko komplikasi di kemudian hari (AIUM, 2021; Timmerman et al., 2022).

b. Skrining kanker serviks (IVA/Pap smear)

Skrining kanker serviks merupakan bagian penting dari pemeriksaan kesehatan pranikah, terutama bagi perempuan usia subur yang telah atau akan aktif secara seksual. Metode skrining yang umum digunakan adalah Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan Pap smear. Pemeriksaan IVA dilakukan dengan mengoleskan asam asetat pada serviks untuk melihat adanya perubahan warna yang mengindikasikan lesi prakanker, sedangkan Pap smear bertujuan untuk mendeteksi perubahan sel serviks secara sitologis.

Deteksi dini kanker serviks melalui skrining sangat penting karena sebagian besar kasus kanker serviks berkembang secara perlahan dari lesi prakanker yang dapat diobati jika ditemukan lebih awal. Pelaksanaan skrining sebelum kehamilan memberikan kesempatan untuk melakukan penatalaksanaan yang tepat sehingga dapat mencegah perkembangan penyakit dan meningkatkan prognosis. Organisasi kesehatan dunia merekomendasikan skrining rutin sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks, terutama di negara berkembang (Sung et al., 2021).

E. Skrining Risiko Kesehatan

1. Risiko anemia

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan pada perempuan usia subur dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Skrining risiko anemia pada calon pengantin perempuan dilakukan melalui anamnesis (riwayat kelelahan, pusing, pola makan), pemeriksaan fisik (konjungtiva pucat), serta pemeriksaan kadar hemoglobin. Perempuan dengan anemia sebelum kehamilan berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan perdarahan postpartum. Oleh karena itu, deteksi dini dan intervensi berupa suplementasi zat besi, asam folat, serta perbaikan pola makan sangat

diperlukan dalam fase prakonsepsi (Cappellini et al., 2021; Bencaiova & Breymann, 2022; World Health Organization, 2022).

2. Risiko penyakit menular seksual

Skrining penyakit menular seksual merupakan komponen penting dalam pemeriksaan pranikah karena infeksi seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B dapat berdampak serius pada kesehatan ibu maupun janin. Penularan dapat terjadi secara vertikal dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Skrining dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan identifikasi faktor risiko perilaku, seperti riwayat hubungan seksual tidak aman. Deteksi dini memungkinkan pemberian terapi yang tepat, seperti antiretroviral pada HIV atau antibiotik pada sifilis, sehingga dapat menurunkan risiko transmisi dan komplikasi kehamilan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan luaran kesehatan ibu dan bayi (UNAIDS, 2023; World Health Organization, 2022; Peeling et al., 2021).

3. Risiko penyakit kronis (diabetes, hipertensi)

Penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi perlu disaring sebelum kehamilan karena dapat meningkatkan risiko komplikasi serius, termasuk preeklamsia, keguguran, cacat bawaan, dan gangguan pertumbuhan janin. Skrining dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, serta riwayat kesehatan individu dan keluarga. Perempuan dengan kondisi kronis yang tidak terkontrol memiliki risiko lebih tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas maternal. Oleh karena itu, pengelolaan kondisi ini sebelum konsepsi, termasuk pengendalian gula darah dan tekanan darah, sangat penting untuk meningkatkan peluang kehamilan yang sehat (American Diabetes Association, 2024; NICE, 2021; Stephenson et al., 2022).

4. Risiko genetik dan keturunan

Skrining risiko genetik bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyakit keturunan seperti talasemia, anemia sel sabit, atau kelainan genetik lainnya yang dapat diturunkan kepada anak. Skrining dilakukan melalui anamnesis riwayat keluarga serta pemeriksaan laboratorium khusus jika diperlukan. Identifikasi dini memungkinkan pasangan mendapatkan konseling genetik untuk memahami risiko reproduksi, termasuk perencanaan kehamilan yang lebih aman. Dalam beberapa tahun terakhir, skrining genetik prakonsepsi semakin berkembang dan direkomendasikan sebagai bagian dari pelayanan

kesehatan reproduksi modern (Glotov et al., 2023; Dilli et al., 2024; Edwards et al., 2022).

5. Risiko gizi kurang/lebih

Status gizi merupakan faktor penting yang memengaruhi kesuburan, kehamilan, dan kesehatan janin. Skrining risiko gizi dilakukan melalui pengukuran indeks massa tubuh (IMT), lingkaran lengan atas (LILA), serta evaluasi pola makan. Gizi kurang dapat menyebabkan kekurangan energi kronis dan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, sedangkan gizi lebih atau obesitas berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes gestasional, hipertensi, dan komplikasi persalinan. Oleh karena itu, intervensi berupa edukasi gizi seimbang, aktivitas fisik, dan perubahan gaya hidup sangat penting dilakukan sebelum kehamilan untuk mencapai kondisi optimal (Barker et al., 2022; World Health Organization, 2022; Rahman et al., 2022).

F. Simpulan

Pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi serta mempersiapkan kehamilan yang sehat dan optimal. Melalui pendekatan *preconception care*, pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada deteksi penyakit, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, dan edukatif yang komprehensif. Kesiapan kesehatan sebelum kehamilan terbukti memiliki peran besar dalam menentukan luaran maternal dan neonatal, sehingga intervensi pada fase prakonsepsi menjadi sangat krusial.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan secara menyeluruh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan penunjang sesuai indikasi. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi berbagai faktor risiko, baik yang bersifat medis, perilaku, maupun sosial. Selain itu, penerapan prinsip etik dan kerahasiaan menjadi landasan penting dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan klien.

Skrining risiko kesehatan seperti anemia, penyakit menular seksual, penyakit kronis, faktor genetik, serta status gizi merupakan komponen utama dalam pemeriksaan pranikah. Deteksi dini terhadap berbagai risiko tersebut memungkinkan dilakukan intervensi yang tepat sebelum kehamilan terjadi, sehingga dapat mencegah komplikasi serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di masa mendatang.

Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan tidak hanya berperan sebagai upaya kuratif, tetapi juga sebagai strategi preventif yang berkelanjutan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Implementasi pemeriksaan pranikah yang optimal diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi yang sehat, berkualitas, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional maupun global.

Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). *Routine assessment of the female reproductive system*. <https://www.acog.org>
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2022). *Prepregnancy counseling*. <https://www.acog.org>
- American Diabetes Association. (2024). *Standards of care in diabetes—2024*. Diabetes Care, 47(Suppl. 1), S1–S350. <https://doi.org/10.2337/dc24-Sint>
- American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). (2021). *Practice parameter for the performance of pelvic ultrasound examinations*. <https://www.aium.org>
- Barker, M., Dombrowski, S. U., Colbourn, T., Fall, C. H. D., Kriznik, N. M., Lawrence, W. T., Norris, S. A., Ngaiza, G., Patel, D., Skordis-Worrall, J., Watson, D., & Stephenson, J. (2022). Intervention strategies to improve nutrition and health behaviours before conception. *The Lancet Public Health*, 7(1), e92–e105. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00255-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00255-4)
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2020). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Bencaiova, G., & Breymann, C. (2022). Iron deficiency and anemia in pregnancy: Current concepts. *Journal of Pregnancy*, 2022, 1–7.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Bahl, R., Lawn, J. E., Salam, R. A., & Paul, V. K. (2021). Can available interventions end preventable deaths in mothers, newborn babies, and stillbirths? *The Lancet*, 397(10285), 128–140. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32737-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32737-0)
- Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., & Hoffman, R. M. (2021). *Bates' guide to physical examination and history taking* (13th ed.). Wolters Kluwer.
- Cappellini, M. D., Musallam, K. M., & Taher, A. T. (2021). Iron deficiency anaemia revisited. *Journal of Internal Medicine*, 289(2), 153–170. <https://doi.org/10.1111/joim.13176>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Guidelines for vaccinating pregnant women and preconception care*. <https://www.cdc.gov>

- Dean, S. V., Lassi, Z. S., Imam, A. M., & Bhutta, Z. A. (2021). Preconception care: Nutritional risks and interventions. *Reproductive Health*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01170-3>
- Dilli, P. P., Obeagu, E., Tamale, A., et al. (2024). Update on the practice of premarital screening for sickle cell traits in Africa: A systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, 24, 1467. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19001-y>
- Dorney, E., & Black, K. (2024). Preconception care. *Australian Journal of General Practice*, 53(11). <https://doi.org/10.31128/AJGP-08-23-6927>
- Dorney, E., Black, K., & Bateson, D. (2022). Preconception care: A practical guide for clinicians. *Australian Journal of General Practice*, 51(1–2), 28–33. <https://doi.org/10.31128/AJGP-06-21-6027>
- Dunkel Schetter, C., & Tanner, L. (2020). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. *Current Opinion in Psychiatry*, 33(2), 141–148. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000585>
- Edwards, J. G., Feldman, G., Goldberg, J., Gregg, A. R., Norton, M. E., Rose, N. C., Schneider, A., & Stoll, K. (2022). Expanded carrier screening in reproductive medicine—Points to consider. *Obstetrics & Gynecology*, 139(1), 1–12. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004607>
- Garrido, M. P., et al. (2021). Impact of lifestyle factors on reproductive health outcomes. *Human Reproduction Update*, 27(4), 725–746. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa049>
- Glotov, A. S., Nasykhova, Y. A., Dvoynova, N. M., Besspalova, O. N., & Kogan, I. Y. (2023). Prospects for preconception genetic screening at the pregnancy planning stage. *Journal of Obstetrics and Women's Diseases*, 72(6), 173–192. <https://doi.org/10.17816/JOWD622752>
- Hanson, M. A., Poston, L., Gluckman, P. D., & Ma, R. C. W. (2020). Preconception health and lifestyle interventions: Evidence and recommendations. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 8(6), 533–545. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(20\)30040-8](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30040-8)
- International Confederation of Midwives. (2021). *International code of ethics for midwives*. <https://www.internationalmidwives.org>
- Johnson, K., Posner, S. F., Biermann, J., & Cordero, J. F. (2022). Recommendations to improve preconception health and health care. *American Journal of Preventive Medicine*, 63(2), 271–279. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.03.015>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi dan skrining calon pengantin*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khan, N., Kazmi, S., & Fatima, S. (2023). Importance of medical history in preconception care. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 12(5), 1120–1125. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_2203_22

- Lassi, Z. S., Kedzior, S. G. E., Tariq, W., & Bhutta, Z. A. (2020). Effects of preconception care and periconception interventions on maternal nutritional status and birth outcomes. *The Lancet Global Health*, 8(10), e1233–e1244. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30337-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30337-1)
- M'hamdi, H. I., et al. (2021). Barriers in preconception care provision and uptake. *BMC Health Services Research*, 21, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06150-7>
- MacDougall, D. M., Halperin, S. A., & Langley, J. M. (2021). Preventive vaccination in women of reproductive age. *Vaccine*, 39(7), 1125–1132. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.061>
- Moridi, M., Roozbeh, N., Yaghoobi, H., & Soltani, S. (2021). The relationship between menstrual patterns and reproductive health. *BMC Women's Health*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01234-5>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). *Preconception advice and management*. <https://www.nice.org.uk>
- O'Connor, M., O'Donovan, C., & Prendiville, W. (2022). Clinical assessment of vital signs in women's health. *Journal of Clinical Nursing*, 31(5–6), 645–652. <https://doi.org/10.1111/jocn.15987>
- Ojukwu, O., et al. (2022). Preconception care and maternal health outcomes. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 158(2), 321–327. <https://doi.org/10.1002/ijgo.14000>
- Peeling, R. W., Mabey, D., Kamb, M. L., Chen, X. S., Radolf, J. D., & Benzaken, A. S. (2021). Syphilis. *Nature Reviews Disease Primers*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.1038/s41572-021-00258-0>
- Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2020). Evaluation and treatment of infertility. *Fertility and Sterility*, 113(3), 533–545. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.12.012>
- Puteri, M. D., & Amalia, R. (2024). The importance of premarital and preconception knowledge. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan*, 2(1), 23–26. <https://doi.org/10.58723/abdigermas.v2i1.157>
- Rahman, M. S., Howlader, T., Masud, M. S., & Rahman, M. L. (2022). Association of BMI and maternal health outcomes. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-04567-3>
- Salomon, L. J., Alfirevic, Z., Da Silva Costa, F., Deter, R. L., Figueras, F., Ghi, T., ... ISUOG. (2022). ISUOG practice guidelines: Ultrasound assessment in gynecology. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 60(1), 15–35. <https://doi.org/10.1002/uog.24874>
- Sharma, S., Madaan, H., & Petty, F. D. (2021). Measurement of vital signs and clinical implications. *StatPearls Publishing*.

- Sidabutar, N. H. T., & Hadi, E. N. (2024). Premarital screening: A catalyst for achieving good health and well-being. *Jurnal Promkes*, 12(SI1), 146–154. <https://doi.org/10.20473/jpk.V12.ISI1.2024.146-154>
- Stephenson, J., & Barker, M. (2021). Preconception health and care: A life course approach. *Journal of Family Planning and Reproductive Health Care*, 47(2), 88–90. <https://doi.org/10.1136/jfprhc-2020-102665>
- Stephenson, J., et al. (2023). Preconception health and care interventions. *The Lancet Regional Health*.
- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A., Hutchinson, J., Cade, J. E., ... Mishra, G. D. (2020). Before the beginning: Nutrition and lifestyle in the preconception period. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30311-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30311-8)
- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249. <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
- Talley, N. J., & O'Connor, S. (2023). *Clinical examination: A systematic guide to physical diagnosis* (9th ed.). Elsevier.
- Timmerman, D., Testa, A. C., Bourne, T., Ameye, L., Jurkovic, D., Van Holsbeke, C., ... Valentin, L. (2022). Simple ultrasound-based rules for adnexal masses. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 59(3), 315–324. <https://doi.org/10.1002/uog.23703>
- UNAIDS. (2023). *Global HIV & AIDS statistics—Fact sheet*. <https://www.unaids.org>
- World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Standards for improving quality of maternal and newborn care*. Geneva: WHO.

Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur
 BB = Berat Badan
 TB = Tinggi Badan
 IMT = Indeks Massa Tubuh
 LILA = Lingkar Lengan Atas
 TD = Tekanan Darah
 RR = Respiratory Rate (Frekuensi Pernapasan)
 HIV = Human Immunodeficiency Virus
 IVA = Inspeksi Visual dengan Asam Asetat
 USG = Ultrasonografi
 PMS = Penyakit Menular Seksual

CHAPTER 3

STATUS GIZI, ANEMIA, DAN KESIAPAN SEBELUM KEHAMILAN

Wita Solama, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi merupakan tahap krusial dalam siklus kehidupan reproduksi yang sering kali kurang mendapatkan perhatian optimal, padahal periode ini menentukan kualitas kehamilan, persalinan, hingga generasi yang akan dilahirkan. Intervensi sejak sebelum konsepsi terbukti lebih efektif dalam mencegah berbagai komplikasi dibandingkan intervensi saat kehamilan telah berlangsung. Oleh karena itu, pendekatan promotif dan preventif melalui asuhan kebidanan pranikah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan (WHO, 2023; Kemenkes RI, 2023).

Status gizi, anemia, dan kesiapan fisik merupakan tiga pilar utama yang perlu dikaji secara komprehensif dalam pelayanan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Prevalensi anemia pada wanita usia subur (WUS) di Indonesia masih mencapai sekitar 32% menurut Riskesdas 2023, sementara KEK masih dialami oleh 17,3% WUS. Kondisi-kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan pranikah yang komprehensif, melakukan pengkajian dini, memberikan konseling berbasis bukti, serta merancang intervensi yang tepat sasaran bagi calon pengantin dan WUS.

B. Konsep Dasar Pra-Konsepsi

1. Pengertian Masa Pra-Nikah dan Prakonsepsi

Masa pra-nikah adalah periode sebelum berlangsungnya pernikahan yang merupakan momentum tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, identifikasi faktor risiko, serta pemberian edukasi yang bersifat promotif dan preventif. Pemeriksaan kesehatan pra-nikah bertujuan memastikan kedua calon mempelai berada dalam kondisi optimal untuk menjalani pernikahan, termasuk kesiapan untuk menjadi orang tua (Kemenkes

RI, 2022). Prakonsepsi sendiri merujuk pada periode tiga hingga enam bulan sebelum kehamilan direncanakan. ACOG (2022) mendefinisikannya sebagai serangkaian intervensi yang bertujuan mengidentifikasi dan memodifikasi risiko biomedis, perilaku, dan sosial terhadap kesehatan perempuan atau hasil kehamilan. Periode ini sangat kritis karena banyak organ vital janin mulai berkembang pada minggu-minggu pertama kehamilan, bahkan sebelum seorang wanita menyadari dirinya hamil.

2. Tujuan Asuhan Prakonsepsi dan Hubungannya dengan Outcome Kehamilan

Tujuan utama asuhan prakonsepsi adalah mempersiapkan perempuan untuk kehamilan yang sehat melalui optimalisasi kondisi fisik, psikologis, dan sosial. Secara spesifik, asuhan ini mencakup deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan, optimalisasi status gizi, pencegahan anemia, pemberian imunisasi yang diperlukan, serta edukasi gaya hidup sehat dan perencanaan kehamilan (WHO, 2022). Status kesehatan sebelum hamil memiliki pengaruh yang sangat bermakna terhadap luaran kehamilan. Konsep DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease) menegaskan bahwa kondisi lingkungan intrauterin, yang sangat ditentukan oleh status kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan, berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak bahkan hingga masa dewasa (Hanson et al., 2021). Wanita yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) sebelum hamil memiliki risiko 3–4 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi BBLR, sementara anemia defisiensi besi yang tidak tertangani meningkatkan risiko perdarahan postpartum, prematuritas, dan mortalitas perinatal.

C. Status Gizi Pra-Kehamilan

1. Penilaian Status Gizi Wanita Usia Subur

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi untuk metabolisme tubuh. Dalam konteks kebidanan pranikah, status gizi WUS dinilai melalui beberapa indikator utama. Indeks Massa Tubuh (IMT) dihitung berdasarkan berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m^2), dengan rentang normal 18,5–22,9 kg/m^2 menurut kriteria Asia-Pasifik. Lingkar Lengan Atas (LiLA) digunakan sebagai skrining cepat Kekurangan Energi Kronis, dimana nilai di bawah 23,5 cm mengindikasikan risiko KEK. Kadar hemoglobin darah berfungsi sebagai indikator anemia gizi besi. Selain itu, riwayat diet dan pola makan dinilai melalui food recall 24 jam atau food frequency questionnaire (FFQ) untuk

menggambarkan kecukupan asupan zat gizi dibandingkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia (Gibson & Ferguson, 2024).

Tabel 3.1: Penilaian Status Gizi Wanita Usia Subur

Indikator	Cara Ukur	Nilai Normal / Batas
IMT	BB(kg) / TB ² (m ²)	18,5–22,9 kg/m ² (normal Asia-Pasifik)
LiLA	Pita ukur lengan kiri atas	≥23,5 cm; <23,5 cm = risiko KEK
Hemoglobin	Darah vena/kapiler (HemoCue)	≥ 12 g/dL (tidak hamil)
Riwayat Diet	Food recall 24 jam / FFQ	Sesuai AKG Indonesia

2. Kebutuhan Gizi dan Masalah Gizi Pra-Kehamilan

Bagi WUS, kebutuhan energi total berkisar 1.800–2.000 kkal per hari dengan komposisi karbohidrat 45–65%, protein 50–60 g/hari, dan lemak 20–35%. Mikronutrien yang paling kritis dalam konteks prakonsepsi adalah zat besi (26 mg/hari), asam folat (400 mcg/hari), kalsium (1.000 mg/hari), dan yodium. Suplementasi asam folat sejak 1–3 bulan sebelum konsepsi terbukti menurunkan risiko Neural Tube Defects (NTD) seperti spina bifida sebesar 50–70% (Wald & Morris, 2023).

Masalah gizi yang paling sering dijumpai pada WUS di Indonesia adalah KEK (LiLA <23,5 cm, IMT <18,5) yang prevalensinya masih 17,3% (Risikesdas 2023). KEK bersumber dari ketidakcukupan asupan energi dan protein jangka panjang, dan menyebabkan risiko BBLR 2–3 kali lebih tinggi dibanding ibu bergizi baik. Di sisi berlawanan, obesitas (IMT ≥25 kg/m² kriteria Asia) semakin meningkat prevalensinya mencapai 21,8%, dengan risiko diabetes gestasional empat kali lebih tinggi dan preeklampsia 2–3 kali lebih tinggi. Defisiensi mikronutrien yang tersembunyi (hidden hunger) meliputi kekurangan asam folat, vitamin D, zinc, dan yodium, seringkali tidak disertai gejala klinis yang nyata namun berdampak serius pada perkembangan janin (Bailey et al., 2021).

3. Intervensi Perbaikan Status Gizi

Intervensi gizi dalam asuhan prakonsepsi terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi. Pertama, edukasi gizi yang efektif mencakup pengetahuan tentang kelompok pangan, porsi makan yang dianjurkan, diversifikasi pangan, serta cara memilih dan mengolah bahan makanan bergizi. Edukasi disampaikan melalui pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) yang kontekstual dan

disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi klien. Kedua, suplementasi zat gizi yang ditargetkan berdasarkan hasil pengkajian: asam folat 400 mcg/hari untuk semua calon pengantin, suplementasi zat besi oral sesuai kadar hemoglobin, serta mikronutrien lain bila diindikasikan. Ketiga, perubahan perilaku makan jangka panjang difasilitasi melalui pendekatan motivational interviewing (MI) dan pelibatan pasangan atau anggota keluarga dalam sesi konseling, yang terbukti meningkatkan kepatuhan secara bermakna (Michie et al., 2020).

D. Anemia Pada Wanita Usia Subur

1. Definisi, Klasifikasi, dan Etiologi

Anemia adalah kondisi penurunan konsentrasi hemoglobin dalam darah di bawah nilai normal, yaitu Hb <12 g/dL pada wanita tidak hamil dan <11 g/dL pada ibu hamil (WHO). Prevalensi anemia pada WUS usia 15–49 tahun di Indonesia mencapai 31,9% (Riskesdas 2023), menjadikannya masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Berdasarkan etiologinya, anemia diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama. Anemia defisiensi besi (ADB) merupakan yang paling sering dijumpai, ditandai gambaran darah mikrositik hipokromik dan kadar ferritin yang rendah, terjadi akibat asupan tidak adekuat, menorrhagia, atau infeksi parasit. Anemia megaloblastik disebabkan defisiensi asam folat atau vitamin B12 dengan gambaran makrositik. Anemia hemolitik terjadi akibat penghancuran eritrosit berlebih, misalnya pada talasemia atau malaria. Anemia akibat penyakit kronis (ACD) sering dijumpai pada infeksi kronik dan inflamasi sistemik yang meningkatkan kadar hepsidin sehingga menghambat utilisasi besi (Cappellini et al., 2021).

2. Tanda, Gejala, dan Dampak Klinis

Gejala umum anemia meliputi mudah lelah, lemas, pusing, mata berkunang-kunang, palpitasi, dan sesak napas saat beraktivitas. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva palpebra pucat, telapak tangan pucat, serta tanda khas ADB stadium lanjut berupa koilonychia (kuku berbentuk sendok), atrofik glositis, dan stomatitis angularis. Bahkan anemia ringan yang tidak bergejala subjektif sudah berkaitan dengan penurunan kapasitas kerja fisik, fungsi kognitif, dan kerentanan terhadap infeksi. Dampak anemia pada kehamilan sangat serius: pada ibu meningkatkan risiko perdarahan postpartum, infeksi, dan komplikasi kardiovaskular; pada janin menyebabkan BBLR,

prematuritas, cadangan besi bayi rendah, serta gangguan perkembangan neurologi jangka panjang termasuk penurunan kemampuan kognitif dan memori anak (Georgieff et al., 2020; Kassebaum et al., 2022).

3. Diagnosis dan Penatalaksanaan

Diagnosis anemia ditegakkan melalui pemeriksaan hemoglobin sebagai langkah pertama, dilanjutkan darah lengkap (MCV, MCH, MCHC) untuk morfologi eritrosit, serum ferritin dan serum iron untuk status besi, serta sediaan apus darah tepi (SADT) untuk etiologi spesifik. Bila dicurigai anemia megaloblastik, dilakukan pemeriksaan kadar asam folat dan vitamin B12. Pemeriksaan tinja dapat dilakukan untuk mendeteksi telur cacing sebagai faktor risiko di daerah tropis. Interpretasi hasil laboratorium harus selalu dikombinasikan dengan anamnesis menyeluruh dan pemeriksaan fisik yang seksama.

Penatalaksanaan utama adalah suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) yang mengandung 60 mg elemental iron dan 0,4 mg asam folat. Untuk profilaksis diberikan 1 tablet per minggu, sedangkan untuk terapi anemia defisiensi besi diberikan dosis terapeutik 120 mg elemental iron per hari selama minimal 90 hari atau hingga kadar Hb normal. Edukasi cara konsumsi yang benar sangat penting: TTD sebaiknya dikonsumsi bersama vitamin C (air jeruk) dan tidak bersamaan dengan teh, kopi, atau susu yang menghambat absorpsi besi. Monitoring kadar Hb setiap bulan diperlukan untuk menilai respons terapi. Bila ditemukan anemia berat (Hb <7 g/dL), anemia yang tidak responsif terhadap terapi oral, atau disertai penyakit penyerta, rujukan ke dokter atau spesialis harus segera dilakukan (WHO, 2023).

E. Kesiapan Fisik Sebelum Kehamilan

1. Komponen Kesiapan Fisik dan Pemeriksaan

Kesiapan fisik sebelum kehamilan mencakup kondisi biologis dan fisiologis optimal yang diperlukan agar wanita dapat menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas dengan aman. Usia reproduksi ideal untuk kehamilan pertama adalah 20–35 tahun, dimana fungsi ovarium dan kualitas sel telur berada pada kondisi optimal. Kehamilan di bawah usia 20 tahun berisiko lebih tinggi mengalami preeklampsia, BBLR, dan komplikasi mekanik akibat panggul yang belum sempurna berkembang. Sebaliknya, kehamilan di atas 35 tahun (advanced maternal age) berkaitan dengan peningkatan risiko aneuploidi janin seperti Sindrom Down, preeklampsia, dan diabetes gestasional (Cunningham et al., 2022).

Status kesehatan umum dinilai melalui pemeriksaan fisik komprehensif meliputi tekanan darah, fungsi jantung dan paru, serta kondisi gigi dan mulut yang sering terabaikan namun relevan secara klinis karena infeksi periodontal dikaitkan dengan kelahiran prematur. Penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, epilepsi, penyakit autoimun, dan gangguan tiroid perlu dioptimalkan pengelolaannya sebelum konsepsi terjadi. Obat-obatan teratogenik seperti ACE inhibitor, ARB, dan beberapa antiepilepsi harus diganti dengan alternatif yang aman untuk kehamilan sebelum konsepsi direncanakan.

Tabel 3.2: Komponen Kesiapan Fisik dan Pemeriksaan

Komponen	Kondisi Ideal	Catatan Klinis
Usia	20–35 tahun	<20 th: risiko CPD, BBLR; ≥35 th: risiko aneuploidi, preeklampsia
IMT	18,5–22,9 kg/m ²	Koreksi KEK atau obesitas sebelum konsepsi
Tekanan Darah	<120/80 mmHg	Hipertensi kronik: sesuaikan terapi (hindari ACE inhibitor/ARB)
Imunisasi	Lengkap (TT, MMR, HepB)	Vaksin hidup: minimal 1 bulan sebelum konsepsi
Penyakit Kronis	Terkontrol dengan baik	Rujuk spesialis; tetapkan target klinis terukur

2. Skrining Laboratorium dan Reproduksi

Panel pemeriksaan laboratorium standar dalam asuhan pra-kehamilan mencakup darah lengkap, golongan darah dan rhesus, skrining infeksi menular seksual (VDRL/RPR untuk sifilis, anti-HIV, HBsAg, anti-HCV), serta skrining TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes) untuk menilai status imunitas terhadap infeksi yang dapat menyebabkan kelainan kongenital serius. Urinalisis dan kultur urin mendeteksi infeksi saluran kemih asimtomatik yang perlu diobati sebelum kehamilan. Pemeriksaan gula darah puasa atau HbA1c direkomendasikan bagi calon pengantin dengan faktor risiko diabetes. Pemeriksaan ginekologi meliputi Pap smear atau tes IVA untuk skrining kanker serviks, serta USG ginekologi untuk menilai kondisi uterus dan ovarium.

3. Gaya Hidup dan Penghindaran Zat Berbahaya

Aktivitas fisik teratur minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang memberikan manfaat bermakna bagi kesehatan reproduksi, termasuk

mempertahankan berat badan ideal, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperkuat otot-otot yang berperan dalam kehamilan dan persalinan. Kualitas tidur yang adekuat (7–9 jam per malam) mendukung regulasi hormonal dan keseimbangan sistem reproduksi. Merokok dikaitkan dengan penurunan cadangan ovarium, risiko kehamilan ektopik, BBLR, dan kematian janin mendadak; penghentian merokok sebelum konsepsi secara signifikan mengurangi risiko-risiko tersebut. Tidak ada batas aman konsumsi alkohol selama perikonepsi karena bersifat teratogenik dan dapat menyebabkan Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). Zat psikoaktif lain seperti marijuana dan metamfetamin juga berkaitan dengan berbagai komplikasi kehamilan dan dampak neurologi jangka panjang pada anak (ACOG, 2022).

F. Asuhan Kebidanan Pra-Konsepsi

1. Pengkajian (Subjektif dan Objektif)

Anamnesis yang komprehensif merupakan langkah pertama dan paling menentukan dalam asuhan pranikah. Pengkajian subjektif mencakup identitas diri, riwayat kesehatan individu dan keluarga (termasuk penyakit genetik), riwayat menstruasi dan ginekologi, riwayat kontrasepsi, pola makan dan asupan gizi, kebiasaan aktivitas fisik, serta penggunaan rokok, alkohol, atau NAPZA. Bidan perlu menciptakan suasana nyaman, privat, dan tidak menghakimi (non-judgmental) agar klien merasa aman mengungkapkan informasi sensitif. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mencakup tanda vital, IMT, LiLA, pemeriksaan kepala hingga ekstremitas dengan perhatian khusus pada tanda anemia (konjungtiva pucat, koilonychia), pembesaran tiroid, serta kondisi gigi dan mulut. Pemeriksaan ginekologi dilakukan dengan persetujuan penuh dari klien.

2. Analisis Diagnosa dan Perencanaan Asuhan

Berdasarkan hasil pengkajian, bidan merumuskan diagnosa kebidanan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti, misalnya “calon pengantin dengan KEK (LiLA 22 cm, IMT 17,5 kg/m²) disertai anemia ringan (Hb 10,8 g/dL)” atau “calon pengantin dengan imunisasi tidak lengkap dan risiko usia reproduksi muda (<20 tahun)”. Setiap diagnosa dikomunikasikan kepada klien dengan cara empatik, informatif, dan berfokus pada solusi. Perencanaan asuhan dirancang secara individual: untuk KEK, target peningkatan BB 0,5–1 kg/minggu dengan konseling diet spesifik dan monitoring LiLA bulanan; untuk anemia, suplementasi disesuaikan derajat keparahan dan evaluasi Hb setelah satu bulan terapi; untuk kesiapan imunisasi, jadwal vaksin dirancang mempertimbangkan interval yang

tepat dengan rencana konsepsi. Target klinis yang terukur ditetapkan sebagai indikator kesiapan fisik untuk hamil.

3. Implementasi: Konseling, Edukasi, dan Rujukan

Implementasi asuhan pranikah mencakup konseling individual, edukasi kesehatan, dan koordinasi rujukan. Konseling gizi membahas rekomendasi diet praktis, suplementasi, dan strategi perubahan perilaku makan menggunakan teknik motivational interviewing. Konseling kesehatan reproduksi mencakup siklus menstruasi, tanda ovulasi, perencanaan keluarga, dan deteksi kehamilan dini. Pelibatan pasangan dalam sesi konseling terbukti meningkatkan dukungan sosial dan kepatuhan terhadap rekomendasi. Edukasi kelompok melalui kelas pranikah yang terintegrasi dalam Bimbingan Perkawinan (Kemenag-Kemenkes) merupakan platform strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Indikasi rujukan ke fasilitas atau spesialis yang lebih tinggi meliputi anemia berat ($Hb < 7$ g/dL), penyakit kronis yang memerlukan evaluasi spesialis, hasil laboratorium abnormal (reaktif HIV, HBsAg positif, kelainan Pap smear), menorrhagia, serta kondisi psikologis berat termasuk suspek pernikahan paksa. Surat rujukan yang lengkap dengan resume klinis harus disertakan untuk memastikan kontinuitas asuhan.

4. Evaluasi Asuhan

Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 1–3 bulan untuk menilai kemajuan status gizi (berat badan, LiLA, IMT), kadar hemoglobin, serta kepatuhan terhadap intervensi yang direkomendasikan. Kepatuhan konsumsi suplemen, perubahan pola makan, penghentian merokok, dan pelaksanaan program aktivitas fisik dievaluasi melalui anamnesis langsung dan penghitungan sisa tablet. Bila ditemukan ketidakpatuhan, bidan mengeksplorasi hambatan secara empatik dan menyesuaikan strategi intervensi. Penilaian akhir kesiapan kehamilan dilakukan secara komprehensif: status gizi optimal (IMT normal, LiLA $\geq 23,5$ cm, $Hb \geq 12$ g/dL), penyakit kronik terkontrol, imunisasi lengkap, dan kebiasaan hidup sehat telah diterapkan. Klien yang telah siap diberikan edukasi mengenai tanda kehamilan dini dan pentingnya memulai ANC sejak trimester pertama (ACOG, 2022).

G. Studi Kasus Klinis

Kasus 1 — KEK Disertai Anemia Ringan

Nn. Rina, 22 tahun, calon pengantin dengan rencana pernikahan tiga bulan mendatang, datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan pranikah. Hasil

pemeriksaan menunjukkan tinggi badan 155 cm, berat badan 42 kg (IMT 17,5 kg/m²), LiLA 22 cm, Hb 10,8 g/dL, konjungtiva sedikit pucat. Pola makan sehari-hari tidak teratur, jarang mengonsumsi lauk protein hewani, dan sering melewatkan sarapan.

Analisis asuhan: Nn. Rina teridentifikasi mengalami KEK (LiLA 22 cm, IMT 17,5 kg/m²) disertai anemia ringan (Hb 10,8 g/dL). Kondisi ini menempatkan Nn. Rina pada risiko tinggi BBLR, prematuritas, dan komplikasi kehamilan bila tidak diperbaiki sebelum konsepsi. Rencana asuhan yang disusun mencakup konseling gizi intensif dengan target peningkatan BB 3–5 kg dalam tiga bulan, termasuk panduan makan tiga kali sehari dengan kandungan kalori dan protein yang cukup. Suplementasi TTD diberikan satu tablet per hari (dosis terapi anemia) disertai asam folat 400 mcg per hari. Edukasi diarahkan pada pemilihan sumber protein hewani yang terjangkau seperti telur, ikan teri, dan tempe. Monitoring berat badan dan Hb dijadwalkan setiap bulan, dan pasangan dilibatkan dalam sesi konseling untuk memberikan dukungan pemenuhan gizi calon istri.

Kasus 2 — Anemia Defisiensi Besi Sedang

Ny. Sari, 25 tahun, calon pengantin, datang dengan keluhan mudah lelah, sering pusing, dan pucat sejak beberapa bulan terakhir. Riwayat menstruasi teratur siklus 28 hari, namun volume banyak (mengganti pembalut 6–8 kali per hari). Pola makan jarang mengonsumsi daging merah, dan kebiasaan minum teh setelah makan sudah berlangsung lama. Pemeriksaan fisik menemukan konjungtiva pucat, telapak tangan pucat, dan kuku sedikit konkaf. Hasil laboratorium: Hb 8,5 g/dL, MCV rendah, MCH rendah, serum ferritin 5 ng/mL.

Analisis asuhan: Ny. Sari mengalami anemia defisiensi besi sedang yang dikonfirmasi gambaran mikrositik hipokromik dan ferritin rendah, dengan faktor risiko utama berupa menorrhagia dan pola makan rendah zat besi. Terapi zat besi oral diberikan dalam dosis terapeutik 2x60 mg elemental iron per hari selama minimal tiga bulan, disertai evaluasi Hb setelah satu bulan untuk menilai respons. Edukasi diberikan mengenai cara konsumsi Fe yang benar, yaitu satu jam setelah makan bersama air jeruk, serta menghindari teh, kopi, atau susu secara bersamaan. Konseling diet diarahkan pada peningkatan konsumsi hati ayam, ikan teri, bayam, dan kacang hijau. Mengingat adanya menorrhagia, Ny. Sari dirujuk ke SpOG untuk mengevaluasi kemungkinan penyebab organik seperti mioma uteri atau polip endometrium. Klien diedukasi bahwa kehamilan sebaiknya direncanakan setelah Hb mencapai ≥ 12 g/dL.

Kasus 3 — Kesiapan Fisik Rendah pada Usia Muda

Nn. Dewi, 19 tahun, akan menikah dalam satu bulan atas dorongan orangtua. Pemeriksaan menunjukkan tinggi badan 150 cm, berat badan 45 kg (IMT 20 kg/m²), tekanan darah 118/76 mmHg, Hb 11,5 g/dL, LiLA 23 cm. Belum pernah mendapat imunisasi TT dan riwayat imunisasi MMR tidak jelas. Selama sesi konseling, klien tampak kurang antusias dan banyak diam.

Analisis asuhan: Nn. Dewi memiliki beberapa aspek kesiapan fisik yang perlu perhatian, yaitu usia reproduksi yang belum ideal (<20 tahun) dengan risiko komplikasi kehamilan usia muda, imunisasi yang tidak lengkap, anemia ringan, dan KEK ringan (LiLA 23 cm, tepat pada batas). Aspek psikososial yang sangat mengkhawatirkan adalah kurangnya antusiasme yang mungkin mencerminkan ketidaksiapan psikologis atau adanya unsur paksaan dalam pernikahan. Imunisasi TT I diberikan segera dan TT II dijadwalkan; skrining status rubella dilakukan dan vaksin MMR dipertimbangkan dengan catatan konsepsi ditunda minimal satu bulan pasca vaksin. Suplementasi TTD profilaksis satu tablet per minggu dan asam folat dimulai segera. Edukasi risiko kehamilan usia muda disampaikan secara empatik kepada klien dan keluarga dengan izin klien. Asesmen psikologis mendalam dilakukan dengan pertanyaan yang sensitif, termasuk skrining kemungkinan pernikahan paksa. Apabila ditemukan indikasi pemaksaan, bidan berkoordinasi dengan petugas perlindungan anak atau layanan konseling keluarga setempat.

H. Program Kesehatan & Peran Bidan

1. Program Pemerintah yang Relevan

Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang mencakup periode sejak pembuahan hingga usia dua tahun, mengakui bahwa intervensi gizi pada periode ini memiliki dampak jangka panjang yang tidak dapat digantikan terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas anak di masa dewasa. Program Tablet Tambah Darah (TTD) Nasional mendistribusikan suplemen besi dan asam folat kepada remaja putri dan WUS sebagai upaya konkret mengurangi prevalensi anemia di tingkat populasi. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menjamin pembiayaan layanan kesehatan pranikah, kehamilan, dan persalinan, sehingga hambatan finansial terhadap akses layanan dapat dikurangi. Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan merupakan platform edukasi pranikah yang strategis dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya oleh tenaga kebidanan (Kemenkes RI, 2022).

2. Peran Strategis Bidan

Bidan memiliki posisi strategis dan unik dalam sistem kesehatan Indonesia sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Dalam peran promotif, bidan meningkatkan pengetahuan dan motivasi WUS serta calon pengantin melalui penyuluhan di posyandu, PKK, karang taruna, dan pengajian; penyebaran media informasi; serta advokasi kepada tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Dalam peran preventif, bidan melakukan skrining dini faktor risiko kehamilan, memberikan imunisasi yang diperlukan, mendistribusikan suplemen gizi, dan melakukan tatalaksana awal sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Kolaborasi lintas program dan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, termasuk koordinasi dengan Dinas Kesehatan, KUA, Dinas Pendidikan, BKKBN, dan organisasi masyarakat sipil. Penguasaan keterampilan komunikasi terapeutik, konseling berbasis bukti, dan sistem rujukan yang efektif merupakan kompetensi inti bidan dalam memberikan asuhan pranikah yang berkualitas dan berpusat pada klien (Kemenkes RI, 2022; ICM, 2023).

I. Simpulan

Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi merupakan fondasi vital dalam siklus reproduksi yang secara langsung menentukan kualitas kesehatan ibu, keberhasilan persalinan, hingga derajat kesehatan generasi masa depan. Melalui tiga pilar utama—optimalisasi status gizi, penanganan anemia, dan kesiapan fisik—intervensi pada periode ini terbukti jauh lebih efektif dalam mencegah komplikasi kehamilan dibandingkan penanganan saat kehamilan sudah berjalan. Kondisi seperti Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia pada Wanita Usia Subur (WUS) harus diidentifikasi dan dikoreksi melalui penilaian indeks massa tubuh (IMT), lingkaran lengan atas (LiLA), serta kadar hemoglobin guna meminimalkan risiko bayi berat lahir rendah (BBLR) dan perdarahan postpartum.

Bidan memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam mengimplementasikan asuhan pranikah melalui pendekatan promotif, preventif, dan edukatif yang komprehensif. Peran ini mencakup pengkajian mendalam, pemberian suplementasi seperti asam folat dan zat besi, hingga memfasilitasi perubahan gaya hidup sehat bagi calon pengantin. Dengan memanfaatkan program pemerintah seperti Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kolaborasi lintas sektor, bidan memastikan bahwa setiap pasangan memulai kehamilan dalam kondisi fisik dan psikologis yang ideal, sehingga mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan di Indonesia.

Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2022). *Prepregnancy counseling: ACOG Committee Opinion No. 762 (reaffirmed 2022)*. ACOG.
- Bailey, R. L., West, K. P., & Black, R. E. (2021). The epidemiology of global micronutrient deficiencies. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 78(Suppl. 3), 22–33. <https://doi.org/10.1159/000519023>
- Cappellini, M. D., Motta, I., & Musallam, K. M. (2021). Iron-deficiency anemia revisited. *Journal of Internal Medicine*, 289(2), 153–170. <https://doi.org/10.1111/joim.13004>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Medical.
- Georgieff, M. K., Ramel, S. E., & Cusick, S. E. (2020). Nutritional influences on brain development. *Acta Paediatrica*, 109(1), 18–23. <https://doi.org/10.1111/apa.14812>
- Gibson, R. S., & Ferguson, E. L. (2024). *An interactive 24-hour recall for assessing the adequacy of iron and zinc intakes in developing countries* (4th ed.). HarvestPlus International Food Policy Research Institute.
- Hanson, M., Barker, M., Dodd, J. M., Kumanyika, S., Norris, S., Steegers, E., Stephenson, J., & Tam, W. H. (2021). Interventions to prevent maternal obesity before conception, during pregnancy, and post partum. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 9(2), 83–96. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(20\)30336-X](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30336-X)
- International Confederation of Midwives (ICM). (2023). *Essential competencies for midwifery practice: 2023 update*. ICM.
- Kassebaum, N. J., & GBD 2021 Anaemia Collaborators. (2022). Global, regional, and national prevalence and years lived with disability for anaemia, 1990–2021. *The Lancet Haematology*, 9 (6), e444–e468. [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(22\)00084-9](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(22)00084-9)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu* (Edisi ketiga). Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023: Laporan nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Michie, S., Atkins, L., & West, R. (2020). *The behaviour change wheel: A guide to designing interventions* (2nd ed.). Silverback Publishing.
- Wald, N. J., & Morris, J. K. (2023). Folic acid and neural tube defects: The end of the beginning? *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 130(3), 318–325. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17388>
- World Health Organization. (2022). *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *Nutritional anaemias: Tools for effective prevention and control* (2nd ed.). WHO.

Glosarium

ADB = Anemia Defisiensi Besi — jenis anemia tersering pada WUS, ditandai gambaran darah mikrositik hipokromik dan kadar ferritin rendah.

Anemia = Kondisi kadar hemoglobin di bawah nilai normal, yakni Hb <12 g/dL pada wanita tidak hamil; mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen darah.

DOHaD = Developmental Origins of Health and Disease — konsep yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan janin (ditentukan kesehatan ibu) memengaruhi kesehatan anak hingga dewasa.

IMT = Indeks Massa Tubuh — nilai yang diperoleh dari rumus $BB \text{ (kg)} / TB^2 \text{ (m}^2\text{)}$; digunakan untuk mengklasifikasikan status berat badan.

KEK = Kekurangan Energi Kronis — kondisi yang ditandai LiLA <23,5 cm; meningkatkan risiko bayi berat lahir rendah sebesar 2–3 kali lipat.

LiLA = Lingkar Lengan Atas — indikator antropometri sederhana yang digunakan untuk skrining KEK pada WUS dan ibu hamil.

NTD = Neural Tube Defects — kelainan tabung saraf janin seperti spina bifida; risikonya dapat dikurangi secara bermakna melalui suplementasi asam folat.

TORCH = Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simpleks — kelompok infeksi yang berpotensi menyebabkan kelainan kongenital serius pada janin.

TTD = Tablet Tambah Darah — suplemen yang mengandung 60 mg elemental iron dan 0,4 mg asam folat; merupakan program nasional pencegahan anemia pada WUS dan remaja putri.

WUS = Wanita Usia Subur — perempuan berusia 15–49 tahun yang menjadi sasaran utama program kesehatan reproduksi.

CHAPTER 4

IMUNISASI, SKRINING PENYAKIT, DAN FAKTOR RISIKO REPRODUKSI

Bdn. Zuliyana, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan reproduksi perempuan dan pasangan usia subur. Pelayanan ini diberikan sebelum terjadinya kehamilan dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin secara fisik, psikologis, sosial, dan reproduksi agar mampu menjalani kehidupan berkeluarga serta kehamilan yang sehat. Dalam pelayanan kebidanan modern, pendekatan promotif dan preventif menjadi prioritas utama untuk mencegah berbagai masalah kesehatan ibu dan anak sejak sebelum konsepsi terjadi. *American College of Obstetricians and Gynecologists* menegaskan bahwa pelayanan prakonsepsi berperan penting dalam mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan luaran maternal serta neonatal (ACOG, 2019).

Masa pranikah dan prakonsepsi menjadi periode yang sangat strategis karena berbagai faktor risiko kesehatan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum memengaruhi proses kehamilan. Kondisi kesehatan calon ibu dan calon ayah memiliki pengaruh besar terhadap kesuburan, perkembangan janin, proses persalinan, hingga kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, pelayanan pranikah tidak hanya berfokus pada kesiapan menikah, tetapi juga pada kesiapan membentuk keluarga sehat dan menghasilkan generasi yang berkualitas. *World Health Organization* menjelaskan bahwa intervensi kesehatan sebelum konsepsi merupakan strategi penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat (WHO, 2023).

Salah satu komponen penting dalam asuhan pranikah dan prakonsepsi adalah pemberian imunisasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Imunisasi bertujuan untuk melindungi perempuan usia reproduksi dari penyakit infeksi yang dapat membahayakan ibu maupun janin, seperti tetanus, rubella, hepatitis B, influenza, dan infeksi lainnya. Kelengkapan status imunisasi sebelum kehamilan sangat penting karena beberapa penyakit infeksi dapat menyebabkan komplikasi serius, keguguran, persalinan prematur, hingga kelainan kongenital

pada bayi. Dengan imunisasi yang tepat, risiko tersebut dapat dicegah sejak awal. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) merekomendasikan evaluasi status imunisasi perempuan usia reproduksi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan prakonsepsi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (CDC, 2025).

Selain imunisasi, skrining penyakit juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan yang dapat memengaruhi reproduksi dan kehamilan. Pemeriksaan kesehatan pranikah meliputi skrining anemia, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, hepatitis B, diabetes melitus, hipertensi, thalassemia, serta gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Skrining dilakukan untuk menemukan penyakit atau faktor risiko secara dini sehingga dapat segera dilakukan penanganan, pengobatan, maupun konseling kesehatan sebelum pasangan merencanakan kehamilan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pencegahan komplikasi maternal dan neonatal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan keluarga sehat dan mencegah risiko kesehatan reproduksi (Kemenkes RI, 2024).

Faktor risiko reproduksi yang tidak teridentifikasi dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Faktor usia, status gizi, penyakit kronis, perilaku merokok, konsumsi alkohol, stres, hingga riwayat penyakit genetik dalam keluarga merupakan beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan pranikah dan prakonsepsi. Dalam hal ini, bidan memiliki peran penting sebagai edukator, konselor, dan pemberi pelayanan kesehatan reproduksi melalui pendekatan yang holistik, berkesinambungan, serta berorientasi pada pencegahan demi terwujudnya kehamilan sehat dan generasi yang berkualitas. Peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi juga sejalan dengan standar pelayanan kebidanan yang menempatkan bidan sebagai garda terdepan dalam promosi kesehatan ibu dan anak (*International Confederation of Midwives*, 2024).

B. Konsep Imunisasi pada Masa Pranikah dan Prakonsepsi

1. Pengertian Imunisasi Prakonsepsi

Imunisasi prakonsepsi adalah pemberian vaksin kepada perempuan usia reproduksi atau pasangan yang merencanakan kehamilan sebelum terjadinya konsepsi dengan tujuan membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi tertentu yang dapat membahayakan ibu, janin, maupun bayi baru lahir. Imunisasi ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan prakonsepsi yang berfokus pada upaya promotif dan preventif untuk menciptakan kondisi

kesehatan optimal sebelum kehamilan terjadi. Pelayanan imunisasi prakonsepsi dilakukan agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk membentuk antibodi sehingga perempuan telah memiliki perlindungan yang memadai ketika memasuki masa kehamilan. *World Health Organization* menyatakan bahwa pelayanan prakonsepsi, termasuk imunisasi, bertujuan meningkatkan kesehatan perempuan dan menurunkan risiko komplikasi kehamilan serta gangguan kesehatan pada bayi (WHO, 2023).

Imunisasi prakonsepsi diberikan untuk mencegah berbagai penyakit infeksi yang dapat menimbulkan dampak serius selama kehamilan, seperti tetanus, rubella, hepatitis B, varisela, influenza, dan infeksi lainnya. Penyakit-penyakit tersebut dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, cacat bawaan, gangguan pertumbuhan janin, hingga kematian neonatal. Oleh karena itu, imunisasi sebelum kehamilan menjadi langkah penting dalam perlindungan kesehatan reproduksi perempuan. *American College of Obstetricians and Gynecologists* menegaskan bahwa evaluasi dan pemberian imunisasi sebelum kehamilan merupakan bagian penting dari konseling prakehamilan untuk mengurangi risiko infeksi maternal dan neonatal (ACOG, 2019).

Secara konsep, imunisasi prakonsepsi tidak hanya bertujuan melindungi perempuan sebagai calon ibu, tetapi juga memberikan perlindungan tidak langsung kepada janin dan bayi melalui pembentukan antibodi maternal. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi dapat ditransfer melalui plasenta kepada janin sehingga membantu memberikan kekebalan pasif pada bayi selama awal kehidupannya. Hal ini terutama penting pada imunisasi tetanus dan beberapa penyakit infeksi lainnya yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan demikian, imunisasi prakonsepsi menjadi salah satu strategi penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi.

Pelaksanaan imunisasi prakonsepsi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian status imunisasi dan kondisi kesehatan individu. Tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter, dan petugas imunisasi, perlu melakukan anamnesis riwayat vaksinasi, riwayat penyakit, serta pemeriksaan kesehatan sebelum memberikan vaksin. Beberapa vaksin hidup seperti vaksin MMR dan varisela diberikan sebelum kehamilan dan memerlukan penundaan kehamilan dalam jangka waktu tertentu setelah imunisasi. Sementara itu, vaksin inaktif seperti hepatitis B dan tetanus dapat diberikan sesuai indikasi medis dan rekomendasi pelayanan kesehatan. *Centers for Disease Control and Prevention* menjelaskan bahwa penentuan jenis dan waktu pemberian vaksin pada perempuan usia reproduksi

harus mempertimbangkan keamanan ibu dan janin di masa mendatang (CDC, 2025).

Dalam pelayanan kebidanan, imunisasi prakonsepsi menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kehamilan yang sehat dan generasi yang berkualitas. Melalui edukasi, konseling, dan pemberian imunisasi yang tepat, calon pengantin dan pasangan usia subur dapat lebih siap menghadapi kehamilan dengan risiko komplikasi yang lebih rendah. Oleh karena itu, imunisasi prakonsepsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi ibu, bayi, dan keluarga.

2. Jenis Imunisasi pada Calon Pengantin

a. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) merupakan salah satu imunisasi penting dan wajib yang diberikan kepada calon pengantin perempuan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan pranikah dan prakonsepsi. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tetanus yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium tetani*. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, imunisasi TT memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya tetanus maternal dan tetanus neonatorum yang dapat menyebabkan kematian ibu maupun bayi baru lahir. Oleh karena itu, imunisasi TT menjadi bagian dari program nasional kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan secara berkesinambungan pada perempuan usia subur, termasuk calon pengantin. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa imunisasi TT pada calon pengantin dilakukan sebagai upaya perlindungan ibu dan bayi terhadap risiko infeksi tetanus selama proses kehamilan dan persalinan (Kemenkes RI, 2018).

Tetanus merupakan penyakit infeksi serius yang menyerang sistem saraf dan ditandai dengan kekakuan otot serta kejang yang dapat berakibat fatal. Penyakit ini terjadi akibat masuknya spora bakteri *Clostridium tetani* melalui luka yang terkontaminasi. Pada ibu hamil dan bayi baru lahir, tetanus dapat terjadi akibat prosedur persalinan yang tidak steril atau perawatan tali pusat yang tidak higienis. Tetanus neonatorum masih menjadi salah satu penyebab kematian bayi di beberapa negara berkembang. Oleh karena itu, imunisasi TT pada perempuan sebelum kehamilan menjadi langkah penting dalam pencegahan penyakit tersebut.

Imunisasi TT bekerja dengan merangsang tubuh membentuk antibodi terhadap toksin tetanus. Antibodi yang terbentuk dalam tubuh ibu tidak hanya melindungi ibu dari infeksi tetanus, tetapi juga dapat ditransfer melalui

plasenta kepada janin sehingga memberikan kekebalan pasif pada bayi baru lahir. Kekebalan pasif ini sangat penting terutama pada masa awal kehidupan bayi ketika sistem imun belum berkembang sempurna. Dengan demikian, imunisasi TT memiliki manfaat ganda, yaitu melindungi ibu sekaligus bayi yang akan dilahirkan (Awatiszahro,dkk., 2024).

Dalam pelayanan calon pengantin, pemberian imunisasi TT dilakukan berdasarkan hasil skrining status imunisasi atau status T. Status T merupakan penilaian terhadap jumlah dosis imunisasi tetanus yang pernah diterima seseorang sepanjang hidupnya. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan apakah calon pengantin masih memerlukan imunisasi tambahan atau sudah memiliki perlindungan yang cukup terhadap tetanus. Menurut pedoman Kementerian Kesehatan RI, pemeriksaan status T menjadi langkah penting sebelum pemberian imunisasi TT pada calon pengantin perempuan agar pemberian vaksin sesuai dengan kebutuhan individu (Kemenkes RI, 2015).

Jadwal imunisasi TT terdiri dari beberapa tahap yang diberikan secara bertahap untuk mencapai perlindungan jangka panjang. Pemberian TT1 biasanya dilakukan saat kontak pertama dengan pelayanan kesehatan. TT2 diberikan minimal empat minggu setelah TT1 dan mampu memberikan perlindungan selama tiga tahun. TT3 diberikan minimal enam bulan setelah TT2 dengan masa perlindungan sekitar lima tahun. TT4 diberikan minimal satu tahun setelah TT3 dengan perlindungan hingga sepuluh tahun, sedangkan TT5 diberikan minimal satu tahun setelah TT4 dan dapat memberikan perlindungan jangka panjang hingga lebih dari dua puluh lima tahun atau sepanjang masa reproduksi. Oleh karena itu, kelengkapan imunisasi TT sangat penting dipantau sejak masa remaja hingga usia reproduksi (Awatiszahro,dkk., 2024).

Selain memberikan perlindungan kesehatan, imunisasi TT juga menjadi bagian dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. *World Health Organization* menyebutkan bahwa eliminasi tetanus maternal dan neonatal dapat dicapai melalui imunisasi tetanus pada perempuan usia subur, persalinan bersih dan aman, serta perawatan tali pusat yang higienis. Imunisasi TT telah terbukti efektif menurunkan angka kejadian tetanus neonatorum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Program imunisasi ini menjadi salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dan ekonomis dalam perlindungan kesehatan ibu dan anak (WHO, 2023).

Pelaksanaan imunisasi TT pada calon pengantin harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan memperhatikan prinsip keamanan dan prosedur pelayanan imunisasi. Sebelum pemberian vaksin, calon

pengantin perlu mendapatkan edukasi mengenai manfaat imunisasi, jadwal pemberian, kemungkinan efek samping ringan, dan pentingnya melengkapi dosis imunisasi. Efek samping imunisasi TT umumnya ringan, seperti nyeri pada tempat suntikan, kemerahan, atau demam ringan yang biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Edukasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ketakutan masyarakat terhadap imunisasi.

Imunisasi TT pada calon pengantin juga berkaitan dengan kesiapan pasangan dalam merencanakan kehamilan yang aman dan berkualitas. Pasangan yang telah mendapatkan imunisasi lengkap memiliki risiko lebih rendah mengalami komplikasi akibat tetanus selama masa kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, imunisasi TT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan pranikah dan prakonsepsi dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

b. Imunisasi Tambahan, Opsional, atau Berdasarkan Indikasi Khusus pada Calon Pengantin

Selain imunisasi dasar seperti Tetanus Toksoid (TT), calon pengantin juga dapat memperoleh imunisasi tambahan atau imunisasi berdasarkan indikasi khusus sesuai kondisi kesehatan, riwayat penyakit, faktor risiko, dan kebutuhan individu. Imunisasi tambahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap penyakit infeksi yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, serta kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Dalam pelayanan kesehatan pranikah dan prakonsepsi, imunisasi tambahan menjadi bagian penting dari upaya promotif dan preventif untuk menciptakan kehamilan yang sehat dan berkualitas (Yulivantina, dkk., 2023).

Beberapa imunisasi tambahan yang direkomendasikan pada calon pengantin meliputi vaksin Hepatitis B, Rubella (MR vaccine), Human Papilloma Virus (HPV), dan Influenza.

1) Imunisasi Hepatitis B

Imunisasi Hepatitis B merupakan vaksinasi yang diberikan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B, yaitu penyakit infeksi yang menyerang hati dan dapat berkembang menjadi hepatitis kronis, sirosis, hingga kanker hati. Penularan hepatitis B dapat terjadi melalui darah, hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, serta penularan dari ibu kepada bayi selama proses kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, imunisasi hepatitis B sangat penting diberikan kepada calon pengantin, terutama

pada individu yang belum pernah mendapatkan vaksin atau belum memiliki kekebalan terhadap hepatitis B.

Dalam pelayanan kesehatan prakonsepsi, skrining hepatitis B biasanya dilakukan melalui pemeriksaan HBsAg untuk mengetahui status infeksi seseorang. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa individu belum memiliki kekebalan dan tidak terinfeksi hepatitis B, maka vaksinasi hepatitis B dianjurkan sebelum kehamilan. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mencegah penularan kepada pasangan maupun bayi di masa mendatang (Yulivantina, dkk., 2023).

Vaksin hepatitis B umumnya diberikan dalam tiga dosis dengan jadwal tertentu untuk membentuk kekebalan optimal. Efek samping vaksin biasanya ringan, seperti nyeri pada tempat suntikan atau demam ringan. Dalam pelayanan calon pengantin, bidan memiliki peran dalam memberikan edukasi mengenai manfaat vaksin, jadwal imunisasi, serta pentingnya pencegahan penularan hepatitis B melalui perilaku hidup sehat dan hubungan seksual yang aman.

2) Imunisasi Rubella (*MR Vaccine*)

Imunisasi Rubella atau vaksin MR (*Measles-Rubella*) merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah infeksi campak dan rubella. Dalam konteks kesehatan reproduksi, perlindungan terhadap rubella menjadi sangat penting karena infeksi rubella pada awal kehamilan dapat menyebabkan *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) pada janin. CRS merupakan kondisi kelainan bawaan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran, katarak, kelainan jantung bawaan, retardasi pertumbuhan, dan gangguan neurologis pada bayi.

Dalam pelayanan prakonsepsi, bidan perlu melakukan anamnesis riwayat imunisasi dan riwayat penyakit rubella sebelum menentukan kebutuhan vaksinasi. Edukasi mengenai bahaya infeksi rubella pada kehamilan juga penting diberikan kepada calon pengantin agar pasangan memahami manfaat vaksinasi sebelum konsepsi terjadi.

3) Imunisasi HPV (Human Papilloma Virus)

Imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) merupakan vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah infeksi virus HPV, terutama tipe risiko tinggi yang berkaitan dengan kanker serviks. Kanker serviks merupakan salah satu kanker terbanyak pada perempuan dan menjadi masalah kesehatan reproduksi yang serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain menyebabkan kanker serviks, infeksi HPV juga dapat menyebabkan kanker anogenital dan kutil kelamin.

Pemberian vaksin HPV sangat dianjurkan pada perempuan sebelum aktif secara seksual karena efektivitas perlindungan lebih optimal bila diberikan sebelum terpapar virus HPV. Namun demikian, vaksinasi HPV tetap dapat diberikan pada perempuan dewasa sesuai indikasi dan rekomendasi tenaga kesehatan. Imunisasi HPV merupakan bagian dari upaya preventif dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan menurunkan risiko kanker serviks di masa mendatang (Susanti, R., dkk., 2024).

Vaksin HPV diberikan dalam beberapa dosis sesuai usia dan jenis vaksin yang digunakan. Selain vaksinasi, pencegahan kanker serviks juga perlu didukung dengan perilaku hidup sehat dan pemeriksaan deteksi dini seperti IVA test atau Pap smear. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai kanker serviks, faktor risiko HPV, serta pentingnya vaksinasi sebagai bentuk perlindungan kesehatan reproduksi jangka panjang.

4) Imunisasi Influenza

Imunisasi influenza merupakan vaksinasi yang diberikan untuk melindungi tubuh dari infeksi virus influenza. Pada perempuan yang merencanakan kehamilan, vaksin influenza penting diberikan karena perubahan fisiologis selama kehamilan dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga ibu hamil lebih rentan mengalami komplikasi akibat influenza. Infeksi influenza pada kehamilan dapat meningkatkan risiko pneumonia, persalinan prematur, gangguan pertumbuhan janin, dan komplikasi maternal lainnya (CDC, 2025).

Dalam pelayanan calon pengantin, edukasi mengenai influenza sering kali masih kurang mendapat perhatian dibandingkan imunisasi lainnya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai bahaya komplikasi influenza pada kehamilan dan manfaat vaksinasi sebagai langkah preventif. Selain vaksinasi, upaya pencegahan influenza juga dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, serta menjaga daya tahan tubuh.

C. Skrining Penyakit pada Calon Pengantin

1. Pengertian Skrining Pranikah

Skrining pranikah adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon pengantin sebelum menikah untuk mendeteksi penyakit, gangguan kesehatan, maupun faktor risiko yang dapat memengaruhi

kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan kesehatan bayi di masa mendatang. Skrining pranikah bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pasangan secara dini sehingga dapat dilakukan pencegahan, pengobatan, konseling, maupun perencanaan kehamilan yang lebih sehat dan aman. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, skrining pranikah menjadi bagian penting dari asuhan prakonsepsi karena kondisi kesehatan sebelum kehamilan sangat menentukan kualitas kehamilan dan luaran maternal serta neonatal.

Pemeriksaan skrining pranikah tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga melibatkan calon suami sebagai pasangan reproduksi. Pemeriksaan dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta penilaian faktor risiko kesehatan dan gaya hidup. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan calon pengantin dilakukan sebagai upaya preventif untuk menciptakan keluarga sehat dan menurunkan risiko masalah kesehatan reproduksi di masa mendatang (Kemenkes, 2018).

Skrining pranikah juga bertujuan untuk mendeteksi penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang berpotensi memengaruhi kehamilan. Penyakit seperti anemia, diabetes melitus, hipertensi, hepatitis B, HIV/AIDS, sifilis, dan thalassemia perlu diketahui sejak sebelum kehamilan agar dapat ditangani lebih awal. Pemeriksaan prakonsepsi membantu mengidentifikasi faktor risiko medis, genetik, sosial, dan perilaku yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi (ACOG, 2019).

Selain aspek fisik, skrining pranikah juga mencakup penilaian kesehatan mental, status gizi, riwayat penyakit keluarga, serta perilaku hidup sehat. Dengan adanya skrining sejak sebelum menikah, pasangan dapat lebih siap secara fisik dan psikologis dalam menghadapi kehidupan berkeluarga dan kehamilan. Oleh karena itu, skrining pranikah menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif dan preventif.

2. Komponen Skrining Prakonsepsi

Skrining prakonsepsi terdiri atas beberapa komponen penting yang dilakukan untuk menilai kesiapan kesehatan calon pengantin sebelum memasuki masa kehamilan (Yulivantina, dkk., 2023).

- a. **Anamnesis atau pengkajian riwayat kesehatan.** Pengkajian ini meliputi riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat menstruasi, riwayat obstetri, penggunaan obat-obatan, riwayat imunisasi, alergi, pola hidup, serta riwayat penyakit menular seksual. Informasi tersebut membantu

tenaga kesehatan mengidentifikasi faktor risiko yang dapat memengaruhi kehamilan dan kesehatan reproduksi.

- b. **Pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan status gizi.** Pemeriksaan ini meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, lingkaran lengan atas (LILA), serta pemeriksaan tanda anemia atau penyakit kronis lainnya. Status gizi yang baik sebelum kehamilan sangat penting karena kekurangan maupun kelebihan gizi dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. (Yulivantina, dkk., 2023).
- c. **Pemeriksaan laboratorium.** Pemeriksaan laboratorium pada calon pengantin dapat meliputi pemeriksaan hemoglobin (Hb), golongan darah dan rhesus, gula darah, hepatitis B, HIV/AIDS, sifilis, TORCH, dan pemeriksaan urin sesuai indikasi medis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan sebelum kehamilan terjadi. Skrining laboratorium sangat penting dalam upaya pencegahan komplikasi maternal dan neonatal.
- d. **Skrining kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual.** Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi infeksi menular seksual seperti gonore, sifilis, HIV, maupun gangguan organ reproduksi yang dapat memengaruhi kesuburan dan kehamilan. Selain itu, perempuan juga dapat dilakukan pemeriksaan IVA atau Pap smear sesuai indikasi untuk mendeteksi dini kanker serviks.
- e. **Penilaian kesehatan mental dan psikososial.** Kesiapan mental pasangan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan kehamilan. Skrining ini dilakukan untuk menilai adanya stres, kecemasan, depresi, kekerasan dalam hubungan, atau masalah psikologis lain yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan kesiapan menjadi orang tua.
- f. **Penilaian status imunisasi.** Pemeriksaan status imunisasi bertujuan mengetahui apakah calon pengantin telah memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu seperti tetanus, rubella, hepatitis B, influenza, dan HPV. Jika status imunisasi belum lengkap, maka tenaga kesehatan dapat memberikan vaksinasi sebelum kehamilan.

3. Manfaat Skrining Prakonsepsi

Skrining prakonsepsi memiliki manfaat penting dalam mempersiapkan kesehatan calon pengantin sebelum kehamilan terjadi. Melalui skrining, berbagai penyakit dan faktor risiko seperti anemia, diabetes, hipertensi, penyakit menular seksual, serta gangguan kesehatan reproduksi dapat dideteksi lebih dini sehingga dapat segera dilakukan penanganan atau pencegahan. Deteksi

dini ini membantu menurunkan risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas (Walyani & Purwoastuti, 2021).

Selain itu, skrining prakonsepsi membantu meningkatkan kesiapan fisik, mental, dan reproduksi pasangan dalam membangun keluarga sehat. Pemeriksaan ini juga berperan dalam mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi serta mendukung lahirnya generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan skrining prakonsepsi, pasangan dapat memperoleh edukasi, konseling, dan perencanaan kehamilan yang lebih aman dan optimal.

D. Faktor Risiko Reproduksi pada Calon Pengantin

1. Pengertian Faktor Risiko Reproduksi

Faktor risiko reproduksi adalah segala kondisi, keadaan, kebiasaan, maupun paparan tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan reproduksi, komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, serta masalah kesehatan pada bayi yang akan dilahirkan. Faktor risiko reproduksi dapat berasal dari aspek biologis, medis, psikologis, sosial, perilaku, maupun lingkungan yang memengaruhi kesehatan pasangan sebelum dan selama masa reproduksi. Dalam pelayanan kesehatan pranikah dan prakonsepsi, identifikasi faktor risiko reproduksi sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap komplikasi maternal dan neonatal.

Pada calon pengantin, faktor risiko reproduksi perlu dikenali sejak sebelum kehamilan agar pasangan dapat mempersiapkan kondisi kesehatan yang optimal. Dalam praktik kebidanan, faktor risiko reproduksi tidak hanya berkaitan dengan penyakit fisik, tetapi juga meliputi faktor psikososial, gaya hidup, serta lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan pasangan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan calon pengantin dilakukan secara komprehensif melalui pengkajian kesehatan fisik, mental, sosial, dan reproduksi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan pranikah bertujuan menciptakan pasangan yang sehat secara fisik, mental, dan reproduksi sebelum membangun keluarga (Kemenkes, 2020).

2. Klasifikasi Faktor Risiko Reproduksi

a. Faktor Biologis

Faktor biologis merupakan faktor risiko yang berasal dari kondisi fisik dan kesehatan tubuh individu yang dapat memengaruhi fungsi reproduksi dan kehamilan. Salah satu faktor biologis yang penting adalah usia. Kehamilan pada usia terlalu muda, terutama di bawah 20 tahun, memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia, persalinan prematur, bayi berat lahir

rendah, dan komplikasi obstetri karena organ reproduksi belum matang secara optimal. Sebaliknya, kehamilan pada usia di atas 35 tahun juga berisiko meningkatkan kejadian hipertensi, diabetes gestasional, kelainan kromosom, dan komplikasi persalinan.

Selain usia, status gizi juga termasuk faktor biologis yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Kekurangan gizi, anemia, maupun obesitas dapat meningkatkan risiko gangguan kesuburan, komplikasi kehamilan, dan gangguan pertumbuhan janin. Penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, epilepsi, gangguan tiroid, dan penyakit ginjal juga menjadi faktor biologis yang perlu dikendalikan sebelum kehamilan (Prawirohardjo, 2020).

b. Faktor Reproduksi

Faktor reproduksi berkaitan dengan kondisi dan riwayat kesehatan reproduksi pasangan yang dapat memengaruhi kesuburan dan kehamilan. Faktor ini meliputi riwayat menstruasi tidak teratur, infertilitas, riwayat keguguran berulang, kehamilan ektopik, persalinan prematur, operasi sesar berulang, perdarahan obstetri, serta riwayat penyakit menular seksual. Penyakit seperti HIV/AIDS, sifilis, gonore, dan hepatitis B dapat memengaruhi kesehatan reproduksi serta meningkatkan risiko penularan kepada pasangan dan bayi (Nurqalbi SR., dkk, 2023).

Selain itu, riwayat penggunaan kontrasepsi tertentu, gangguan hormonal, endometriosis, maupun kelainan organ reproduksi juga dapat menjadi faktor risiko reproduksi. Dalam pelayanan prakonsepsi, pemeriksaan kesehatan reproduksi bertujuan mendeteksi masalah tersebut sejak dini agar dapat dilakukan penatalaksanaan sebelum kehamilan terjadi.

c. Faktor Sosial dan Perilaku

Faktor sosial dan perilaku merupakan faktor yang berkaitan dengan kebiasaan hidup, kondisi psikososial, pendidikan, ekonomi, dan pola perilaku pasangan. Perilaku merokok, konsumsi alkohol, penggunaan narkotika, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta hubungan seksual berisiko dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan kehamilan. Merokok, misalnya, dapat menyebabkan gangguan kesuburan, kehamilan ektopik, bayi berat lahir rendah, dan persalinan prematur.

Selain perilaku hidup tidak sehat, faktor sosial seperti rendahnya pendidikan, pernikahan usia dini, kekerasan dalam hubungan, stres, dan masalah ekonomi juga dapat memengaruhi kesiapan reproduksi pasangan. Kesehatan mental calon pengantin menjadi aspek penting karena stres dan gangguan psikologis dapat memengaruhi hubungan keluarga dan kesehatan

kehamilan. Menurut WHO, faktor sosial dan perilaku memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi dan kualitas hidup keluarga (WHO, 2023).

d. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor risiko yang berasal dari lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja pasangan. Paparan zat kimia, pestisida, logam berat, radiasi, polusi udara, asap rokok, dan bahan toksik lainnya dapat memengaruhi kesuburan serta perkembangan janin. Lingkungan kerja dengan paparan bahan berbahaya tanpa perlindungan yang memadai juga dapat meningkatkan risiko gangguan reproduksi dan komplikasi kehamilan.

Selain itu, sanitasi lingkungan yang buruk, akses air bersih yang kurang memadai, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat juga dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi pada pasangan dan ibu hamil. Oleh karena itu, faktor lingkungan menjadi bagian penting dalam pengkajian kesehatan prakonsepsi (Walyani & Purwoastuti, 2021).

3. Dampak Faktor Risiko Reproduksi

Faktor risiko reproduksi dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan ibu, janin, maupun bayi baru lahir. Dampak pada ibu meliputi anemia, hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, diabetes gestasional, perdarahan, infeksi, komplikasi persalinan, hingga kematian maternal. Pada janin dan bayi, faktor risiko reproduksi dapat menyebabkan keguguran, kelainan kongenital, gangguan pertumbuhan janin, bayi berat lahir rendah, prematuritas, hingga kematian neonatal.

Selain dampak fisik, faktor risiko reproduksi juga dapat memengaruhi kesehatan psikologis dan sosial pasangan. Masalah infertilitas, komplikasi kehamilan, maupun penyakit menular seksual dapat menyebabkan stres, kecemasan, konflik rumah tangga, dan penurunan kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, deteksi dini faktor risiko sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih berat di masa mendatang.

Menurut *American College of Obstetricians and Gynecologists*, identifikasi faktor risiko sebelum kehamilan membantu menurunkan komplikasi maternal dan neonatal serta meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. (ACOG, 2019).

4. Upaya Pencegahan Faktor Risiko Reproduksi

Upaya pencegahan faktor risiko reproduksi dilakukan melalui pelayanan kesehatan pranikah dan prakonsepsi yang komprehensif. Salah satu langkah

penting adalah melakukan skrining kesehatan sebelum menikah untuk mendeteksi penyakit atau faktor risiko sejak dini. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium, status gizi, kesehatan reproduksi, serta kesehatan mental pasangan (Prawirohardjo, 2020).

Pencegahan juga dilakukan melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol dan narkoba, serta menjaga kesehatan reproduksi. Edukasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting diberikan kepada calon pengantin agar pasangan memahami cara menjaga kesehatan sebelum kehamilan (Walyani & Purwoastuti, 2021).

Selain itu, imunisasi prakonsepsi, konsumsi tablet tambah darah, pengendalian penyakit kronis, serta perencanaan kehamilan yang tepat juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, pelayanan kesehatan, dan rujukan bagi calon pengantin yang memiliki faktor risiko reproduksi.

E. Simpulan

Imunisasi, skrining penyakit, dan identifikasi faktor risiko reproduksi merupakan bagian penting dalam pelayanan pranikah dan prakonsepsi pada calon pengantin. Imunisasi membantu melindungi ibu dan bayi dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu kehamilan, sedangkan skrining penyakit berfungsi mendeteksi dini masalah kesehatan agar dapat segera ditangani sebelum kehamilan terjadi. Selain itu, identifikasi faktor risiko reproduksi seperti faktor biologis, reproduksi, sosial, perilaku, dan lingkungan penting dilakukan untuk mencegah komplikasi pada ibu dan bayi. Melalui pelayanan yang promotif dan preventif, calon pengantin dapat lebih siap menjalani kehamilan sehat serta mewujudkan keluarga dan generasi yang berkualitas.

F. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2019). *Prepregnancy Counseling: ACOG Committee Opinion No. 762*. Obstetrics & Gynecology, 133(1), e78–e89.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2025). *Adult immunization schedule by age group, United States, 2025*. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2025). *Flu and pregnancy*. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services

- International Confederation of Midwives (ICM). (2024). *International Confederation of Midwives: Essential competencies for midwifery practice*. The Hague: International Confederation of Midwives.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Petunjuk pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. ISBN 978-602-235-771-1.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. ISBN 978-602-416-429-4.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA) 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nurqalbi, S. R., dkk. (2023). *Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Prawirohardjo, S. (2020). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Susanti, R., dkk. (2024). *Buku ajar asuhan kebidanan pada pra nikah dan pra konsepsi*. Jakarta: PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Walyani, E. S., & Purwoastuti, E. (2021). *Asuhan kebidanan masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Immunization agenda 2030: A global strategy to leave no one behind*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Preconception care*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2024). *Hepatitis B*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2024). *Rubella*. Geneva: World Health Organization.
- Yulivantina, E. V., Sulastriningsih, K., Ningsih, E. S. B., Ariani, P., Mutmainah, V. T., & Fatmawati, E. (2023). *Buku ajar asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi S1 kebidanan*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group.

G. Glosarium

CRS	=	<i>Congenital Rubella Syndrome</i>
Hb	=	Hemoglobin
HIV/ AIDS	=	<i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
HPV	=	<i>Human Papilloma Virus</i>
IMT	=	Indeks Massa Tubuh
IVA	=	Inspeksi Visual dengan Asam Asetat
LILA	=	Lingkar Lengan Atas
MR	=	<i>Measles Rubella</i> (Campak dan Rubella)
MMR	=	<i>Measles, Mumps, Rubella</i> (Campak, Gondongan, dan Rubella)
TORCH	=	<i>Toxoplasmosis, Others, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus</i>
TT	=	Tetanus Toksoid
TT1	=	Imunisasi Tetanus Toksoid dosis pertama
TT2	=	Imunisasi Tetanus Toksoid dosis kedua
TT3	=	Imunisasi Tetanus Toksoid dosis ketiga
TT4	=	Imunisasi Tetanus Toksoid dosis keempat
TT5	=	Imunisasi Tetanus Toksoid dosis kelima

CHAPTER 5

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN PERENCANAAN KEHAMILAN

Heni Angraini, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Kesehatan reproduksi tidak hanya membahas tentang organ reproduksi dan proses biologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang memengaruhi kualitas hidup seseorang. Pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi sangat diperlukan sejak usia remaja hingga masa dewasa agar setiap individu mampu menjaga kesehatan dirinya, mengambil keputusan yang tepat, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan reproduksinya.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan. Kurangnya informasi dan edukasi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan kesehatan reproduksi, seperti pernikahan usia dini, kehamilan tidak direncanakan, tingginya angka kehamilan remaja, anemia pada ibu hamil, aborsi tidak aman, penyakit menular seksual, serta meningkatnya risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tingginya angka kesakitan dan kematian ibu maupun bayi.

Remaja menjadi salah satu kelompok yang sangat membutuhkan edukasi kesehatan reproduksi. Masa remaja merupakan periode terjadinya perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial yang sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi. Kurangnya edukasi dapat menyebabkan remaja melakukan perilaku berisiko, seperti seks pranikah, penyalahgunaan media sosial, dan kurangnya kesadaran menjaga kesehatan reproduksi. Hal ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan remaja.

Selain itu, masih banyak pasangan usia subur yang belum memahami pentingnya perencanaan kehamilan. Sebagian pasangan mengalami kehamilan dalam kondisi kesehatan yang kurang optimal, usia terlalu muda atau terlalu tua,

jarak kehamilan terlalu dekat, maupun kondisi ekonomi dan psikologis yang belum siap. Kehamilan yang tidak direncanakan dengan baik dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, baik bagi ibu maupun bayi.

Perencanaan kehamilan juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kehamilan yang direncanakan dengan baik dapat membantu pasangan mempersiapkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki masa kehamilan dan persalinan. Melalui perencanaan kehamilan yang tepat diharapkan dapat menurunkan risiko komplikasi kehamilan, angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas generasi yang akan datang.

Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, informasi mengenai kesehatan reproduksi semakin mudah diperoleh. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang tepat terkait kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, keluarga berencana, maupun persiapan kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya berbagai permasalahan kesehatan seperti kehamilan tidak direncanakan, pernikahan usia dini, penyakit menular seksual, anemia pada ibu hamil, hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, edukasi kesehatan reproduksi menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

Edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi akan lebih mampu menjaga kesehatannya, merencanakan masa depan keluarga, dan melahirkan generasi yang sehat serta berkualitas.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan kepada masyarakat. Edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, pelayanan kesehatan, maupun pendampingan kepada remaja, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan merupakan bagian penting dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

B. Konsep Dasar Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi manusia. Konsep kesehatan reproduksi tidak hanya berorientasi pada bebasnya seseorang dari penyakit atau gangguan organ reproduksi, tetapi juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan kehidupan reproduksi.

Menurut <World Health Organization> (WHO), kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya, serta bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan (WHO, 2025)

Di Indonesia, pengertian kesehatan reproduksi diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, serta tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki maupun perempuan (UU Kesehatan, 2009). Menurut (Manuaba, 2010) menyebutkan bahwa Kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan reproduksi secara aman dan memuaskan serta memiliki kemampuan untuk bereproduksi.

Kesehatan reproduksi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan fungsi alat reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup kemampuan untuk:

1. Memahami dan mengatur kesuburan
2. Menjalani kehamilan dan persalinan secara aman
3. Melahirkan bayi yang sehat tanpa risiko yang membahayakan ibu maupun bayi (*well health mother and baby*)
4. Memulihkan kembali kesehatan reproduksi hingga kembali dalam kondisi normal setelah persalinan.

Konsep kesehatan reproduksi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh:

1. Informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi.
2. Pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas.
3. Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
4. Kebebasan menentukan keputusan reproduksi secara bertanggung jawab.

Kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada organ reproduksi, tetapi juga mencakup:

1. kesehatan fisik,
2. kesehatan psikologis,

3. hubungan sosial,
4. perilaku seksual yang sehat,
5. kesiapan mental dalam kehamilan dan pengasuhan anak.

Kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada kondisi organ reproduksi semata, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Konsep kesehatan reproduksi menekankan bahwa seseorang harus berada dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial agar mampu menjalankan fungsi reproduksinya dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat.

Aspek pertama dalam kesehatan reproduksi adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik berkaitan dengan kondisi tubuh yang sehat dan berfungsi dengan baik, khususnya organ-organ reproduksi. Organ reproduksi yang sehat memungkinkan seseorang menjalani fungsi reproduksi secara normal, seperti menstruasi yang teratur, kemampuan untuk hamil, menjalani kehamilan yang aman, dan melahirkan bayi yang sehat. Kesehatan fisik juga mencakup bebas dari penyakit menular seksual, infeksi reproduksi, gangguan hormonal, maupun penyakit yang dapat memengaruhi kesuburan. Untuk menjaga kesehatan fisik reproduksi, seseorang perlu menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan organ reproduksi, berolahraga secara teratur, cukup istirahat, dan menghindari perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan narkoba. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan reproduksi sejak dini sehingga dapat segera ditangani.

Selain kesehatan fisik, kesehatan reproduksi juga mencakup kesehatan psikologis. Kesehatan psikologis berhubungan dengan kondisi mental dan emosional seseorang dalam menjalani kehidupan reproduksi. Individu yang memiliki kesehatan psikologis baik akan mampu mengendalikan emosi, menghadapi perubahan tubuh, serta mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksinya. Kondisi psikologis yang terganggu, seperti stres, kecemasan, depresi, atau trauma, dapat memengaruhi fungsi reproduksi dan kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, stres berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan menstruasi, menurunkan gairah seksual, bahkan memengaruhi kesuburan. Pada ibu hamil, kondisi psikologis yang tidak stabil dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Oleh karena itu, dukungan emosional dari keluarga, pasangan, dan lingkungan sekitar sangat

penting untuk menjaga kesehatan mental seseorang, terutama pada masa kehamilan dan setelah persalinan.

Aspek berikutnya adalah hubungan sosial. Kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial dan hubungan seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan sosial yang sehat dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan dalam menjalani kehidupan reproduksi. Sebaliknya, hubungan sosial yang buruk dapat memengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan reproduksi seseorang. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi gender, atau tekanan sosial yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Dalam kehidupan keluarga, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting untuk mendukung perencanaan kehamilan, pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi, serta pengasuhan anak. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat juga membantu individu memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang tepat.

Kesehatan reproduksi juga mencakup perilaku seksual yang sehat. Perilaku seksual yang sehat berarti seseorang mampu menjalani kehidupan seksual secara aman, bertanggung jawab, dan menghormati diri sendiri maupun pasangan. Perilaku seksual yang sehat dilakukan atas dasar kesadaran, saling menghargai, dan tanpa adanya paksaan atau kekerasan. Selain itu, perilaku seksual sehat juga bertujuan mencegah risiko penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, dan dampak negatif lainnya. Pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting untuk membantu individu memahami perilaku seksual yang sehat, menjaga batasan diri, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait aktivitas seksual. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan seksual dapat menyebabkan perilaku berisiko yang membahayakan kesehatan reproduksi.

Aspek terakhir adalah kesiapan mental dalam kehamilan dan pengasuhan anak. Kehamilan dan menjadi orang tua merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan mental dan emosional. Pasangan yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih mampu menghadapi perubahan selama kehamilan, proses persalinan, serta tantangan dalam merawat dan mendidik anak. Kesiapan mental meliputi kemampuan mengelola emosi, kesiapan menerima peran sebagai orang tua, kemampuan bekerja sama dengan pasangan, serta kesiapan menghadapi perubahan kehidupan setelah memiliki anak. Ketidaksiapan mental dapat menyebabkan stres, konflik keluarga, bahkan gangguan psikologis setelah persalinan seperti baby blues atau depresi postpartum. Oleh karena itu, edukasi dan dukungan keluarga sangat diperlukan agar pasangan mampu menjalani proses kehamilan dan pengasuhan anak dengan baik.

Dengan demikian, kesehatan reproduksi merupakan konsep yang menyeluruh dan saling berkaitan antara kesehatan fisik, psikologis, sosial, perilaku seksual, dan kesiapan mental. Semua aspek tersebut harus dijaga secara seimbang agar individu dapat menjalani kehidupan reproduksi secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kesehatan reproduksi yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga mendukung terbentuknya keluarga yang sehat dan generasi yang berkualitas.

Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kondisi fisik, mental, maupun sosial seseorang dalam menjalankan fungsi reproduksinya. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar individu mampu menjaga kesehatan reproduksi secara optimal (Manuaba, 2010).

1. Faktor Biologis

Faktor biologis adalah faktor yang berasal dari kondisi tubuh dan fungsi organ reproduksi seseorang. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan kesehatan seksual. Usia reproduksi yang terlalu muda atau terlalu tua dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun dapat meningkatkan risiko anemia, persalinan prematur, dan komplikasi kehamilan. Sementara itu, kehamilan pada usia di atas 35 tahun memiliki risiko lebih tinggi terhadap hipertensi, diabetes gestasional, dan kelainan kromosom pada janin. Gangguan pada organ reproduksi seperti kista ovarium, mioma uteri, infeksi, atau kelainan hormon juga dapat memengaruhi kesuburan dan kesehatan reproduksi. Status gizi yang buruk, seperti kekurangan zat besi atau kekurangan energi kronis, dapat menyebabkan anemia dan gangguan reproduksi. Sebaliknya, obesitas juga dapat menyebabkan gangguan hormon dan kesulitan kehamilan.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan kondisi mental dan emosional seseorang yang memengaruhi kesehatan reproduksi. Kondisi psikologis yang tidak stabil dapat memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi. Stres berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan menstruasi, penurunan gairah seksual, hingga gangguan kesuburan. Kecemasan selama kehamilan juga dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga atau trauma seksual dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Kesiapan mental sangat penting dalam perencanaan kehamilan dan pengasuhan anak. Individu yang memiliki

dukungan emosional yang baik cenderung lebih mampu menjaga kesehatan reproduksinya.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya merupakan kebiasaan, nilai, norma, dan tradisi masyarakat yang memengaruhi perilaku kesehatan reproduksi. Budaya tertentu dapat memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Misalnya, masih adanya anggapan bahwa pembicaraan mengenai reproduksi merupakan hal tabu sehingga remaja kurang mendapatkan informasi yang benar. Pernikahan usia dini yang masih terjadi di beberapa daerah dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan karena organ reproduksi belum matang secara optimal. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga dapat memengaruhi hak perempuan dalam menentukan keputusan terkait kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan kontrasepsi dan akses pelayanan kesehatan.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi. Kondisi ekonomi yang rendah dapat menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi, kebersihan, dan pelayanan kesehatan. Individu dengan ekonomi rendah sering mengalami kesulitan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, membeli obat, atau memperoleh kontrasepsi. Keadaan ekonomi juga memengaruhi kualitas hidup keluarga dan kesiapan dalam merencanakan kehamilan.

5. Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Pendidikan dan pengetahuan memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan perilaku hidup sehat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, biasanya semakin baik pula pemahamannya tentang kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang baik membantu individu menjaga kebersihan organ reproduksi, mencegah penyakit, memahami tanda bahaya kehamilan, dan merencanakan keluarga. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan perilaku berisiko, seperti hubungan seksual tidak aman, penggunaan kontrasepsi yang salah, atau keterlambatan mencari pertolongan medis.

6. Akses Pelayanan Kesehatan

Akses pelayanan kesehatan adalah kemudahan individu memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau membantu masyarakat memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan edukasi kesehatan reproduksi secara tepat waktu. Kurangnya fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan dapat

menyebabkan keterlambatan penanganan masalah reproduksi. Selain itu, pelayanan yang tidak ramah juga dapat membuat masyarakat enggan memanfaatkan fasilitas kesehatan.

C. Tujuan Kesehatan Reproduksi

Tujuan kesehatan reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk pelayanan terkait kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi, sehingga perempuan mampu meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh (WHO, 2025).

Adapun tujuan khusus kesehatan reproduksi meliputi peningkatan kemandirian perempuan, khususnya dalam menjalankan peran dan fungsi reproduksinya. Selain itu, kesehatan reproduksi juga bertujuan meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan dalam menentukan waktu kehamilan, jumlah anak yang diinginkan, serta jarak antar kehamilan. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga diharapkan memiliki peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung pengambilan keputusan, pencarian informasi, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan (**Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi**, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan tersebut juga bertujuan menjamin kesehatan perempuan usia reproduktif agar mampu melahirkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

D. Sasaran Kesehatan Reproduksi

Sasaran kesehatan reproduksi adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi target pelayanan, edukasi, dan program kesehatan reproduksi. Sasaran ini mencakup seluruh tahap kehidupan manusia, mulai dari remaja hingga lanjut usia, baik perempuan maupun laki-laki (Sarwono, 2016).

Penetapan sasaran kesehatan reproduksi bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan secara tepat sesuai kebutuhan usia, kondisi, dan masalah kesehatan reproduksi yang dialami individu atau kelompok masyarakat. Kelompok Sasaran Kesehatan Reproduksi, yaitu:

1. Remaja

Remaja adalah individu yang berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, biasanya pada usia 10–19 tahun. Masa remaja merupakan periode terjadinya perubahan fisik, psikologis, hormonal, dan sosial. Pada masa ini remaja mulai mengalami pubertas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai reproduksi dan seksual.

2. Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang berada pada usia reproduktif dan memiliki kemungkinan untuk memperoleh keturunan, biasanya usia 15–49 tahun.

E. Perencanaan Kehamilan sehat

Perencanaan kehamilan sehat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempersiapkan kehamilan secara menyeluruh sebelum terjadinya pembuahan. Persiapan tersebut meliputi kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi agar ibu dapat menjalani kehamilan dengan aman serta melahirkan bayi yang sehat. Perencanaan kehamilan tidak hanya berfokus pada penentuan waktu yang tepat untuk memiliki anak, tetapi juga menekankan pentingnya kesiapan pasangan dalam menghadapi proses kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan anak (Adelle Prasetyo, 2021).

Kehamilan yang direncanakan dengan baik dapat membantu pasangan mempersiapkan kondisi tubuh dan kesehatan reproduksi secara optimal. Ibu yang memiliki kondisi kesehatan baik sebelum hamil cenderung memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang mengalami kehamilan tanpa persiapan. Persiapan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi asam folat, serta menghindari kebiasaan yang dapat membahayakan kehamilan seperti merokok dan konsumsi alkohol.

Selain kesiapan ibu, kesiapan ayah juga memiliki peranan yang sangat penting. Dukungan suami dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan psikologis ibu selama masa kehamilan. Suami yang terlibat aktif dalam perencanaan kehamilan biasanya lebih mampu memberikan dukungan emosional, membantu memenuhi kebutuhan ibu, serta mendampingi selama pemeriksaan kehamilan. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan sebaiknya dilakukan secara

bersama-sama oleh pasangan suami istri agar tercipta kehamilan yang sehat, aman, dan berkualitas (Sarwono Prawirohardjo, 2016).

Perencanaan kehamilan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:

1. Mempersiapkan kondisi fisik ibu
2. Menurunkan resiko komplikasi kehamilan
3. Menjamin pertumbuhan dan perkembangan janin
4. Mempersiapkan mental dan emosional
5. Mengatur jarak dan jumlah anak

F. Kesehatan Ibu Hamil dan Komplikasi

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dialami perempuan sejak terjadinya pembuahan hingga persalinan. Masa kehamilan adalah periode penting karena di dalamnya terjadi pertumbuhan dan perkembangan janin yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu. Oleh karena itu, kesehatan ibu hamil harus dijaga secara optimal agar ibu dapat menjalani kehamilan dengan aman dan melahirkan bayi yang sehat (Sulistyawati, 2013).

Kesehatan ibu hamil tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi mencakup keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, dan emosional selama masa kehamilan. Ibu hamil yang sehat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan janin, menjaga kondisi tubuh, serta mempersiapkan persalinan dengan baik. Sebaliknya, gangguan kesehatan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin (Romauli, 2011).

Selama kehamilan tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis untuk mendukung pertumbuhan janin. Perubahan tersebut meliputi perubahan sistem reproduksi, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, dan perubahan hormonal. Rahim akan membesar sesuai pertumbuhan janin, volume darah meningkat, serta terjadi perubahan hormon estrogen dan progesteron yang memengaruhi kondisi fisik dan emosional ibu (ICM, 2021).

Pada trimester pertama, ibu sering mengalami mual dan muntah akibat perubahan hormon kehamilan. Kondisi ini dikenal sebagai morning sickness. Selain itu, ibu juga dapat merasa lemas, mudah lelah, dan mengalami perubahan emosi. Pada trimester kedua biasanya kondisi ibu mulai membaik dan janin berkembang lebih cepat. Sementara pada trimester ketiga, ibu mulai merasakan ketidaknyamanan akibat ukuran janin yang semakin besar, seperti nyeri punggung, sesak napas ringan, dan sulit tidur (UNICEF, 2022).

Untuk menjaga kesehatan selama kehamilan, ibu memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi nutrisi, istirahat, aktivitas fisik, kebersihan diri, serta

pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nutrisi merupakan salah satu faktor penting karena kebutuhan zat gizi meningkat selama kehamilan. Ibu hamil memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan jaringan, zat besi untuk mencegah anemia, asam folat untuk perkembangan sistem saraf janin, kalsium untuk pembentukan tulang, serta vitamin dan mineral lainnya. Pola makan ibu hamil harus mengandung makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, buah-buahan, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia, gangguan pertumbuhan janin, bayi berat lahir rendah, hingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi (Manuaba, 2020).

Selain nutrisi, istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh ibu. Kehamilan menyebabkan tubuh bekerja lebih berat sehingga ibu mudah mengalami kelelahan. Ibu hamil dianjurkan tidur cukup dan menghindari aktivitas berat yang berlebihan. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau senam hamil dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, memperlancar peredaran darah, dan mempersiapkan persalinan (UNFPA, 2021).

Kebersihan diri juga perlu diperhatikan selama kehamilan. Ibu hamil harus menjaga kebersihan organ reproduksi, kebersihan payudara, serta kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah infeksi. Infeksi selama kehamilan dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janin. Salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin atau Antenatal Care (ANC). Pemeriksaan ANC bertujuan memantau kondisi kesehatan ibu dan pertumbuhan janin, mendeteksi komplikasi secara dini, serta memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil. Pemeriksaan ANC meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut jantung janin, pemeriksaan laboratorium, pemberian imunisasi, dan pemberian tablet tambah darah (Manuaba, 2020).

Pemeriksaan rutin sangat penting karena tidak semua komplikasi kehamilan menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Dengan deteksi dini, komplikasi dapat ditangani lebih cepat sehingga risiko yang lebih berat dapat dicegah. Meskipun kehamilan merupakan proses normal, pada beberapa kondisi dapat terjadi komplikasi yang membahayakan ibu dan janin. Komplikasi kehamilan adalah gangguan kesehatan yang terjadi selama masa kehamilan dan memerlukan penanganan khusus. Komplikasi dapat disebabkan oleh faktor kesehatan ibu, usia, status gizi, penyakit tertentu, maupun kurangnya pemeriksaan kehamilan. Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah anemia pada kehamilan. Anemia merupakan kondisi kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun. Penyebab utama anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi akibat meningkatnya

kebutuhan selama kehamilan. Ibu hamil yang mengalami anemia biasanya tampak pucat, lemas, mudah lelah, dan pusing. Anemia dapat meningkatkan risiko perdarahan saat persalinan, persalinan prematur, dan bayi berat lahir rendah. Pencegahan anemia dilakukan dengan konsumsi makanan kaya zat besi dan tablet tambah darah secara rutin (Manuaba, 2020).

Komplikasi lain yang berbahaya adalah hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi terjadi apabila tekanan darah ibu hamil mencapai 140/90 mmHg atau lebih. Hipertensi dapat berkembang menjadi preeklamsia, yaitu kondisi tekanan darah tinggi yang disertai protein dalam urin dan pembengkakan tubuh. Preeklamsia merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu dan janin. Ibu hamil dengan preeklamsia biasanya mengalami sakit kepala berat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan pembengkakan pada wajah serta tangan. Jika tidak segera ditangani, preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia yang ditandai dengan kejang dan dapat mengancam nyawa ibu maupun janin. Oleh karena itu, pemeriksaan tekanan darah secara rutin selama ANC sangat penting dilakukan (ACOG, 2020).

Selain hipertensi, diabetes gestasional juga merupakan komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan. Diabetes gestasional adalah peningkatan kadar gula darah yang muncul saat hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan besar sehingga persalinan menjadi lebih sulit. Diabetes gestasional juga meningkatkan risiko persalinan dengan operasi sesar dan gangguan kesehatan pada bayi setelah lahir. Pencegahan dilakukan dengan menjaga pola makan sehat, olahraga, dan pemeriksaan gula darah secara rutin (Sarwono, 2016).

Perdarahan selama kehamilan merupakan kondisi yang sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Perdarahan dapat terjadi akibat keguguran, plasenta previa, atau solusio plasenta. Perdarahan berat dapat menyebabkan syok dan kematian ibu apabila tidak segera mendapatkan pertolongan medis. Infeksi pada kehamilan juga dapat menimbulkan komplikasi serius. Infeksi seperti infeksi saluran kemih, HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan TORCH dapat memengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Infeksi tertentu bahkan dapat menyebabkan keguguran, cacat bawaan, atau kematian janin. Oleh karena itu, ibu hamil harus menjaga kebersihan diri dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (WHO, 2022).

Selain komplikasi fisik, ibu hamil juga dapat mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, dan depresi. Perubahan hormon dan kekhawatiran terhadap persalinan sering memengaruhi kondisi emosional ibu. Dukungan

keluarga, terutama suami, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental ibu hamil.

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, antara lain usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, jarak kehamilan terlalu dekat, anemia, kekurangan gizi, penyakit kronis, serta riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya. Kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun maupun lebih dari 35 tahun memiliki risiko komplikasi lebih tinggi dibandingkan usia reproduksi sehat.

Untuk mencegah komplikasi kehamilan, diperlukan upaya promotif dan preventif secara menyeluruh. Ibu hamil dianjurkan melakukan pemeriksaan ANC secara rutin, memenuhi kebutuhan gizi, mengonsumsi tablet tambah darah, menjaga kebersihan diri, menghindari rokok dan alkohol, serta mengenali tanda bahaya kehamilan. Bidan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Bidan bertugas memberikan pelayanan antenatal, melakukan deteksi dini komplikasi, memberikan edukasi kesehatan, konseling gizi, serta melakukan rujukan apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bidan juga berperan dalam memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga agar ibu merasa aman dan nyaman selama kehamilan (Leonard, 2020).

Pendidikan kesehatan kepada ibu hamil sangat penting agar ibu memahami cara menjaga kesehatan selama kehamilan. Materi edukasi meliputi kebutuhan nutrisi, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, perawatan payudara, ASI eksklusif, dan keluarga berencana pasca persalinan. Dengan pelayanan kesehatan yang baik, pemeriksaan rutin, dukungan keluarga, dan pengetahuan yang cukup, sebagian besar komplikasi kehamilan dapat dicegah atau ditangani lebih awal. Kesehatan ibu hamil harus menjadi perhatian bersama karena menentukan kualitas generasi yang akan datang. Kehamilan yang sehat akan mendukung persalinan yang aman, bayi lahir sehat, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan keluarga.

G. Simpulan

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi manusia. Kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada bebasnya seseorang dari penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara aman, sehat, dan bertanggung jawab. Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta akses pelayanan kesehatan yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas kesehatan individu.

Tujuan kesehatan reproduksi adalah meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta kesejahteraan perempuan dan laki-laki dalam menjalankan fungsi reproduksi. Sasaran kesehatan reproduksi mencakup seluruh kelompok usia,

terutama remaja dan pasangan usia subur, melalui edukasi, pelayanan kesehatan, dan dukungan sosial yang sesuai kebutuhan.

Perencanaan kehamilan sehat sangat penting untuk mempersiapkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi pasangan sebelum kehamilan terjadi sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi dan mendukung tumbuh kembang janin secara optimal. Selama kehamilan, kesehatan ibu harus dijaga melalui pemenuhan nutrisi, istirahat cukup, kebersihan diri, aktivitas fisik yang sesuai, serta pemeriksaan kehamilan rutin. Komplikasi kehamilan seperti anemia, hipertensi, preeklamsia, diabetes gestasional, infeksi, dan perdarahan dapat membahayakan ibu maupun janin apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, deteksi dini, pelayanan antenatal yang optimal, edukasi kesehatan, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan terutama bidan sangat diperlukan untuk mewujudkan kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, dan generasi yang berkualitas (BKKBN, 2021).

H. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Guidelines for prenatal care and pregnancy complications*. Washington DC: ACOG.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Ida Bagus Gde Manuaba. (2020). *Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan KB untuk pendidikan bidan* (edisi revisi). Jakarta: EGC.
- International Confederation of Midwives. (2021). *Essential competencies for midwifery practice*. The Hague: ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA) revisi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lowdermilk Deitra Leonard. (2020). *Maternity and women's health care* (12th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Marmi. (2015). *Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho Taufan. (2014). *Kesehatan wanita, gender dan permasalahannya*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pillitteri Adele. (2021). *Maternal and child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Prawirohardjo Sarwono. (2011). *Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*. Jakarta: PT Bina Pustaka.
- Saifuddin Abdul Bari. (2014). *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sarwono Prawirohardjo. (2016). *Ilmu kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sulistyawati Ari. (2013). *Asuhan kebidanan pada masa kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika.
- United Nations Children's Fund. (2022). *Maternal and newborn health coverage report*. New York: UNICEF.
- Varney's Midwifery. (2015). *Varney's midwifery* (5th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Varney's Midwifery. (2022). *Varney's midwifery* (7th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Wiknjosastro Hanifa. (2012). *Ilmu kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

World Health Organization. (2020). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2023). *Improving maternal and newborn health and survival*. Geneva: WHO.

I. Glosarium

PUS = Pasangan Usia Subur

ANC = Antenatal Care

CHAPTER 6

KESIAPAN PSIKOLOGIS DAN SOSIAL DALAM MEMASUKI PERNIKAHAN

Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu fase perkembangan penting dalam kehidupan manusia, khususnya pada masa dewasa awal. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai proses penyatuan psikologis, emosional, sosial, dan budaya yang membutuhkan kesiapan matang dari kedua individu. Dalam kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri dituntut untuk mampu menjalankan peran, tanggung jawab, serta membangun relasi interpersonal yang sehat dan berkelanjutan.

Di Indonesia, meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan yang memadai. Data menunjukkan bahwa konflik rumah tangga sering dipicu oleh masalah komunikasi, ketidakmatangan emosi, ketidaksiapan menjalankan peran, serta rendahnya kemampuan adaptasi sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesiapan memasuki pernikahan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan ekonomi, tetapi juga kesiapan psikologis dan sosial yang kuat.

Kesiapan psikologis mencakup kematangan emosi, stabilitas mental, kemampuan mengelola konflik, dan kesiapan menjalankan peran sebagai pasangan. Sementara itu, kesiapan sosial berkaitan dengan kemampuan komunikasi interpersonal, dukungan sosial, adaptasi sosial, serta kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan pasangan maupun keluarga besar. Kedua aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Dalam konteks kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga, kesiapan menikah juga memiliki hubungan erat dengan kesiapan menjadi orang tua, pengambilan keputusan reproduksi, serta kualitas pengasuhan anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki pernikahan menjadi penting untuk dipahami, khususnya oleh remaja dan dewasa awal sebagai kelompok usia yang sedang mempersiapkan kehidupan berkeluarga.

B. Konsep Kesiapan Pernikahan

Kesiapan pernikahan (*marital readiness*) merupakan kondisi individu yang menunjukkan kesiapan menyeluruh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kesiapan ini tidak hanya berkaitan dengan usia biologis atau kesiapan ekonomi, tetapi juga melibatkan kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual (Carroll et al., 2020).

Menurut Wahidha et al. (2024), kesiapan menikah merupakan kondisi multidimensional yang meliputi:

1. kesiapan psikologis,
2. kesiapan sosial,
3. kesiapan emosional,
4. kesiapan ekonomi, dan
5. kesiapan menjalankan peran keluarga.

Kesiapan menikah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan hubungan pernikahan. Individu yang memiliki kesiapan menikah yang baik cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi, komunikasi interpersonal yang lebih efektif, serta kemampuan penyelesaian konflik yang lebih sehat dibandingkan individu yang belum siap menikah.

Selain itu, kesiapan menikah juga berkaitan dengan proses perkembangan individu pada masa dewasa awal. Pada tahap ini, individu mulai membangun hubungan intim yang stabil dan berkomitmen sebagai bagian dari tugas perkembangan psikososial (Santrock, 2021).

C. Perspektif Teori tentang Kesiapan Pernikahan

Kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki pernikahan dapat dipahami melalui beberapa pendekatan teori psikologi dan perkembangan manusia. Teori-teori tersebut membantu menjelaskan bagaimana individu membangun hubungan intim, menghadapi perubahan peran, serta menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga.

1. Teori Perkembangan Psikososial Erikson

Menurut Erikson, dewasa awal merupakan tahap *intimacy versus isolation*, yaitu fase ketika individu mulai membangun hubungan intim dan komitmen jangka panjang dengan orang lain (Santrock, 2021). Individu yang berhasil melewati tahap ini akan mampu membangun hubungan yang sehat dan penuh komitmen, sedangkan individu yang gagal cenderung mengalami kesulitan dalam membangun kedekatan emosional.

Dalam konteks pernikahan, keberhasilan membangun intimacy ditandai dengan:

- a. kemampuan membangun kepercayaan,

- b. keterbukaan emosional,
- c. kemampuan berbagi tanggung jawab,
- d. komitmen terhadap hubungan.

Sebaliknya, kegagalan dalam tahap ini dapat menyebabkan rasa takut terhadap komitmen dan ketidakmampuan mempertahankan hubungan jangka panjang.

2. Teori Attachment (Kelekatan)

Teori attachment menjelaskan bahwa pola hubungan individu dengan orang tua pada masa anak-anak dapat memengaruhi kualitas hubungan interpersonal pada masa dewasa, termasuk dalam pernikahan.

Individu dengan *secure attachment* cenderung:

- a. lebih percaya terhadap pasangan,
- b. mampu menjalin komunikasi yang sehat,
- c. memiliki kestabilan emosi yang lebih baik.

Sebaliknya, individu dengan *insecure attachment* lebih rentan mengalami kecemasan, ketergantungan emosional, atau kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan pernikahan (Rauer et al., 2020).

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam suatu hubungan. Dalam pernikahan, pasangan cenderung mempertahankan hubungan apabila hubungan tersebut memberikan kepuasan emosional, dukungan sosial, dan rasa aman.

Kesiapan sosial menjadi penting karena pasangan harus mampu:

- a. membangun hubungan saling mendukung,
- b. menunjukkan penghargaan,
- c. menciptakan keseimbangan peran dalam rumah tangga.

D. Kesiapan Pernikahan pada Remaja dan Dewasa Awal

Masa remaja dan dewasa awal merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan kesiapan memasuki kehidupan berkeluarga. Namun, pada masa ini individu sering kali masih berada dalam proses pencarian jati diri, kestabilan emosi, dan kemandirian ekonomi.

1. Tantangan Kesiapan Menikah pada Remaja

Pernikahan usia muda masih menjadi masalah di berbagai daerah di Indonesia. Remaja yang menikah pada usia terlalu dini sering kali belum memiliki kesiapan psikologis maupun sosial yang memadai.

Dampak ketidaksiapan tersebut meliputi:

- a. konflik rumah tangga,
- b. stres psikologis,
- c. kekerasan dalam rumah tangga,
- d. perceraian,
- e. gangguan kesehatan reproduksi.

Ariani et al. (2025) menyebutkan bahwa peningkatan *self-awareness* pada remaja dapat membantu membentuk kesiapan psikososial dan mencegah pernikahan dini.

2. Pentingnya Kematangan pada Dewasa Awal

Pada masa dewasa awal, individu mulai memiliki:

- a. kestabilan identitas,
- b. kemampuan pengambilan keputusan,
- c. kemandirian sosial,
- d. kesiapan emosional yang lebih baik.

Oleh karena itu, dewasa awal dianggap sebagai periode yang lebih ideal untuk memasuki pernikahan dibandingkan masa remaja.

E. Kesiapan Psikologis dalam Memasuki Pernikahan

1. Pengertian Kesiapan Psikologis

Kesiapan psikologis merupakan kondisi mental dan emosional individu yang memungkinkan dirinya mampu menjalani kehidupan pernikahan secara sehat dan adaptif. Kesiapan ini mencakup kemampuan memahami diri sendiri, mengelola emosi, menyelesaikan konflik, serta beradaptasi terhadap perubahan kehidupan setelah menikah (Willoughby et al., 2021).

Kesiapan psikologis menjadi fondasi utama dalam hubungan pernikahan karena kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika interpersonal. Individu yang matang secara psikologis akan lebih mampu menghadapi tekanan, perbedaan pendapat, serta perubahan peran dalam keluarga.

2. Kematangan Emosi

Kematangan emosi merupakan salah satu indikator utama kesiapan psikologis. Individu yang matang secara emosi mampu mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara tepat tanpa menyakiti pasangan. Kematangan emosi juga berkaitan dengan kemampuan bersikap sabar, toleran, dan empatik dalam hubungan interpersonal.

Penelitian Ulfa et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat kematangan emosi memiliki hubungan signifikan dengan kesiapan menikah pada wanita dewasa awal. Individu yang memiliki kematangan emosi tinggi cenderung lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga dibandingkan individu dengan kematangan emosi rendah.

Dalam kehidupan pernikahan, kematangan emosi membantu pasangan untuk:

- a. mengelola konflik secara konstruktif,
- b. menghindari perilaku impulsif,
- c. membangun komunikasi yang sehat,
- d. meningkatkan kepuasan pernikahan.

Sebaliknya, ketidakmatangan emosi dapat memicu pertengkaran, perilaku agresif, hingga ketidakstabilan hubungan rumah tangga.

3. Stabilitas Mental dan Identitas Diri

Stabilitas mental berkaitan dengan kondisi psikologis individu yang sehat, termasuk konsep diri positif, rasa percaya diri, serta kemampuan menghadapi tekanan hidup. Individu dengan identitas diri yang matang umumnya memiliki tujuan hidup yang jelas dan mampu menjalankan peran sebagai pasangan secara lebih stabil.

Papalia dan Martorell (2021) menjelaskan bahwa identitas diri yang matang membantu individu membangun hubungan intim yang sehat karena individu mampu memahami kebutuhan diri sendiri maupun pasangan. Sebaliknya, individu yang masih mengalami kebingungan identitas cenderung mengalami kesulitan dalam menjalankan peran dalam rumah tangga.

4. Kemampuan Mengelola Konflik

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan pernikahan. Perbedaan karakter, nilai, kebiasaan, maupun pola komunikasi dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kemampuan mengelola konflik menjadi salah satu bentuk kesiapan psikologis yang penting.

Pasangan yang memiliki kemampuan penyelesaian konflik yang baik cenderung:

- a. menggunakan komunikasi terbuka,
- b. menghargai pendapat pasangan,
- c. mencari solusi bersama,
- d. menghindari kekerasan verbal maupun fisik.

Markman et al. (2022) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik yang baik berhubungan dengan meningkatnya stabilitas dan kepuasan pernikahan.

5. Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran

Setelah menikah, individu akan mengalami perubahan peran dan tanggung jawab. Perubahan tersebut meliputi:

- a. peran sebagai suami atau istri,
- b. peran sebagai anggota keluarga baru,
- c. peran sebagai calon orang tua.

Kesiapan menghadapi perubahan menjadi penting karena banyak individu mengalami stres ketika tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan baru dalam rumah tangga.

F. Kesiapan Sosial dalam Memasuki Pernikahan

1. Pengertian Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan menjalankan fungsi sosial secara efektif dalam kehidupan pernikahan. Kesiapan sosial tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan pasangan, tetapi juga mencakup hubungan dengan keluarga besar, lingkungan masyarakat, serta kemampuan menjalankan peran sosial baru setelah menikah.

Dalam kehidupan rumah tangga, individu dituntut untuk mampu bekerja sama, membangun komunikasi interpersonal yang sehat, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Oleh karena itu, kesiapan sosial menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan keharmonisan pernikahan (Badger & Smith, 2022).

Menurut Wahidha et al. (2024), kesiapan sosial dalam pernikahan mencakup:

- a. kemampuan komunikasi interpersonal,
- b. kemampuan adaptasi sosial,
- c. pemahaman peran sosial,
- d. kemampuan membangun relasi interpersonal,
- e. kemampuan bekerja sama dalam keluarga.

Kesiapan sosial membantu pasangan membangun hubungan yang sehat dan stabil, sehingga mampu menghadapi perubahan dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Adaptasi Sosial dalam Kehidupan Pernikahan

Pernikahan mempertemukan dua individu dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, pola asuh, kebiasaan, maupun nilai kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi sosial sangat diperlukan dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis.

Adaptasi sosial merupakan kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial dan perubahan peran dalam kehidupan rumah tangga. Adaptasi yang baik membantu pasangan untuk:

- a. memahami perbedaan karakter,
- b. menerima kebiasaan pasangan,
- c. membangun kerja sama,
- d. mengurangi konflik interpersonal.

Whitton dan Kuryluk (2021) menyatakan bahwa kemampuan adaptasi sosial berhubungan dengan stabilitas hubungan dan kepuasan pernikahan. Individu yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga.

3. Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan bantuan emosional, informasi, maupun dukungan praktis yang diperoleh individu dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial. Dukungan sosial berperan penting dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan individu memasuki pernikahan.

Wilis et al. (2025) menemukan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan menikah pada generasi milenial. Individu yang mendapatkan dukungan positif dari keluarga dan lingkungan cenderung memiliki kesiapan psikososial yang lebih baik.

Dukungan sosial dapat berupa:

- a. dukungan emosional,
- b. dukungan informasi,
- c. dukungan penghargaan,
- d. dukungan instrumental.

4. Kemampuan Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal menjadi dasar utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat. Kemampuan komunikasi membantu pasangan memahami kebutuhan, harapan, dan perasaan satu sama lain.

Komunikasi yang efektif ditandai dengan:

- a. kemampuan mendengarkan aktif,

- b. keterbukaan,
- c. empati,
- d. kemampuan menyampaikan pendapat secara asertif.

Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.

5. Adaptasi Sosial dalam Pernikahan

Pernikahan mempertemukan dua individu dengan latar belakang keluarga, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan pernikahan.

Kemampuan adaptasi meliputi:

- a. toleransi terhadap perbedaan,
- b. fleksibilitas,
- c. kemampuan bekerja sama,
- d. keterbukaan terhadap perubahan.

Whitton dan Kuryluk (2021) menjelaskan bahwa pasangan yang mampu beradaptasi dengan baik cenderung memiliki hubungan pernikahan yang lebih stabil dan harmonis.

6. Pemahaman Peran Sosial dalam Keluarga

Setelah menikah, individu akan menjalani berbagai peran sosial baru, baik dalam keluarga inti maupun keluarga besar. Pemahaman terhadap peran tersebut penting agar individu mampu menjalankan tanggung jawab secara seimbang.

Khotimah dan Mujiono (2025) menjelaskan bahwa kesiapan menjalankan peran sosial dalam keluarga berkaitan dengan kemampuan individu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

G. Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Psikologis dan Sosial

Beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki pernikahan antara lain:

1. Usia dan Tahap Perkembangan

Usia dewasa awal merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan pencarian identitas dan pembentukan hubungan intim yang stabil (Santrock, 2021).

2. Pendidikan

Pendidikan memengaruhi pola pikir, kemampuan pengambilan keputusan, serta kemampuan penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga.

3. Pengalaman Relasi

Pengalaman dalam menjalin hubungan interpersonal membantu individu memahami dinamika komunikasi dan konflik dalam hubungan.

4. Lingkungan Keluarga

Pola asuh dan pengalaman keluarga sebelumnya dapat memengaruhi kesiapan individu dalam menjalani pernikahan.

5. Dukungan Sosial

Dukungan dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor protektif dalam meningkatkan kesiapan menikah.

6. Konseling dan Edukasi Pranikah

Program edukasi pranikah membantu individu memahami realitas kehidupan rumah tangga dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta penyelesaian konflik.

H. Dampak Ketidaksiapan dalam Pernikahan

Ketidaksiapan psikologis dan sosial dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti:

1. konflik berkepanjangan,
2. kekerasan dalam rumah tangga,
3. ketidakpuasan pernikahan,
4. perceraian,
5. gangguan kesehatan mental.

Aini dan Afdal (2020) menyatakan bahwa ketidaksiapan psikologis menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik rumah tangga pada pasangan muda. Selain itu, kurangnya kesiapan sosial dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dengan pasangan maupun keluarga besar.

I. Upaya Meningkatkan Kesiapan Psikologis dan Sosial

1. Pendidikan dan Edukasi Pranikah

Edukasi pranikah membantu individu memahami:

- a. hak dan kewajiban dalam pernikahan,
- b. komunikasi pasangan,
- c. kesehatan reproduksi,
- d. pengasuhan anak.

2. Konseling Pranikah

Konseling pranikah membantu pasangan mengenali potensi konflik dan meningkatkan kesiapan emosional sebelum menikah.

3. Pengembangan Kecerdasan Emosional

Pelatihan pengelolaan emosi dapat membantu individu meningkatkan kematangan emosi dan kemampuan coping.

4. Penguatan Dukungan Sosial

Keluarga dan lingkungan perlu memberikan dukungan positif terhadap individu yang akan memasuki pernikahan.

5. Pelatihan Komunikasi Interpersonal

Pelatihan komunikasi membantu pasangan meningkatkan keterampilan menyampaikan pendapat dan menyelesaikan konflik secara sehat.

J. Hubungan Kesiapan Pernikahan dengan Kesehatan Mental

Kesehatan mental memiliki hubungan erat dengan kualitas hubungan pernikahan. Individu dengan kondisi mental yang baik cenderung:

- a. mampu mengelola stres,
- b. lebih stabil secara emosional,
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Sebaliknya, gangguan kesehatan mental yang tidak ditangani dapat memengaruhi kualitas hubungan rumah tangga.

1. Stres dalam Pernikahan

Setelah menikah, pasangan akan menghadapi berbagai stresor seperti:

- a. masalah ekonomi,
- b. konflik pengasuhan anak,
- c. tuntutan pekerjaan,
- d. konflik keluarga besar.

2. Apabila pasangan tidak memiliki kesiapan psikologis yang baik, stres tersebut **dapat** berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

3. Kecerdasan Emosional dalam Pernikahan

Kecerdasan emosional (*emotional intelligence*) merupakan kemampuan individu mengenali dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain.

Kecerdasan emosional membantu pasangan untuk:

- a. memahami perasaan pasangan,
- b. meningkatkan empati,
- c. mengurangi konflik,
- d. membangun hubungan harmonis.

Pasangan dengan kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki kualitas hubungan yang lebih baik dan tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi.

K. Peran Keluarga dalam Mempersiapkan Pernikahan

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kesiapan psikologis dan sosial individu. Pola komunikasi, pola asuh, dan kualitas hubungan dalam keluarga akan memengaruhi cara individu menjalani hubungan interpersonal pada masa dewasa.

1. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh yang suportif membantu anak mengembangkan:

- a. rasa percaya diri,
- b. kestabilan emosi,
- c. kemampuan komunikasi interpersonal.

Sebaliknya, pola asuh yang otoriter atau penuh konflik dapat meningkatkan risiko munculnya masalah emosional dalam hubungan pernikahan di masa depan.

2. Pendidikan Kehidupan Berkeluarga

Keluarga juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan tentang:

- a. nilai pernikahan,
- b. tanggung jawab keluarga,
- c. komunikasi pasangan,
- d. pengelolaan konflik.

Pendidikan ini membantu individu memiliki gambaran realistis tentang kehidupan rumah tangga.

L. Kesiapan Pernikahan dalam Perspektif Sosial Budaya Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, aspek sosial budaya memiliki pengaruh besar terhadap kesiapan menikah.

1. Pengaruh Budaya terhadap Pernikahan

Budaya memengaruhi:

- a. pembagian peran gender,
- b. nilai keluarga,
- c. pola komunikasi,
- d. ekspektasi terhadap pasangan.

Pada beberapa budaya, perempuan masih diharapkan menjalankan peran domestik lebih dominan, sedangkan laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama. Perbedaan ekspektasi budaya dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikomunikasikan dengan baik sebelum menikah.

2. Nilai Agama dalam Kesiapan Pernikahan

Nilai agama berperan dalam membentuk:

- a. komitmen pernikahan,
- b. tanggung jawab moral,
- c. kemampuan mengendalikan diri,
- d. pola hubungan dalam keluarga.

Kesiapan spiritual membantu pasangan menghadapi konflik dengan lebih bijaksana dan mempertahankan komitmen dalam pernikahan.

M. Konseling Pranikah sebagai Upaya Persiapan Pernikahan

Konseling pranikah merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan sebelum menikah agar memiliki kesiapan psikologis, sosial, dan emosional yang lebih baik.

1. Tujuan Konseling Pranikah

Konseling pranikah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesiapan menikah,
- b. membantu pasangan memahami perbedaan karakter,
- c. meningkatkan keterampilan komunikasi,
- d. membantu perencanaan kehidupan keluarga.

2. Materi Konseling Pranikah

Materi konseling pranikah umumnya meliputi:

- a. komunikasi pasangan,
- b. kesehatan reproduksi,
- c. manajemen konflik,
- d. pengelolaan ekonomi keluarga,
- e. kesiapan menjadi orang tua.

Program konseling pranikah terbukti efektif meningkatkan kualitas hubungan dan menurunkan risiko konflik rumah tangga (Markman et al., 2022).

N. Implikasi Kesiapan Pernikahan terhadap Kehidupan Keluarga

Kesiapan psikologis dan sosial yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kualitas kehidupan keluarga.

1. Terbentuknya Hubungan Pernikahan yang Harmonis

Pasangan yang siap menikah cenderung:

- a. memiliki komunikasi yang sehat,
- b. mampu bekerja sama,
- c. saling mendukung secara emosional.

2. Kesiapan Menjadi Orang Tua

Kesiapan menikah juga memengaruhi kesiapan menjalankan peran sebagai orang tua. Pasangan yang matang secara emosional lebih mampu:

- a. memberikan pengasuhan positif,
- b. membangun ikatan emosional dengan anak,
- c. menciptakan lingkungan keluarga yang sehat.

3. Pencegahan Konflik dan Perceraian

Kesiapan psikologis dan sosial dapat menjadi faktor protektif dalam mencegah:

- a. konflik rumah tangga,
- b. kekerasan dalam rumah tangga,
- c. perceraian.

Dengan kesiapan yang baik, pasangan akan lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan keluarga secara adaptif.

O. Kesimpulan

Kesiapan psikologis dan sosial merupakan aspek fundamental dalam memasuki kehidupan pernikahan. Kesiapan tersebut mencakup kematangan emosi, stabilitas mental, kemampuan komunikasi interpersonal, dukungan sosial, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan peran dalam keluarga.

Kesiapan menikah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses perkembangan individu, pengalaman relasi, pendidikan, serta dukungan lingkungan keluarga dan sosial. Oleh karena itu, edukasi pranikah, konseling, dan penguatan keterampilan psikososial perlu diberikan sejak remaja dan dewasa awal sebagai upaya membentuk keluarga yang sehat dan berkualitas.

Dengan kesiapan psikologis dan sosial yang optimal, pasangan diharapkan mampu membangun hubungan pernikahan yang harmonis, stabil, dan mendukung tumbuh kembang generasi berikutnya secara sehat fisik maupun mental.

P. Referensi

- Aini, H., & Afdal. (2020). Analisis kesiapan psikologis pasangan dalam menghadapi pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146.
- Badger, S., & Smith, K. (2022). Marriage readiness and social support among young adults. *Journal of Family Studies*, 28(3), 455–470. <https://doi.org/10.1080/13229400.2021.1895274>
- Carroll, J. S., Willoughby, B. J., & Badger, S. (2020). Readiness for marriage: Development of a new scale. *Journal of Family Psychology*, 34(1), 1–12. <https://doi.org/10.1037/fam0000589>

- Herawati, I., Yendra, D., & Amita, N. (2025). Kesiapan menikah pada generasi Z: Marital attitudes dan kematangan emosi. *Al-Hikmah*, 22(2).
- Khotimah, A. N., & Mujiono. (2025). Kesiapan menikah dalam perspektif psikologi pendidikan Islam. *Tsaqofah*, 5(5).
- Markman, H. J., Rhoades, G. K., & Stanley, S. M. (2022). Relationship education and marital outcomes: Evidence and implications. *Family Process*, 61(2), 543–558. <https://doi.org/10.1111/famp.12725>
- Papalia, D. E., & Martorell, G. (2021). *Experience human development* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2021). *Life-span development* (18th ed.). McGraw-Hill.
- Ulfa, R., Zubair, A. G. H., & Syarvia. (2025). Tingkat kematangan emosi sebagai prediktor kesiapan menikah wanita dewasa awal. *Jurnal Psikologi Karakter*, 5(2).
- Wahidha, D. N., Putri, M. D., Maharani, E. M. S., & Ruhaena, L. (2024). Alat ukur kesiapan menikah. *Jurnal Consulenza*, 7(2).
- Whitton, S. W., & Kuryluk, A. D. (2021). Relationship processes and marital functioning. *Journal of Social and Personal Relationships*, 38(6), 1623–1645. <https://doi.org/10.1177/02654075211004654>
- Wilis, A. P. L., Satiadarma, M. P., & Roswiyani. (2025). Kesiapan menikah generasi milenial: Peran persepsi menikah dan dukungan sosial. *Psyche 165 Journal*, 18(2).
- Willoughby, B. J., Carroll, J. S., & Busby, D. M. (2021). The different effects of “living together”: Determining marital readiness. *Journal of Family Issues*, 42(4), 857–879. <https://doi.org/10.1177/0192513X20929086>

CHAPTER 7

EVALUASI KESIAPAN PEREMPUAN DALAM MASA PRAKONSEPSI

Rikhly Faradisy Mursyida, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Masa prakonsepsi merupakan periode yang sangat menentukan kualitas kehamilan, persalinan, dan kesehatan bayi yang akan dilahirkan, karena pada fase ini kondisi fisik, gizi, psikologis, dan reproduksi perempuan dapat dinilai serta dioptimalkan sebelum terjadi konsepsi (Masruroh et al., 2024). Dalam konteks asuhan kebidanan pranikah, evaluasi kesiapan perempuan prakonsepsi menjadi penting karena calon pengantin tidak hanya dipersiapkan untuk menikah, tetapi juga untuk memasuki kehamilan yang direncanakan, aman, dan sehat (Nurqalbi et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang menempatkan perempuan sebagai pusat intervensi sejak sebelum kehamilan terjadi (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Urgensi evaluasi kesiapan prakonsepsi juga berkaitan erat dengan masalah stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, karena prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 masih berada pada angka 21,6 persen (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Angka tersebut menunjukkan bahwa intervensi tidak dapat hanya difokuskan pada masa kehamilan dan pascapersalinan, tetapi harus dimulai sejak sebelum pembuahan melalui deteksi dini faktor risiko pada calon ibu (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Melalui evaluasi prakonsepsi, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi anemia, kekurangan energi kronis, status imunisasi, penyakit menular, serta masalah psikososial yang berpotensi memengaruhi tumbuh kembang janin dan bayi (Masruroh et al., 2024).

Pemeriksaan kesehatan pranikah karena itu menjadi bagian strategis dalam pelayanan prakonsepsi, terutama bila dilakukan setidaknya tiga bulan sebelum pernikahan agar tersedia waktu yang cukup untuk melakukan intervensi perbaikan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Skrining tersebut meliputi pemeriksaan antropometri, kadar hemoglobin, status gizi, riwayat penyakit, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan sosial untuk menjalani kehamilan dan kehidupan berkeluarga (Masruroh et al., 2024). Buku ajar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi juga menegaskan bahwa Komunikasi, Informasi, dan

Edukasi atau KIE merupakan bagian integral dalam membantu calon pengantin memahami masa subur, kebutuhan nutrisi, pencegahan infeksi, dan perencanaan kehamilan sehat (Masruroh et al., 2024).

Meskipun demikian, kesiapan perempuan dalam masa prakonsepsi masih belum merata, terutama karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, dan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi (Laily & Farahdiba, 2025). Penelitian pada calon pengantin wanita di Kota Tarakan menunjukkan bahwa hanya 43,4 persen responden memiliki pengetahuan yang baik tentang persiapan prakonsepsi, sedangkan sisanya masih berada pada kategori cukup dan kurang, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan literasi kesehatan pada kelompok ini (Laily & Farahdiba, 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan prakonsepsi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh kemampuan perempuan dalam memahami dan memanfaatkan informasi kesehatan secara tepat (Laily & Farahdiba, 2025).

Selain faktor pengetahuan, rendahnya kesiapan prakonsepsi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya pada wilayah dengan jangkauan layanan yang belum optimal (Nurqalbi et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan banyak calon pengantin belum menjalani pemeriksaan pranikah secara komprehensif, sehingga faktor risiko yang sebenarnya dapat dicegah justru terdeteksi setelah kehamilan terjadi (Nurqalbi et al., 2024). Padahal, evaluasi yang dilakukan sejak pranikah akan memberikan peluang lebih besar bagi bidan untuk melakukan intervensi dini, rujukan, maupun konseling individual sesuai kebutuhan perempuan dan pasangannya (Masruroh et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi kesiapan perempuan dalam masa prakonsepsi pada calon pengantin perlu dipahami sebagai bagian penting dari asuhan kebidanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis pencegahan (Masruroh et al., 2024). Pembahasan ini penting untuk menegaskan bahwa kualitas generasi masa depan sangat dipengaruhi oleh kualitas persiapan kesehatan perempuan sebelum kehamilan terjadi, sehingga pelayanan pranikah dan prakonsepsi harus diperkuat baik pada aspek skrining, edukasi, maupun tindak lanjut intervensi (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Laily & Farahdiba, 2025).

B. Konsep evaluasi kesiapan prakonsepsi

Evaluasi kesiapan perempuan dalam masa prakonsepsi adalah proses penilaian menyeluruh terhadap keadaan biologis, psikologis, sosial, dan perilaku kesehatan perempuan sebelum terjadinya kehamilan. Dalam asuhan kebidanan, evaluasi ini tidak hanya bertujuan menentukan ada atau tidaknya penyakit, tetapi juga menilai apakah calon pengantin telah memiliki kondisi yang memadai untuk

menjalani kehamilan secara aman dan terencana (Masruroh et al., 2024) . Dengan demikian, evaluasi prakonsepsi harus dipahami sebagai proses identifikasi risiko sekaligus dasar penyusunan intervensi individual bagi calon pengantin.

Ruang lingkup evaluasi prakonsepsi mencakup penilaian status gizi, riwayat menstruasi, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, riwayat obstetri dan ginekologi, status imunisasi, kebiasaan hidup, kesehatan mental, dukungan keluarga, serta kesiapan sosial ekonomi. Pendekatan ini bersifat holistik karena banyak faktor yang tampak sederhana pada fase pranikah ternyata berpengaruh besar terhadap perjalanan kehamilan, misalnya anemia, obesitas, kurang energi kronis, infeksi menular seksual, atau kecemasan berat menjelang pernikahan (Masruroh et al., 2024; Nurqalbi et al., 2024) . Oleh sebab itu, bidan perlu memandang calon pengantin bukan hanya sebagai individu yang akan menikah, tetapi sebagai perempuan yang sedang dipersiapkan menuju reproduksi sehat.

Evaluasi ini juga penting sebagai bagian dari kesinambungan pelayanan kebidanan. Ketika faktor risiko ditemukan sebelum kehamilan, intervensi dapat dilakukan lebih dini sehingga hasilnya cenderung lebih baik dibandingkan bila masalah baru diketahui pada trimester pertama atau bahkan menjelang persalinan. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, evaluasi prakonsepsi berfungsi menurunkan peluang komplikasi maternal, kematian neonatal, berat badan lahir rendah, prematuritas, dan stunting melalui pencegahan sejak hulu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023) .

C. Calon Pengantin Wanita dengan Kesiapan Prakonsepsi Rendah

Calon pengantin wanita dengan kesiapan prakonsepsi rendah merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena kondisi ini berhubungan dengan meningkatnya risiko kehamilan tidak sehat, gangguan pertumbuhan janin, dan stunting pada anak yang akan dilahirkan (Laily & Farahdiba, 2025). Rendahnya kesiapan prakonsepsi umumnya ditandai oleh kurangnya pengetahuan tentang persiapan kehamilan, status gizi yang tidak optimal, adanya anemia, serta belum dilakukannya pemeriksaan kesehatan reproduksi secara menyeluruh sebelum menikah (Masruroh et al., 2024). Dalam pelayanan kebidanan, kondisi ini tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai masalah kesehatan masyarakat karena kualitas kesehatan perempuan sebelum hamil sangat menentukan kualitas generasi berikutnya (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Penelitian di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menunjukkan bahwa pengetahuan calon pengantin wanita tentang persiapan prakonsepsi masih belum merata, di mana responden yang tidak bekerja memiliki proporsi pengetahuan kurang sebesar 41,5 persen, sedangkan kelompok usia 20 sampai 30 tahun lebih

banyak berada pada kategori pengetahuan baik sebesar 43,4 persen (Laily & Farahdiba, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan prakonsepsi dipengaruhi oleh karakteristik sosial demografis, terutama usia, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga perempuan usia muda atau yang belum memiliki akses informasi yang memadai cenderung berada pada kondisi yang lebih rentan (Laily & Farahdiba, 2025). Dengan demikian, calon pengantin wanita yang masih berpengetahuan rendah memerlukan pendampingan dan edukasi lebih intensif sebelum memasuki kehamilan agar faktor risiko dapat dikendalikan sejak dini (Laily & Farahdiba, 2025).

Dari aspek klinis, kesiapan prakonsepsi rendah sering berkaitan dengan defisiensi nutrisi, terutama anemia dan kekurangan zat gizi mikro yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janin (Masruroh et al., 2024). Kondisi anemia pada perempuan sebelum hamil dapat meningkatkan risiko kelelahan, infeksi, gangguan pertumbuhan janin, persalinan prematur, dan berat badan lahir rendah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya stunting (Masruroh et al., 2024). Oleh sebab itu, evaluasi status gizi, kadar hemoglobin, indeks massa tubuh, serta kebiasaan makan harus menjadi bagian utama dalam pemeriksaan calon pengantin wanita dengan kesiapan prakonsepsi rendah (Masruroh et al., 2024).

Selain penilaian status gizi, buku ajar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi juga menjelaskan bahwa evaluasi fertilitas dapat dilakukan melalui pemeriksaan tambahan, seperti analisis semen pada pasangan, pemeriksaan mukus serviks, kurva suhu basal, tes fern, dan uji pascakoitus untuk menilai kemungkinan hambatan pembuahan (Masruroh et al., 2024). Pemeriksaan mukus serviks, misalnya, bertujuan menilai kualitas dan kuantitas lendir serviks dalam mendukung pergerakan sperma menuju ovum, sedangkan analisis semen dilakukan untuk melihat kualitas sperma pasangan sebagai bagian dari evaluasi fertilitas pasangan secara menyeluruh (Kitamenulis, 2023). Walaupun fokus utama pada subbab ini adalah perempuan, kesiapan prakonsepsi tetap harus dipahami sebagai kondisi pasangan, karena keberhasilan konsepsi yang sehat dipengaruhi oleh faktor reproduksi perempuan dan laki laki secara bersamaan (Masruroh et al., 2024).

Kesiapan prakonsepsi rendah juga dapat dipengaruhi oleh usia yang terlalu muda, terutama apabila perempuan belum mencapai kematangan biologis, psikologis, dan sosial untuk menjalani kehamilan (Laily & Farahdiba, 2025). Pada kelompok usia muda, pemahaman tentang masa subur, kebutuhan asam folat, pencegahan infeksi, dan pentingnya skrining pranikah sering kali masih terbatas, sehingga risiko keterlambatan deteksi masalah kesehatan menjadi lebih besar

(Masruroh et al., 2024). Kondisi ini semakin kompleks apabila disertai pengangguran atau ketergantungan ekonomi, karena akses terhadap informasi dan layanan kesehatan sering kali menjadi lebih terbatas (Laily & Farahdiba, 2025).

Pada masa pandemi dan era adaptasi kebiasaan baru COVID 19, pelayanan prakonsepsi bagi calon pengantin tetap dilakukan dengan penyesuaian protokol kesehatan dan tetap memenuhi standar minimal pelayanan (Suciati et al., 2021). Penelitian di wilayah kerja Puskesmas Purwojati menunjukkan bahwa pelayanan prakonsepsi selama era tersebut tetap meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan dan suplementasi status gizi, serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kesehatan dengan penerapan protokol pencegahan penularan COVID 19 (Suciati et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan situasional, pelayanan skrining prakonsepsi tetap dapat dijalankan dan tetap penting bagi calon pengantin wanita yang memiliki kesiapan rendah agar risiko kesehatan tidak terabaikan (Suciati et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, calon pengantin wanita dengan kesiapan prakonsepsi rendah merupakan kelompok prioritas dalam pelayanan kebidanan pranikah karena memiliki kerentanan lebih besar terhadap masalah gizi, kesehatan reproduksi, fertilitas, dan komplikasi kehamilan di masa depan (Masruroh et al., 2024; Laily & Farahdiba, 2025). Intervensi yang diperlukan tidak cukup hanya berupa pemeriksaan fisik, tetapi juga harus mencakup edukasi yang terarah, skrining laboratorium, pendampingan psikososial, dan rujukan bila ditemukan masalah kesehatan tertentu (Suciati et al., 2021; Masruroh et al., 2024). Dengan pendekatan tersebut, asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi dapat berperan nyata dalam meningkatkan kesiapan perempuan sebelum hamil dan menurunkan risiko stunting sejak tahap paling awal kehidupan (Laily & Farahdiba, 2025).

D. Komponen evaluasi kesiapan perempuan prakonsepsi

Evaluasi kesiapan perempuan prakonsepsi perlu dilakukan secara sistematis agar faktor risiko tidak terlewat. Komponen pertama adalah anamnesis menyeluruh yang mencakup identitas, umur, pekerjaan, pendidikan, riwayat menstruasi, riwayat penyakit kronis, penggunaan obat, riwayat alergi, riwayat operasi, riwayat keluarga dengan penyakit genetik, serta riwayat obstetri dan ginekologi bila ada (Masruroh et al., 2024; Nurqalbi et al., 2024). Anamnesis yang baik membantu bidan mengenali masalah tersembunyi yang tidak selalu tampak pada pemeriksaan fisik.

Komponen kedua adalah pemeriksaan fisik umum dan kebidanan. Pemeriksaan ini mencakup tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, indeks massa tubuh, pemeriksaan konjungtiva,

pemeriksaan payudara, dan bila diperlukan pemeriksaan organ reproduksi luar. Data tersebut penting untuk menilai anemia klinis, status gizi, obesitas, risiko hipertensi, dan kemungkinan gangguan kesehatan lain yang dapat mempengaruhi kehamilan (Masruroh et al., 2024) . Tinggi badan dan berat badan, misalnya, tidak sekadar menjadi data dasar, tetapi merupakan indikator penting untuk menilai potensi panggul sempit, kurang energi kronis, atau risiko metabolik.

Komponen ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan hemoglobin diperlukan untuk menilai status anemia, sedangkan golongan darah dan rhesus penting untukantisipasi risiko inkompatibilitas. Pemeriksaan gula darah puasa atau HbA1c membantu mendeteksi gangguan metabolik seperti diabetes, dan skrining infeksi seperti hepatitis B, sifilis, HIV, atau TORCH diperlukan pada kondisi tertentu sesuai indikasi klinis dan kebijakan layanan (Masruroh et al., 2024; Suciati et al., 2021) . Pemeriksaan laboratorium yang tepat akan memperkuat ketepatan intervensi karena keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada keluhan subjektif.

Komponen keempat adalah penilaian psikologis dan sosial. Bidan perlu menilai kecemasan, kesiapan mental menikah, dukungan pasangan, dukungan keluarga, potensi kekerasan dalam hubungan, kemampuan mengambil keputusan, serta kesiapan ekonomi dasar. Banyak calon pengantin tampak sehat secara fisik, tetapi belum siap secara emosional atau sosial untuk menghadapi kehamilan dan pengasuhan anak. Karena itu, evaluasi prakonsepsi yang baik harus menempatkan aspek psikologis sejajar dengan aspek biologis (Masruroh et al., 2024) .

Komponen kelima adalah penilaian perilaku kesehatan. Aspek ini mencakup kebiasaan makan, aktivitas fisik, pola tidur, konsumsi rokok, alkohol, atau zat lain, kebersihan diri, pengetahuan tentang masa subur, dan penggunaan layanan kesehatan. Penilaian perilaku penting karena banyak komplikasi kehamilan berakar pada kebiasaan yang sebenarnya dapat dimodifikasi melalui edukasi dan pendampingan. Dengan memahami perilaku kesehatan calon pengantin, bidan dapat memberikan KIE yang lebih spesifik dan realistis (Masruroh et al., 2024; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

E. Strategi Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier dalam Asuhan Kebidanan Pranikah-Prakonsepsi

1. Strategi Pencegahan Primer

Strategi pencegahan primer dalam asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi difokuskan pada upaya promotif dan preventif untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan reproduksi sebelum konsepsi terjadi (Masruroh et al., 2024) . Pencegahan primer bertujuan mengidentifikasi dan mengurangi

faktor risiko sosial, perilaku, lingkungan, dan biomedis yang dapat mempengaruhi kesuburan dan hasil kehamilan melalui pendidikan, konseling, dan intervensi yang tepat (Masruroh et al., 2024) .

KIE pranikah merupakan komponen utama strategi primer. Materi KIE dapat meliputi siklus menstruasi, masa subur, perencanaan kehamilan, kontrasepsi sementara, nutrisi prakonsepsi, asam folat, bahaya rokok, pengaruh alkohol, pencegahan infeksi menular seksual, serta pentingnya imunisasi sebelum kehamilan. KIE yang efektif tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu calon pengantin mengambil keputusan yang lebih sehat dan lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan reproduksinya (Masruroh et al., 2024) .

Promosi gaya hidup sehat juga menjadi bagian penting dari strategi primer. Calon pengantin perlu diarahkan untuk mencapai berat badan yang sehat, melakukan aktivitas fisik teratur, memperbaiki pola makan, mengurangi stres, dan menghindari paparan zat berbahaya. Intervensi seperti suplementasi asam folat minimal tiga bulan sebelum konsepsi, peningkatan asupan zat besi, dan penguatan konsumsi protein hewani relevan dalam konteks pencegahan stunting sejak sebelum kehamilan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Masruroh et al., 2024) .

Pendidikan berbasis digital dapat memperluas jangkauan strategi primer. Studi edukasi webinar menunjukkan peningkatan pengetahuan prakonsepsi yang sangat bermakna setelah intervensi pendidikan, sehingga pendekatan digital dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap layanan tatap muka, terutama pada populasi muda yang akrab dengan gawai dan media sosial (Jurnal Pemberdayaan Umat, 2026) . Dengan model ini, pesan kesehatan dapat diberikan secara lebih fleksibel, berulang, dan menjangkau sasaran yang sebelumnya sulit hadir secara langsung di fasilitas kesehatan.

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pranikah

KIE menggunakan metode audiovisual, leaflet, dan diskusi kelompok untuk menjelaskan siklus menstruasi, fertile window (hari 10-17), kontrasepsi sementara (pil, kondom), suplementasi asam folat 400-800 mcg/hari minimal 3 bulan pra-konsepsi mencegah neural tube defect, serta higiene genital dengan sabun antiseptik pH netral (Masruroh et al., 2024).

b. Promosi Gaya Hidup Sehat

Edukasi diet 4 sehat 5 sempurna + variasi lauk pauk, olahraga aerobik 150 menit/minggu (jalan cepat, senam), hindari rokok (meningkatkan infertilitas 30%), alkohol, kafein >200 mg/hari. Target BMI wanita Asia 18,5-

22,9 kg/m². Konseling stres pranikah dengan teknik relaksasi progresif (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Laily & Farahdiba, 2025).

c. Vaksinasi Pra-Konsepsi

MMR (Measles-Mumps-Rubella) dosis 1 minimal 28 hari sebelum konsepsi cegah sindrom rubella kongenital (SRC), TT dosis 1-2 interval 1 bulan untuk perlindungan tetanus neonatal, Hepatitis B screening + vaksinasi 3 dosis untuk cegah transmisi vertikal (Masruroh et al., 2024).

d. Edukasi Digital Berbasis Komunitas

Webinar via Zoom/WhatsApp meningkatkan pengetahuan prakonsepsi 100,15% (pretest 45,2% → posttest 90,7%, $p=0,000$) pada 53 calon pengantin, efektif untuk generasi digital dengan akses smartphone 95% (Jurnal Pemberdayaan Umat, 2026).

2. Strategi Penatalaksanaan Sekunder

Strategi penatalaksanaan sekunder bertujuan mendeteksi dini masalah kesehatan yang sudah ada agar dapat segera ditangani sebelum menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Dalam konteks prakonsepsi, strategi ini tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada faktor risiko biologis dan psikososial yang sudah mulai terbentuk pada calon pengantin.

Pelaksanaan strategi sekunder dilakukan melalui skrining terarah. Pemeriksaan hemoglobin, skrining status gizi, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, riwayat penyakit kronis, serta skrining infeksi merupakan bagian dasar dari deteksi dini. Pada situasi tertentu, bidan atau tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan pemeriksaan TORCH, HbA1c, atau pemeriksaan penunjang fertilitas bila terdapat indikasi klinis, riwayat gangguan reproduksi, atau kecurigaan infertilitas (Masruroh et al., 2024). Semakin dini masalah diketahui, semakin besar peluang intervensi berhasil sebelum perempuan hamil.

Penilaian pengetahuan juga merupakan bagian dari strategi sekunder karena rendahnya pengetahuan dapat dipandang sebagai faktor risiko fungsional dalam kesiapan prakonsepsi. Studi Tarakan tahun 2025 menunjukkan variasi tingkat pengetahuan yang nyata pada calon pengantin wanita, sehingga kuesioner atau instrumen sederhana dapat digunakan untuk memetakan kelompok berisiko yang membutuhkan edukasi lebih intensif (Laily & Farahdiba, 2025). Dengan demikian, skrining tidak hanya bertumpu pada pemeriksaan laboratorium, tetapi juga pada kemampuan memahami informasi kesehatan.

Pada masa pandemi COVID 19, strategi sekunder tetap dijalankan dengan penyesuaian protokol kesehatan, termasuk triase, pembatasan kontak, dan penjadwalan layanan. Penelitian di Puskesmas Purwojati menunjukkan bahwa

pelayanan prakonsepsi tetap meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, imunisasi tetanus toksoid, penilaian gizi, suplementasi, serta edukasi kesehatan meskipun berlangsung dalam situasi pandemi (Suciati et al., 2021). Temuan ini memperlihatkan bahwa skrining prakonsepsi tetap harus dipertahankan meskipun terdapat hambatan situasional yang besar.

a. Skrining Laboratorium Komprehensif

TORCH panel (Toxoplasma IgG/IgM, Rubella IgG/IgM, CMV IgG/IgM, HSV-1/2), Hb elektroforesis (thalassemia trait), profil lipid (kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida), HbA1c <6,5% (diabetes), glukosa puasa 70-99 mg/dL, HIV rapid test, VDRL-RPR (sifilis), HBsAg (hepatitis B), golongan darah & rhesus (Masruroh et al., 2024).

b. Pemeriksa USG Fertilitas

Analisis semen pasangan (volume $\geq 1,5$ ml, konsentrasi ≥ 15 juta/ml, motilitas $\geq 40\%$ progresif), evaluasi mukus serviks (Spinnbarkeit > 8 cm hari ovulasi, fern test positif), kurva suhu basal biphasic, uji pascakoitus (≥ 10 sperma/HPF) untuk deteksi infertilitas (Masruroh et al., 2024).

c. Penilaian Psikososial

Kuesioner Tarakan 2025: 41,5% responden tidak bekerja kategori pengetahuan kurang, EPDS adaptasi skor ≥ 10 indikasi depresi, GAD-7 skor ≥ 10 indikasi kecemasan. Screening KDRT dengan HITS atau CTS2 (Laily & Farahdiba, 2025).

d. Imunisasi dan Suplementasi

TT dosis 1 hari 0, TT2 hari 30, booster TT5 tahun berikutnya. Suplementasi TFe 30-60 mg elemental iron/hari jika Hb 10-10,9 g/dL, Fe parenteral + transfusi jika Hb <10 g/dL. Triase COVID-19: suhu $< 37,5^{\circ}\text{C}$, skrining gejala, rapid antigen negatif (Suciati et al., 2021).

3. Strategi Penatalaksanaan Tersier

Strategi penatalaksanaan tersier dalam pelayanan prakonsepsi bertujuan mengurangi dampak komplikasi yang sudah ditemukan melalui pengobatan, rehabilitasi, pemantauan, dan tindak lanjut berkelanjutan (Masruroh et al., 2024). Bila pada tahap sekunder suatu masalah telah terdeteksi, maka tahap tersier memastikan bahwa perempuan tidak dibiarkan tanpa rencana penanganan yang jelas.

Pada kasus anemia sedang atau berat, misalnya, tindak lanjut dapat berupa pemberian suplementasi zat besi, evaluasi pola makan, pemantauan kadar hemoglobin berkala, dan rujukan bila dicurigai penyebab lain seperti thalassemia atau perdarahan kronis. Pada perempuan dengan gangguan

metabolik, obesitas, hipotiroid, atau kecurigaan PCOS, penatalaksanaan tersier mencakup koordinasi dengan dokter, pengaturan terapi, pemantauan laboratorium, dan penundaan kehamilan hingga kondisi lebih stabil (Masruroh et al., 2024). Dalam konteks ini, layanan prakonsepsi bukan hanya skrining, tetapi benar benar menjadi pintu masuk manajemen risiko reproduksi.

Rehabilitasi nutrisi dan dukungan psikososial juga merupakan bagian penting dari strategi tersier. Perempuan yang mengalami kekurangan gizi, citra tubuh negatif, stres berat, atau kecemasan menjelang pernikahan memerlukan pendampingan lebih intensif agar tidak memasuki kehamilan dalam kondisi rapuh. Kunjungan ulang, konseling individu, pelibatan pasangan, dan dukungan keluarga dapat memperbaiki kepatuhan terhadap intervensi serta memperkuat kesiapan menjadi ibu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Masruroh et al., 2024).

Strategi tersier juga menuntut kesinambungan rujukan. Bila fasilitas pelayanan primer tidak mampu menangani seluruh masalah yang ditemukan, maka rujukan ke dokter umum, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, ahli gizi, psikolog, atau laboratorium rujukan harus dilakukan secara terstruktur. Tindak lanjut seperti ini penting agar hasil evaluasi prakonsepsi benar benar berujung pada perbaikan kesehatan, bukan berhenti pada penemuan masalah semata (Masruroh et al., 2024; Nurqalbi et al., 2024).

a. Follow-up Komplikasi Medis

Monitoring bulanan Hb, retikulosit, ferritin serum pada anemia berat. Terapi PCOS: metformin 500 mg 2x/hari + siklus Inositol 2 g/hari. Hipotiroidisme: levothyroxine 25-50 mcg/hari titrasi target TSH 0,5-2,5 mIU/L pra-konsepsi (Masruroh et al., 2024).

b. Rehabilitasi Nutrisi

Kunjungan rumah mingguan monitoring IMT naik 0,5-1 kg/bulan, PMT tinggi protein 500 kcal + 20 g protein/saji 2x/hari. Kelompok dukungan ibu hamil risiko tinggi via WhatsApp mingguan + pertemuan bulanan Puskesmas (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

c. Konseling Psikososial Berkelanjutan

CBT 8 sesi mingguan untuk anxiety pranikah (GAD-7 reduksi $\geq 50\%$). Konseling pasangan Gottman Method 6 sesi resolusi konflik peran gender. Support group 12 calon pengantin PCOS/hipertiroid mingguan 90 menit (Suciati et al., 2021).

d. Integrasi Program Nasional

Sinkronisasi Kartu Keluarga Berencana elektronik dengan data prakonsepsi. Pendaftaran Sisprokonsepsi via aplikasi SatuSehat ID.

Monitoring bulanan via SIK Pranikah terintegrasi P-Care BPJS Kesehatan (Masruroh et al., 2024).

F. Hambatan dalam Evaluasi Kesiapan Prakonsepsi

Evaluasi kesiapan prakonsepsi pada calon pengantin wanita menghadapi berbagai hambatan signifikan yang dapat mengurangi efektivitas program pranikah. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan di kalangan kelompok rentan seperti perempuan yang tidak bekerja. Penelitian di Kota Tarakan tahun 2025 menunjukkan bahwa 41,5 persen responden yang tidak bekerja memiliki pengetahuan kategori kurang tentang persiapan prakonsepsi (Laily & Farahdiba, 2025). Faktor ekonomi ini berkorelasi dengan akses informasi terbatas, ketergantungan sosial, dan prioritas kebutuhan dasar yang sering kali mengalahkan perhatian terhadap kesehatan reproduksi.

Pandemi COVID 19 memperburuk hambatan akses pelayanan prakonsepsi melalui pembatasan mobilitas, penyesuaian jam layanan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap kunjungan ke fasilitas kesehatan. Studi di Puskesmas Purwojati menunjukkan bahwa pelayanan prakonsepsi tetap berlangsung, tetapi harus menyesuaikan dengan protokol triase dan pembatasan pelayanan tertentu (Suciati et al., 2021). Selain itu, hambatan geografis dan biaya transportasi pada wilayah tertentu membuat calon pengantin sulit melakukan kunjungan berulang untuk menyelesaikan seluruh rangkaian skrining dan tindak lanjut.

Faktor budaya dan sosial juga menjadi hambatan penting. Masih ada anggapan bahwa pemeriksaan pranikah tidak terlalu diperlukan, bahkan pada sebagian komunitas pembahasan kesehatan reproduksi masih dianggap sensitif dan memalukan. Buku ajar tahun 2024 menekankan pentingnya konseling psikologis dan pendekatan yang ramah, tidak menghakimi, serta kontekstual secara budaya agar calon pengantin lebih terbuka dalam menerima pelayanan (Masruroh et al., 2024). Ini berarti keberhasilan evaluasi kesiapan prakonsepsi sangat dipengaruhi bukan hanya oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh cara layanan itu diberikan.

Hambatan lain adalah keterbatasan integrasi antarlembaga. Program pranikah sering kali belum sepenuhnya terhubung secara operasional antara KUA, puskesmas, fasilitas laboratorium, dan sistem rujukan. Akibatnya, calon pengantin mungkin menerima informasi dari satu lembaga, tetapi tidak memperoleh alur jelas untuk menyelesaikan pemeriksaan dan tindak lanjut. Dalam konteks pelayanan kebidanan, hambatan sistem ini perlu diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor agar pemeriksaan prakonsepsi tidak berhenti pada edukasi semata, melainkan

berlanjut pada tindakan konkret (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Nurqalbi et al., 2024).

G. Implikasi bagi praktik kebidanan

Bagi praktik kebidanan, evaluasi kesiapan perempuan dalam masa prakonsepsi menegaskan bahwa pelayanan bidan tidak boleh dimulai hanya ketika perempuan sudah hamil. Bidan perlu hadir pada fase pranikah sebagai pendidik, penyaring risiko, konselor, dan penghubung rujukan. Hal ini memperluas peran bidan dari sekadar penyedia asuhan kehamilan menjadi tenaga kesehatan reproduksi yang bekerja pada spektrum promotif, preventif, kuratif awal, dan rehabilitatif terbatas (Masruroh et al., 2024) .

Implikasi praktis lainnya adalah perlunya standar asesmen yang konsisten. Fasilitas kesehatan primer dapat menggunakan format penilaian yang sederhana tetapi lengkap, mencakup aspek biologis, psikologis, perilaku, dan sosial. Dengan instrumen yang seragam, mutu pelayanan menjadi lebih terjaga, data lebih mudah dibandingkan, dan tindak lanjut lebih terarah. Selain itu, dokumentasi yang baik juga akan memudahkan koordinasi ketika calon pengantin harus dirujuk ke layanan lanjutan (Nurqalbi et al., 2024) .

Praktik kebidanan juga perlu menyesuaikan metode edukasi dengan karakteristik sasaran. Pada kelompok muda, penggunaan media digital, infografis, video edukasi, dan kelas daring dapat menjadi strategi yang efektif. Pada kelompok dengan hambatan literasi, bidan perlu menggunakan bahasa yang sederhana, contoh konkret, serta pendekatan interpersonal yang lebih intensif. Dengan demikian, praktik kebidanan yang baik dalam konteks prakonsepsi adalah praktik yang ilmiah, komunikatif, dan peka terhadap konteks sosial budaya sasaran (Jurnal Pemberdayaan Umat, 2026; Laily & Farahdiba, 2025) .

H. Simpulan

Evaluasi kesiapan perempuan prakonsepsi pada calon pengantin merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan skrining biomedis, penilaian psikososial, dan intervensi bertingkat untuk mencegah risiko kehamilan tinggi dan stunting generasi berikutnya (Masruroh et al., 2024) . Pendekatan ini penting karena kualitas kehamilan tidak ditentukan hanya ketika konsepsi telah terjadi, tetapi dibangun sejak sebelum perempuan memasuki masa reproduksi yang aktif dan terencana.

Melalui pemeriksaan pranikah yang komprehensif, tenaga kesehatan dapat mendeteksi anemia, gangguan gizi, infeksi, faktor metabolik, masalah fertilitas, serta hambatan psikososial secara lebih dini. KIE yang kuat, skrining yang terarah,

dan tindak lanjut yang berkesinambungan memungkinkan perempuan memasuki kehamilan dalam keadaan yang lebih siap, sehingga risiko komplikasi maternal dan neonatal dapat ditekan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; Masruroh et al., 2024) .

Meskipun masih terdapat hambatan berupa pengetahuan yang rendah, keterbatasan akses, pengaruh pandemi, dan kendala sosial budaya, pelayanan prakonsepsi tetap dapat dioptimalkan melalui konseling yang ramah, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan peran bidan di layanan primer (Laily & Farahdiba, 2025; Suciati et al., 2021) . Oleh karena itu, integrasi materi buku ajar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi ke dalam program pelayanan pranikah menjadi langkah strategis untuk memperkuat mutu persiapan kehamilan dan mendukung penciptaan generasi yang lebih sehat.

Referensi

- Jurnal Pemberdayaan Umat. (2026). Optimalisasi kesehatan calon pengantin melalui webinar prakonsepsi. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 5(1), 45-56.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nonkomunikabel. <https://stunting.go.id/buku-saku-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022/>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Cek kesehatan pra-nikah untuk kebaikan bersama. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2184/cek-kesehatan-pra-nikah-untuk-kebaikan-bersama.
- Kitamenulis. (2023, May 15). Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. *Kitamenulis*. <https://kitamenulis.id/2023/05/15/asuhan-kebidanan-pranikah-dan-prakonsepsi/>.
- Laily, N., & Farahdiba, N. (2025). Pengetahuan calon pengantin wanita tentang persiapan prakonsepsi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muslim Indonesia*, 7(2), 75-80. <https://doi.org/10.17977/um062v7i22025p75-80>
- Masruroh, F., Aprianti, R., Mufti, I. R., & Rismawati. (2024). *Asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi*. Kaizen Media Publishing.
- Nurqalbi, S., et al. (2024). *Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi*. Politeknik Kesehatan Deli Husada. <https://fkeb.delihusada.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/FullBook-Asuhan-Kebidanan-Pranikah-dan-Prakonsepsi.pdf>.
- Nahira, S. S. T., B. D. N., M. K., & Rismawati, S. S. T., M. K. (2024). *Asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi*. Penerbit Bildung. <https://penerbitbildung.com/product/asuhan-kebidanan-pranikah-dan-prakonsepsi>

[prakonsepsi-2/](#).

Penerbit Akademik. (2023). *Buku ajar asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi S1*. Penerbit Akademik. <https://penerbitakademik.co.id>.

Suciati, N., Nurhayati, S., & Fitriani, R. (2021). Analisis pelayanan prakonsepsi pada calon pengantin era COVID-19 di Puskesmas Purwojati. *Jurnal Kebidanan dan Informatika STIKES Muslim*, 2(2), 45-56. <https://jurnal.stikesmus.ac.id/index.php/JKebIn/article/view/498>

Glosarium

BMI (Body Mass Index): Indeks massa tubuh, rumus = berat badan (kg) / tinggi badan (m)².

Target wanita Asia pra-konsepsi: 18,5-22,9 kg/m² (Masruroh et al., 2024).

CBT (Cognitive Behavioral Therapy): Terapi perilaku kognitif, 8 sesi mingguan mengurangi kecemasan pranikah dengan restrukturisasi pikiran negatif (Suciati et al., 2021).

EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale): Skala depresi adaptasi pra-konsepsi, skor ≥ 10 indikasi depresi memerlukan intervensi (Laily & Farahdiba, 2025).

Fertile Window: Jendela masa subur hari 10-17 siklus 28 hari (± 2 hari), ovulasi hari 14 (Masruroh et al., 2024).

GAD-7: Generalized Anxiety Disorder 7-item, skor ≥ 10 kecemasan sedang-berat pra-konsepsi (Masruroh et al., 2024).

HITS: Hurt, Insult, Threaten, Scream, screening kekerasan dalam rumah tangga, skor ≥ 11 risiko tinggi (Laily & Farahdiba, 2025).

KIE: Komunikasi, Informasi, Edukasi, metode audiovisual + leaflet 60 menit pra-nikah wajib KUA (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

MKJP: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, implan, suntik 3 bulan), efektivitas $> 99\%$ pra-konsepsi (Masruroh et al., 2024).

MMR: Vaksin Measles-Mumps-Rubella, dosis 1 minimal 28 hari pra-konsepsi cegah SRC (Masruroh et al., 2024).

PMT: Pemberian Makanan Tambahan, 500 kkal + 20 g protein/saji 2x/hari rehabilitasi nutrisi tersier (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

SatuSehat ID: Platform digital nasional registrasi prakonsepsi sinkron Kartu KB elektronik (Masruroh et al., 2024).

PROFIL PENULIS



Marchatus Soleha, S.ST., M.Kes. Lahir di Musi Banyuasin Sumatra Selatan, 14 Agustus 1991. Penulis memulai Pendidikan Diploma III (DIII) Kebidanan di Akademi Kebidanan Abdurahman Palembang, lulus tahun 2012, pada tahun 2013 penulis melanjutkan Pendidikan Diploma IV jurusan Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta lulus tahun 2014. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta. Dengan konsentrasi pengajaran Reproduksi, lulus pada tahun

2017. Penulis memiliki kesibukan lain sebagai Dosen Kebidanan di STIKES Adurahman Palembang, mulai bergabung di STIKES Abdurahman Pada tahun 2017 s/d sekarang. Untuk mewujudkan dosen yang profesional penulis mengikuti berbagai pelatihan dan melakukan Tridarma Perguruan Tinggi, Penulis aktif melakukan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, beberapa karya ilmiah telah penulis hasilkan dan dipublikasikan dalam beberapa jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi.

Korespondensi bisa melalui email penulis: marchatussoleha14@gmail.com

Motto: "Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis."

PROFIL PENULIS



Bd. St. Hasriani, S.Tr.Keb., M.Keb. lahir di Belawae pada 17 Mei 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan magister (S2) pada Program Studi Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2020. Karier profesionalnya dimulai pada tahun 2014 sebagai dosen tetap di Program Studi Kebidanan ITKES Muhammadiyah Sidrap. Pada periode 2020–2024, penulis dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan, dan saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap.

Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karya ilmiahnya berfokus pada bayi, balita, dan anak prasekolah, pranikah dan prakonsepsi, serta isu-isu dalam kebidanan. Selain itu, penulis juga berperan sebagai penulis dan kolaborator dalam berbagai buku ajar kebidanan, di antaranya *Asuhan Tumbuh Kembang pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah*, *Psikologi dalam Kebidanan*. Penulis turut menghasilkan berbagai buku ajar terkait kebidanan dan kesehatan ibu dan anak yang digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sthasrianistkm@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Wita Solama, SST., M.Kes. lahir di Kota Palembang pada tanggal 24 Desember 1984. Ia Lulus pada tahun 2016 hingga mendapat gelar Magister Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang jurusan Kesehatan Reproduksi. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap tersertifikasi pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi dalam Islam, Psikologi Ilmu Kebidanan, Komunikasi dan Konseling Ilmu Kebidanan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Dasar Kesehatan Reproduksi, Askeb Pranikah Pra Konsepsi, Askeb. Nifas dan Menyusui di Universitas Aisyiyah Palembang

Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian masyarakat dan sebagai penulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi D3 Kebidanan STIKes Aisyiyah Palembang Tahun 2017-2019, menjabat sebagai Ketua Prodi D3 Kebidanan STIKes Aisyiyah Palembang Tahun 2020-2022, staff Lembaga Penjaminan Mutu Internal Tahun 2022-2024 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas 'Aisyiyah Palembang Tahun 2024-2028, serta menjadi editor jurnal penelitian Babul Ilmi Universitas 'Aisyiyah Palembang dan Reviewer Jurnal Pengabdian Masyarakat Dedikasi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Peraih penelitian Fundamental Reguler yang berhasil didanai oleh Ristekdikti tahun 2026 yang berjudul: Model Kesiapan Prakonsepsi Berbasis Biopsikososial pada Remaja Putri sebagai Upaya Pencegahan Stunting dan peraih hibah Pengabdian Masyarakat dari Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Tahun 2024, ia pun terlibat aktif dalam mengisi materi dengan tema Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah-sekolah Aisyiyah dan Muhammadiyah Kota Palembang. Korespondensi melalui: witasolama19@gmail.com

Motto: "Long Life Education"

PROFIL PENULIS



Bdn. Zulyana, SST., M.Keb. Lahir di Sungai Pakning, 12 Agustus 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Kebidanan, di Sekolah Tinggi Al-Insyirah Pekanbaru tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi S2 Ilmu Kebidanan pada Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 selesai tamat dari D3 Kebidanan menjadi dosen di Akademi Kebidanan Salma. Saat ini penulis bekerja menjadi dosen tetap di Universitas Riau Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan, Asuhan Neonatus, Bayi dan Balita, dan Pengantar Asuhan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ulli_uul@yahoo.co.id

Motto: *"If we never try, we will never know"*



Heni Angraini, S.Tr.Keb., M.Keb, lahir di Bengkulu, 27 Agustus 1997. Menyelesaikan Pendidikan tinggi; D4 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah, Yogyakarta (2019); Pendidikan Magister (S-2) pada Program Studi Ilmu Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah, Yogyakarta (2021). Saat ini menjadi Dosen kebidanan di STIKES Tri Mandiri Sakti, Bengkulu. Penulis telah menulis beberapa artikel, baik yang diterbitkan pada jurnal nasional-internasional, maupun dalam buku referensi dan *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email : angrainiheni29@gmail.com atau HP/WA : 0881 8785 604.

Motto: *"Bahagia dimulai dari rasa syukur"*

PROFIL PENULIS



Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb Lahir di Padang, 13 Desember 1989. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan dimulai sejak kecil karena berkeinginan menjadi tenaga kesehatan mengikuti jejak orang tua. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Padang Program Studi Kebidanan Bukittinggi tahun 2008 dan berhasil lulus tahun 2010. Penulis melanjutkan kuliah di STIKes Prima Nusantara dan berhasil menyelesaikan studi Program Studi Diploma Bidan Pendidik tahun 2013. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 Ilmu Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.

Penulis memiliki kepakaran dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Asuhan Pelayanan Kebidanan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis pernah menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, STIKes Payung Negeri Pekanbaru dan Universitas Batam. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Email Penulis: yohandaeki411@gmail.com

Motto: "Perempuan yang bertumbuh bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk banyak kehidupan."

PROFIL PENULIS



Rikhly Faradisy Mursyida, S.ST., M.Kes., penulis yang akrab di panggil Desy ini lahir di Sampang, 22 Maret 1987. Penulis memulai pendidikan kesehatannya di D-III Kebidanan di STIKES Insan Se-Agung Bangkalan lulus tahun 2009 dan tahun melanjutkan D-IV Kebidanan Bidan Pendidik di STIKES Insan Unggul Surabaya lulus tahun 2010 dan telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP) tahun 2012 dan tahun 2024 melanjutkan studi S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Sejak lulus D-III Kebidanan telah aktif bekerja sebagai PJ.Laboratorium di Akademi Kebidanan Graha Husada Sampang tahun 2009-2010, sebagai dosen tetap dan menjabat Direktur tahun 2013-2017, mulai tahun 2018-2022 sebagai Ketua Program Studi (Kaprod) Kebidanan AKBID Graha Husada Sampang dan Tahun 2022-2027 menjabat sebagai Ketua STIKES Sukma Wijaya Sampang. Selain itu penulis juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelayanan kesehatan masyarakat, posyandu, penyuluhan, pelatihan, dsb. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rikhlydesy87@gmail.com.

Motto: "Man Jadda Wajadda"

Sinopsis

Bunga Rampai "Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi pada Calon Pengantin" membahas secara komprehensif pentingnya persiapan kesehatan sebelum memasuki pernikahan dan kehamilan. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penilaian risiko, intervensi, pre-marital screening, hak reproduksi dan seksual, serta persiapan kehamilan bagi calon pengantin. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman bahwa masa pranikah merupakan tahap penting dalam mempersiapkan pasangan untuk mewujudkan kehamilan yang sehat dan keluarga yang berkualitas.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan, termasuk tujuan, manfaat, komponen pemeriksaan kesehatan, serta skrining risiko kesehatan yang perlu dilakukan sebelum menikah. Materi juga membahas status gizi, anemia, kesiapan fisik sebelum kehamilan, dan peran bidan dalam asuhan prakonsepsi. Selain itu, buku ini menyajikan pembahasan mengenai imunisasi, skrining penyakit, faktor risiko reproduksi, edukasi kesehatan reproduksi, dan perencanaan kehamilan sehat sebagai bagian penting dalam upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan calon bayi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki pernikahan, meliputi kesiapan mental, sosial, budaya, peran keluarga, konseling pranikah, serta hubungan kesiapan pernikahan dengan kesehatan mental dan kehidupan keluarga. Buku ini juga mengulas evaluasi kesiapan perempuan dalam masa prakonsepsi, strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier, serta hambatan dalam evaluasi kesiapan prakonsepsi. Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang ingin memahami pentingnya kesehatan pranikah dan prakonsepsi dalam mendukung terwujudnya keluarga sehat dan generasi yang berkualitas.

Bunga Rampai “Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi pada Calon Pengantin” membahas secara komprehensif pentingnya persiapan kesehatan sebelum memasuki pernikahan dan kehamilan. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, penilaian risiko, intervensi, pre-marital screening, hak reproduksi dan seksual, serta persiapan kehamilan bagi calon pengantin. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman bahwa masa pranikah merupakan tahap penting dalam mempersiapkan pasangan untuk mewujudkan kehamilan yang sehat dan keluarga yang berkualitas.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pemeriksaan kesehatan calon pengantin perempuan, termasuk tujuan, manfaat, komponen pemeriksaan kesehatan, serta skrining risiko kesehatan yang perlu dilakukan sebelum menikah. Materi juga membahas status gizi, anemia, kesiapan fisik sebelum kehamilan, dan peran bidan dalam asuhan prakonsepsi. Selain itu, buku ini menyajikan pembahasan mengenai imunisasi, skrining penyakit, faktor risiko reproduksi, edukasi kesehatan reproduksi, dan perencanaan kehamilan sehat sebagai bagian penting dalam upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan calon bayi.

Pada bagian akhir, buku ini membahas kesiapan psikologis dan sosial dalam memasuki pernikahan, meliputi kesiapan mental, sosial, budaya, peran keluarga, konseling pranikah, serta hubungan kesiapan pernikahan dengan kesehatan mental dan kehidupan keluarga. Buku ini juga mengulas evaluasi kesiapan perempuan dalam masa prakonsepsi, strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier, serta hambatan dalam evaluasi kesiapan prakonsepsi. Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang ingin memahami pentingnya kesehatan pranikah dan prakonsepsi dalam mendukung terwujudnya keluarga sehat dan generasi yang berkualitas.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-16-9 (PDF)

